

2026 年 最值得关注的 药物预测

不负久候，超越期待。

技术进步与临床突破交织，共塑全球医疗健康新格局

2026 年，制药行业正站在卓越创新与复杂挑战并存的关键时期，其发展路径将带来深远影响。本年度《最值得关注的药物预测》报告遴选出 11 个药物，这些药物不仅有望重塑治疗范式、改善患者预后，而且其中多数具备冲击重磅炸弹级市场地位的潜力。这些药物所折射的行业动向，既彰显了制药行业在多个前沿治疗领域的开拓进取之势，也证明了行业在日趋严峻的商业与监管环境中稳健突围的实力。面对持续加剧的行业复杂性，科睿唯安依托整合式数据平台及人工智能 (AI) 驱动解决方案，为生命科学企业提供贯穿药物研发与商业化全生命周期的情报支持、分析能力及战略洞见，助力企业加速创新进程、抢占决策先机。

代谢治疗革命站上舞台中心

肥胖症与代谢疾病治疗市场延续爆发式增长态势，预计到 2035 年，全球肥胖症药物市场规模将攀升至 1,500 亿美元。与此同时，由胰高血糖素样肽 -1 (GLP-1) 受体激动剂 (RA) 引领的治疗革命，已迈入成熟化与多元化并行的新阶段。

礼来的 orforglipron 和 retatrutide 是代谢领域新一代疗法的典型代表：orforglipron 凭借口服剂型，可显著提升患者治疗依

从性；retatrutide 则依托三重激素机制实现更优减重效果，治疗应用已突破代谢领域边界，延伸至脑健康、肾脏疾病等新方向。当前，代谢治疗领域仍面临多重关键挑战，包括医保定价谈判压力、支付方覆盖限制、供应链短缺及减重过程中的肌肉流失等核心痛点；与此同时，靶向胰淀素 (amylin)、大麻素受体、激活素 (activin) 通路的新型作用机制，正为这些难题提供破局方案。

展望 2026 年，制药企业高管需清醒认识到，代谢领域的创新绝不能局限于对现有 GLP-1 疗法机制的复刻。市场迫切需要真正的差异化方案，核心在于解决耐受性痛点、拓展口服给药途径、制定可维持目标体重的联合治疗策略，并提供与临床试验数据相匹配的真实世界疗效证据。

科睿唯安拥有覆盖临床试验数据、竞争情报和商业预测的全维度分析能力，可帮助企业精准识别市场空白机遇，将企业资产与新兴竞争对手进行对标分析，进而制定循证化产品上市策略。借助科睿唯安人工智能驱动的行业格局分析服务，客户可快速研判在不同治疗机制、给药方式和患者细分策略下的竞争态势，从而为产品组合决策及合作伙伴评估提供参考依据。

罕见病药物商业化呼唤新模式

目前全球已确诊的罕见病超 7,000 种，但获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 或欧洲药品管理局 (EMA) 批准的治疗方案仅约 500 种，罕见病治疗缺口依然显著。不过，入选本年度榜单的药物（如用于慢性淋巴细胞白血病 / 小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL) 的 BGB-16673 以及其他候选药物）表明，罕见病研发已突破肿瘤领域的传统边界，拓展至神经系统、精神类、血液系统等多个领域，赛道更趋多元。

罕见病药物的商业化逻辑，与传统制药的规模化模式存在本质区别。由于患者群体极其有限（部分疾病患病率低至 200 万分之一），企业需将“患者优先”理念深度植入研发与商业化全流程，高度聚焦患者早筛识别与早期用药可及性，并通过疾病认知普及、患者组织深度合作、关键意见领袖 (KOL) 联动等多元举措，构建扎实的市场培育体系。

针对罕见病领域的特殊性，全球监管机构正同步优化审批与激励路径，欧盟出台新的卫生技术评估 (HTA) 法规，实现欧洲多国临床评估的协同推进，提升审批效率；美国近期颁布相关法案，延长孤儿药专利保护期限，强化研发创新激励。

科睿唯安的全球药政法规情报解决方案，借助新增的 Cortellis 法规助手等 AI 工具，彻底革新了企业应对复杂监管路径的模式，即无需人工逐份梳理数百份监管文件，AI 助手可自动检索相关文档、整合多地区监管要求、生成可落地的建议，大幅缩短监管策略的制定周期。更关键的是，该 AI 工具具备高度透明性，支持溯源原始监管文档，既让企业能够信任 AI 输出的指导建议，又可满足合规层面的完整可追溯性要求，兼顾效率与合规。

肿瘤与免疫精准治疗推动靶向疗法迭代升级

肿瘤与免疫领域精准治疗的发展，同时也伴随着疾病机制靶向研究的精细化演进。其中，乳腺癌药物 Exdensur (depemokimab)、嗜酸性粒细胞疾病药物 (depemokimab)、血液恶性肿瘤药物 mezigdomide 以及肾病药 VOYXACT® (sibeprenlimab)，共同构建起新一代精准疗法矩阵。尤其值得关注的是，“不可成药”靶点难题的靶向蛋白降解剂问世，标志着难治性疾病的治疗模式迎来颠覆性转变。

与此同时，icotrokinra 的临床数据表明，口服小分子药物可在特应性皮炎、银屑病等炎症性疾病领域挑战注射类生物制剂，有望提升患者用药可及性并重塑临床治疗指南。而多发性硬化

症药物 tolebrutinib、库欣综合征药物 relacorilant 的研发进展，更显示出行业持续向神经、内分泌等存在巨大未满足需求的领域拓展的趋势。

在肿瘤与免疫这一竞争白热化的治疗赛道中，企业若想稳健发展，必须具备专业的竞争情报分析与管线分析能力。科睿唯安的综合数据库覆盖 160 余个疾病、药物及市场领域，贯穿产品研发与商业化全生命周期，可支撑企业开展全景格局评估、筛选最优联合治疗策略、精准预判市场动态。依托 AI 驱动的竞争情报系统，企业可快速输出市场格局分析成果：不仅能系统梳理竞争风险、深度挖掘合作机遇，还能获得针对性战略建议。该工具将原本需数周的人工分析决策流程，升级为仅需数小时即可输出核心洞见的智能分析模式，大幅提升决策效率。

超越分子层面的突破性给药技术

INLEXZO™ 经膀胱内给药后可持续留存 3 周，这一技术应用揭示了 2026 年制药行业核心产业趋势的缩影，即疗法创新已突破分子机制的单一维度，突破性给药系统正成为提升患者依从性、拓展用药可及性、改善患者生活质量的关键抓手。无论是传统注射类药物的口服剂型改造，还是缓释技术升级，行业均需

将以患者为导向的给药途径创新提升至战略核心地位。

科睿唯安的专利情报与制剂分析服务，可助力企业精准挖掘给药技术的创新机遇、系统评估知识产权布局格局、并将创新的给药途径与竞品资产进行对标分析，为企业制定制剂研发差异化战略提供关键支撑。

中国市场迎来关键拐点

中国大陆已成为全球制药行业的核心战略高地，正实现从“全球医药制造中心”向“本土创新策源地”的关键转型。2026 年中国市场最具潜力的 6 款药物中，4 款源自本土创新企业，包括安得卫（贝莫苏单抗，正大天晴 / 中国生物）、HRS-9531（恒瑞医药）、信超妥（信立泰）和依达方（依沃西单抗，康方生物），部分产品已具备与跨国药企龙头产品同台竞技的实力。市场需求层面，中国大陆超重 / 肥胖人群已达 6.9 亿，癌症发病率持续攀升，共同催生了规模庞大的治疗需求。与此同时，企业也需配套制定精细化的市场策略，具体包括：应对国家医保药品目录（NRDL）准入谈判、制定具备差异化竞争力的定价方案、与本土创新企业搭建优势互补的合作联盟等。

科睿唯安的全球市场情报及中国专属分析模块，可提供 NRDL 动态、本土竞品管线、本土企业合作机遇等核心建议，助力外企制定适配中国市场的精准策略，同时帮助本土企业挖掘全球市场机会。依托 MCP（模型上下文协议）等新兴标准，客户可将科睿唯安的中国市场情报数据接入企业内部 AI 系统，实现企业自有数据与外部情报的融合分析。

应对监管与政治的多重阻力

2026 年制药行业将面临前所未有的监管不确定性，其中美国市场的挑战尤为突出。特朗普政府任命的 FDA 领导层频繁调整监管政策、《通胀削减法案》(IRA) 持续释放定价压力、全球各市场卫生技术评估 (HTA) 要求不断变化，共同构成了复杂的战略挑战。在此背景下，企业管理者需在“加速研发周期”与“生成严谨临床证据”之间实现平衡，既要预判不同地区的差异化监管要求并提前布局适配方案，又要为产品的全球上市策略预留充足弹性，以应对动态变化的监管环境。

科睿唯安的监管情报解决方案可实时监控监管动态、提供审批路径的先例分析、并对不同监管部门的策略进行对比评估。最近在 Cortellis 全球药政法规情报数据库上线的“法规助手” (Regulatory Assistant)，融合了专业领域知识与全球精选内容，借助 AI 能力让关键信息更易获取、解读与应用，助力团队提升工作效率。该 AI 工具支持原始文档溯源，既化解了制药行业对 AI 可靠性的顾虑，又满足了合规审计要求。

科睿唯安如何利用人工智能技术赋能客户创新

科睿唯安不仅通过旗下各个平台输出深度洞察与落地建议，其 AI 战略更支持客户在自有分析环境及 AI 系统中，调用其核心数据资产。其核心差异化优势在于深厚的生命科学领域专业积淀，覆盖“从研发到商业化”全流程的精选内容，以及专为医疗健康应用场景定制的高级提示词工程技术。

AI 智能体 (AI Agent) 是科睿唯安 AI 战略的核心创新方向。相较于传统简单问答系统，AI 智能体具备明确目标导向，可调用多元工具与数据库，自主检索整合信息，精准匹配用户核心需求。无论是分析临床试验审批动态、评估赛道竞争格局，还是整合多地区监管要求，AI 智能体都能大幅缩短“问题提出 - 洞察输出”的转化周期，提升决策效率。

依托 MCP 这一新兴技术标准，客户可将科睿唯安数据深度整合至内部 AI 生态，构建“自有数据 + 科睿唯安精选情报”的融合型 AI 分析系统，显著提升分析效能。客户既可以通过自然语言接口调取科睿唯安信息，整合多个外部数据库开展对标分析，也可根据自身战略需求构建定制化的 AI 智能体。

对于订阅多款科睿唯安产品的客户，AI 智能体可实现跨平台的一体化操作体验，无需手动切换系统，即可同步调用法规情报、竞争分析、临床数据及商业预测数据，提供全方位的综合观点。这种 AI 技术支持下的融合式方法，彻底改变了企业获取信息的方式，助力其更快、更有把握地制定明智决策。

2026 年核心战略要务

在这一关键年份，制药行业需锚定六大战略核心：

- **突破机制局限，实现多维差异化：**在肥胖、肿瘤等拥挤赛道，竞争优势的核心是证明真实世界疗效、卓越的耐受性、给药便利性及卫生经济学价值，而非仅依赖创新机制。科睿唯安的真实世界证据分析与卫生经济学情报服务，可助力企业制定能契合支付方、监管机构与临床医生的差异化策略。
- **掌握罕见病商业化逻辑：**需构建区别于传统模式的患者导向体系，提前联动利益相关方并打造专业的市场培育能力。科睿唯安在罕见病领域的深厚专业积淀、患者痛点分析及 KOL 观点输出，可支持企业制定适配超罕见病独特生态的全维度上市策略。
- **把握中国市场的双重角色：**中国大陆既是核心商业市场，也是新兴创新源头，需同步布局合作与竞争策略。科睿唯安拥有专门面向中国市场的情报服务和全球竞争分析服务，能够助力企业制定精细化战略，在把握市场机遇的同时，有效应对竞争威胁。

- **布局给药系统创新：**突破性给药系统正成为疗法差异化与市场渗透的关键，其制剂创新战略重要性已比肩靶点选择。科睿唯安的专利分析与制剂情报服务可识别新型给药技术机遇，并对相关知识产权格局进行评估。
- **构建监管复杂性应对能力：**企业成功的关键在于打造组织级能力，以应对全球多地区的差异化监管路径、证据要求与政策动态。科睿唯安的监管情报解决方案融合了人工智能技术，在确保合规性与可追溯性的同时，加速企业监管策略的制定进程。
- **借力 AI 加速决策制定：**创新节奏的加快与竞争强度的提升，要求企业更快做出更为可靠的决策。从监管代理到竞争情报分析，科睿唯安的众多解决方案均融合了人工智能技术，能够将耗时的人工分析转化为快速、来源可验证的洞察观点。企业通过新兴标准将科睿唯安数据整合到内部 AI 系统后，即可构建兼具内部知识优势与全面外部情报的分析能力。

本报告遴选出的 11 个药物，既充分展现了制药行业在多治疗领域的创新实力，也深刻折射出行业正面临的日趋严峻的多维挑战，无论是在商业、监管还

是竞争层面，这些挑战都将成为决定企业 2026 年及未来发展成败的核心关键。科睿唯安整合式情报平台通过融合尖端人工智能技术得到进一步强化，为企业应对这一复杂局面提供了切实所需的分析基础。无论是加速制定监管策略、发掘竞争机遇，还是预测商业趋势、支持以数据驱动的产品组合决策，科睿唯安都能将原始数据转化为战略优势，助力生命科学企业更快速、更确信地将变革性疗法带给患者。



Henry Levy
科睿唯安生命科学与
医疗健康事业部总裁

目录

07	方法学
10	数据来源和编著者
12	减重疗法的创新竞赛
15	Orforglipron 和 Retatrutide
32	填补罕见病治疗缺口
35	Exdensur (depemokimab)
43	Icotrokinra
51	VOYXACT (sibeprenlimab)
58	Tolebrutinib
65	蛋白降解剂重塑肿瘤靶向治疗疆界
68	BGB-16673
76	Mezigdomide
84	构建女性健康研究新范式
86	Gedatolisib
94	INLEXZO (TAR-200)
102	Relacorilant
109	癌症、肥胖症与 2 型糖尿病仍是中国市场关注焦点
116	政治化 FDA 背景下重新思考监管透明度
120	创新疗法塑造 2025 年监管格局
123	制药行业高管需关注的核心战略要务
125	术语缩写
127	参考文献

方法学

科睿唯安《最值得关注的药物预测》收录近期上市及年内有望上市、或突破关键里程碑的药物，这些药物有望在未来五年成为重磅炸弹和 / 或改变治疗模式的药物（重磅炸弹定义为年销售额通常可达 10 亿美元的里程碑）。

为了确定《2026 年最值得关注的药物预测》清单，我们收集了 160 多位科睿唯安分析师的专业意见，涵盖了数百种疾病、药物和市场，同时查询了 10 个贯穿产品研发和商业化生命周期、并利用人工智能技术进行了增强的综合数据库。

而后，科睿唯安专家根据预期获批或上市日期、竞争格局、注册审批状态、临床试验结果、市场动态等因素，对每种药物的具体情况进行了人工评估，并添加了一些新药，虽然这些药物可能达不到重磅炸弹的标准，但有望改变治疗方式。

药物遴选标准

- 选择处于 II 期或 III 期临床试验阶段、处于注册或批准阶段，或已经在 2025 年上市的候选药物作为分析对象，包括有新适应症获批且可能对行业带来重大影响的药物；在 2025 年之前上市的药物不在评选范围内。
- 然后，在数据库中筛选出预计在 2031 年总销售额达到或超过 10 亿美元的候选药物。
- 在此基础上，科睿唯安专家补充了一些近期上市和即将上市的治疗药物，这些药物虽然可能不会在五年内达到“重磅炸弹”地位，但将极大地改变治疗方式。

基于上述方法，我们确定了 11 种 2026 年最值得关注的药物。

利用人工智能对药物遴选结果进行验证

为评估我们遴选的 11 个候选药物的适配性、以及是否符合方法论所设定的遴选标准，我们通过多个 AI 平台对入选药物进行评估，同时就“是否存在其他临床阶段或即将上市的候选化合物需纳入考量”发起问询。各 AI 平台一致认为，本次入选药物整体质量优异、代表性极强，并建议增补 6 款化合物，但经对这 6 款增补药物的深度二次问询，AI 平台最终判定其不符合入选标准，予以排除。



主题归类

筛选流程的最后一步，是结合行业前沿趋势将入选药物进行主题归类，既凸显行业发展动向，也便于读者在报告中快速检索对应内容。

01

减重疗法的创新竞赛

Orforglipron 和 Retatrutide

- 礼来
- 肥胖症和 2 型糖尿病 (T2DM)

02

填补罕见病治疗缺口

Exdensur (depemokimab)

- 葛兰素史克
- 哮喘

Icotrokinra (伊可白滞素)

- 强生
- 斑块状银屑病

VOYXACT (sibeprenlimab)

- 大冢制药
- 免疫球蛋白 A 肾病 (IgAN)

Tolebrutinib

- 赛诺菲
- 多发性硬化症

03

蛋白降解剂重塑肿瘤靶向治疗疆界

BGB-16673

- 百济神州
- 慢性淋巴细胞白血病 / 小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL)

Mezigdomide

- 百时美施贵宝
- 多发性骨髓瘤

04

构建女性健康研究新范式

Gedatolisib

- Celcuity
- 乳腺癌

Relacorilant

- Corcept Therapeutics
- 卵巢癌与皮质醇增多症 (库欣综合征)

INLEXZO (TAR-200)

- 强生
- 膀胱癌

[点击此处预约网络研讨会：《高山景行，长风破浪——2026 年全球和中国最值得关注的药物》](#)

药物概况

本报告中的药物概况来自以下资料：相应药物市场的医学专家访谈；科睿唯安药物报告、疾病概览与预测报告；Cortellis 销售数据（源自 Refinitiv I/B/E/S）；以及包括生物制药公司新闻稿和同行评议出版物在内的其他行业来源。请注意，本报告中的数据由科睿唯安分析师于 2025 年 10 月 31 日生成。

中国大陆最值得关注的药物预测

“中国大陆最值得关注的药物预测”聚焦于近期在中国大陆市场上市、或有望于本年度进入中国大陆市场，且可能产生突破性影响和 / 或改变治疗模式的药物。科睿唯安中国深度分析团队充分利用该团队在这一区域的专业知识以及贯穿研发至商业化生命周期的综合数据库，最终筛选出这份清单。



数据来源和编著者

自 2013 年以来，科睿唯安始终运用全球生命科学领域客户信任的专有技术和工具，编写年度《最值得关注的药物预测》报告。

Cortellis 竞争情报数据库：全面的研发管线与医药竞争情报，为战略及业务拓展团队提供有力支持，助其制定关键产品组合决策。

流行病学情报：对 1,000 多种疾病和手术的发病率和流行率相关文献进行综述，为评估市场规模和了解患者群体提供深入见解。针对 240 多种适应症，提供相应疾病 10 年或 20 年的深度预测，并基于美国医疗索赔数据提供独特洞见。

BioWorld：行业领先的一站式生物医药行业资讯平台，专注于为处于研发阶段的最具创新性的药物和医疗技术提供切实可行的情报。

Cortellis 全球药政法规情报数据库：专题领域的专业知识与兼具广度和深度的洞见相结合，交付关键情报助力团队自信应对全球监管环境、确保合规；现在，该平台通过“法规助手”工具的 AI 功能，进一步实现了能力升级。

Cortellis 临床试验情报数据库：兼具互补性与必要性的竞争情报来源，提供有关临床试验进展、竞争对手策略及试验方案设计优化的相关洞见。

Cortellis 交易情报数据库：将全面的制药行业交易数据与强大的可视化工具相结合，可以快速评估可比交易条款、进行定价基准分析并识别潜在合作伙伴，助您通过谈判达成最优交易。

DRG Fusion 是商用生命科学领域可配置性最强、智能化程度最高、与工作流程衔接最自然的分析平台。依托独有的互联真实世界数据与人工智能驱动的使用体验，Fusion 助力您从任意维度剖析各类疾病，攻克最棘手的商业化难题。

DRG 市场评估基于整合的市场数据、准入数据和真实世界数据，针对特定适应症提供深入洞见，助力企业甄别高潜力机遇、指引战略方向。该评估体系包含以下产品：

- **疾病概览与预测报告：**为超过 85 种适应症提供全面的市场情报，包括当前和新兴疗法、目标患者群体规模及市场前景，以帮助客户发现市场机会并优化长期的疾病策略。
- **市场准入和报销：**从品牌层面分析了支付方政策对医生处方行为的影响，以便客户可以优化其市场准入策略，并确定如何针对特定利益方制定产品最佳定位。
- **中国市场深度报告**提供全方位的市场情报解决方案，其核心内容包括：国际水准的流行病学研究数据、针对中国特色的市场准入与医保报销政策深度解读、现行治疗模式分析、创新药物研发管线的专业评估，以及基于超过 35 个适应症的详实一级与二级研究基础上的药物市场预测，助力识别机遇并优化长期疾病战略。



科睿唯安编著者

Michael Ward

科睿唯安生命科学与医疗健康事业部
全球思想领袖内容负责人

Shambhavi Shukla MTech

DRG 商业解决方案事业部医疗研究和数据主管分析师

Matthew Arnold

生命科学与医疗健康首席分析师

Megha Bharadwaj MTech

DRG 商业解决方案事业部医疗研究和数据分析师

John Crowley PhD

DRG 商业解决方案事业部医疗研究和数据总监

Anna Duran PhD

肿瘤学医疗研究和数据分析师

Graeme Green PhD, MSc

心血管、代谢、肾脏和血液学总监

Julia Morris PhD

肿瘤学医疗研究和数据分析师

Rachel Webster DPhil, MSc, BA (Hons)

肿瘤学医疗研究和数据分析总监

Catherine E. Willoughby PhD

肿瘤学医疗研究和数据分析师

Alice Zeng

亚太区生命科学与医疗健康高级顾问

Sahil Arora MPharm

China In-Depth 医疗研究和数据分析师

Arshiya Bhatt PhD

肿瘤学医疗研究和数据高级分析师

Pankaja Dhekane MPharm

China In-Depth 医疗研究和数据分析师

Preeti Attri PhD

China In-Depth 医疗研究和数据高级分析师

Grant Nix MBA

DRG 商业解决方案事业部医疗研究和数据分析师

Glenda Walker PhD

肿瘤学医疗研究和数据高级分析师

Carles Recasens-Alvarez PhD

DRG 商业解决方案事业部分析师

Karan Verma MSc

China In-Depth 医疗研究和数据副首席分析师

Boya Zhang MPH

China In-Depth 医疗研究和数据分析师

Aayushi Sharma MPharm

DRG 商业解决方案事业部医疗研究和数据助理分析师

01

减重疗法的创新竞赛

超重与肥胖领域已迈入全球性关键转折点：全球超 40% 的成年人及 20% 的青少年受其影响（世界卫生组织，2025 年），预计到 2030 年，成人患病率将突破 50%（世界肥胖联合会，2025 年）。

历经数十年的渐进式探索，胰高血糖素样肽 -1 受体激动剂 (GLP-1RA) 已彻底重塑该领域的治疗格局、商业投资逻辑及关联领域的创新路径。

[点击此处预约网络研讨会：《高山景行，长风破浪——2026 年全球和中国最值得关注的药物》](#)

当前，在 GLP-1RAs 及下一代代谢疗法的需求驱动下，全球肥胖药物市场规模预计到 2035 年将达 1,500 亿美元（摩根士丹利，2025 年）。然而，定价谈判博弈、支付方覆盖范围争议、供应短缺、假药泛滥以及部分药物即将到来的专利到期冲击等多重因素，均制约着市场进一步扩容。美国市场数据显示，2019 年至 2024 年间，针对超重或肥胖成年患者的 GLP-1RAs 处方量累计增长 586.7%（FairHealth，2025 年）。随着 GLP-1RAs 的应用场景向脑健康、肾脏疾病等关联领域延伸，市场竞争日趋激烈的同时，行业对下一代疗法的需求也水涨船高。

与此同时，GLP-1 领域研发管线迭代加速，在研药物已覆盖双靶点及三靶点激素受体激动剂（见表 1）。口服给药与给药频次优化，正成为核心差异化研发方向，通过提升患者用药依从性，进一步改善真实世界治疗结局。例如，行业领先的口服 GLP-1RA 候选药物 orforglipron（礼来）的 II 期临床数据显示，其不仅实现了具有临床意义且统计学显著的减重效果，副作用还与注射剂型相当（Wharton 等，2023 年）。

表 1：用于肥胖症治疗的在研 GLP-1 RA 示例，单独使用或与其他受体激动剂联合使用（数据截至 2025 年 9 月 15 日）

药物	公司	类型	给药途径	研发阶段
CagriSema	• 诺和诺德	GLP-1/ 胰淀素双重受体激动剂	注射	III 期
Ecnoglutide (XW003)	• 先为达生物	GLP-1 受体激动剂	注射	III 期
Noiiglutide (HS-20004)	• 恒瑞医药	GLP-1 受体激动剂	注射	III 期
Orforglipron	• 礼来 • 中外制药	GLP-1 受体激动剂	口服	III 期
Retatrutide	• 礼来	葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP)/GLP-1/ 胰高血糖素三重受体激动剂	注射	III 期
Survodutide (BI-456906)	• Zealand Pharma • 勃林格殷格翰	GLP-1/ 胰高血糖素双重受体激动剂	注射	III 期
VK-2735	• Viking Therapeutics	GLP-1/GIP 双重受体激动剂	注射和口服	III 期
Aleniglipron (GSBR-1290)	• Structure Therapeutics	GLP-1 受体激动剂	口服	II 期
AZD5004	• 阿斯利康	GLP-1 受体激动剂	口服	II 期
Dapiglutide	• Zealand Pharma	GLP-1/GLP-2 双重受体激动剂	注射	II 期
Ecnoglutide (XW004)	• 先为达生物	GLP-1 受体激动剂	口服	II 期
MariTide (maridebart cafraglutide/AMG-133)	• 安进	GLP-1/GIP 双重受体激动剂	注射	II 期
Pemvidutide (ALT-801)	• Altimune	GLP-1/ 胰高血糖素双重受体激动剂	注射	II 期
Amycretin	• 诺和诺德	GLP-1/ 胰淀素双重受体激动剂	注射和口服	I 期
AZD-9550	• 阿斯利康	GLP-1 受体激动剂	注射	I 期
SCO-094	• SCOHIA PHARMA Inc • 杭州中美华东制药有限公司	GLP-1/GIP 双重受体激动剂	注射	I 期

数据来源：BioWorld；Carey（2023）；各公司官网

尽管口服 GLP-1 制剂有望改善长期治疗结局，但当前 GLP-1RAs 的真实世界减重效果往往不及临床试验水平，这可能与患者因耐受性问题提前停药或降低剂量相关（Gasoyan 等，2025 年），而停药通常会导致体重大幅反弹（Aronne 等，2024 年；Gasoyan 等，2025 年）。

更值得关注的是，胰腺炎等严重副作用（FairHealth，2025 年）及其他器官损伤，已导致部分研发项目终止。例如，辉瑞于 2025 年年中宣布终止口服 GLP-1RA 达努格列汀（danuglipron）的研发，核心原因是其 III 期临床试验中出现 1 例疑似药物诱导的肝损伤病例（Boggs，2025a）。

胰淀素类药物成为研发热点，有望具备比 GLP-1RAs 更优的耐受性，多家企业已布局相关管线，包括：

- 阿斯利康：AZD6234（II 期临床试验阶段）
- Metsera：MET-233i（I 期临床试验阶段）
- 诺和诺德：Amylin 355 及 GLP-1/胰淀素双重受体激动剂 Amycretin（均处于 I 期临床试验阶段）
- Structure Therapeutics 公司：胰淀素与降钙素双重受体激动剂（临床前研究阶段，正推进新药临床试验申请（IND）相关工作）

艾伯维将胰淀素靶向疗法作为进军肥胖市场的核心切入点，于 2025 年初与 Gubra A/S 达成潜在价值 18.75 亿美元的研发及商业化合作，聚焦长效胰淀素

类似物 Gubamy（GUB-014295），该药物目前处于 I 期临床研发阶段（Moran，2025 年）。此外，Gubra A/S 还在探索尿皮质素 -2（urocortin-2）作为肥胖治疗靶点，该靶点兼具潜在减重疗效与良好的心脏安全性。

除胰淀素外，大麻素受体 1（CB1）受体也是重点布局方向，其参与食欲调节、脂肪储存及代谢调控，也是诺和诺德肥胖研发管线的重点布局方向。Monlunabant 是诺和诺德于 2023 年通过收购 Inversago Pharmaceuticals 获得的 CB1 受体抑制剂，作用靶点位于中枢神经系统（CNS），其临床试验已展现出统计学显著的减重效果，但有报告指出其存在轻度至中度胃肠道及神经精神系统副作用（Osborne，2024b）。为规避潜在神经精神风险，Sky Bioscience 与 Corbus Pharmaceuticals 分别开发了外周靶向 CB1 受体的候选药物 nimacimab 和 CRB-913。

GLP-1RAs 的其他局限性也被逐步攻克，例如肌肉量流失问题。数据显示，使用 GLP-1RAs 减重时，肌肉量流失可能占总减重量的 15%-40%（Memel 等，2025）。Bimagrumab（礼来）一款靶向激活素 IIA/IIB 受体的单克隆抗体，旨在维持肌肉量并促进肌肉生长。在一项与司美格鲁肽联合使用的 IIb 期临床试验中，92.8% 的减重量来自脂肪组织，而司美格鲁肽单药组这一比例仅为 71.8%（美国糖尿病协会，2025）。该药物最初由 MorphoSys 发现，诺华曾针对罕见自身免疫性肌病（肌炎）推进其 II/III 期临床试验，但未达预期，后授权给 Versanis Bio 用于体重管理。2023 年 8 月，礼来以最高 19 亿美元的价格收购 Versanis Bio，获得该药物全部权益。

Orforglipron 和 Retatrutide

肥胖症和 T2DM

减重疗法的创新竞赛

如需获取最新动态，请访问 [orforglipron](#) 与 [retatrutide](#) 页面。

生产商 - 礼来 类型 Orforglipron - 小分子 GLP-1 RA Retatrutide - GLP-1/GIP/ 胰高血糖素三重受体激动剂 用法 Orforglipron - 每日一次口服给药，用于超重 / 肥胖和 2 型糖尿病管理 - 同时正在评估其用于肥胖人群中的阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 和高血压适应症 Retatrutide - 每周一次皮下注射给药，用于超重 / 肥胖和 2 型糖尿病管理 - 同时正在评估其用于以下适应症：肥胖症合并骨关节炎 (OA)、慢性腰痛、心血管疾病 (CVD) 预防、慢性肾病 (CKD)、阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA)，以及非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD)/ 代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH)	影响 约 2.5 亿 2025 年 G7 市场 20 岁及以上成人肥胖症及符合药物治疗条件的超重患者约 2.5 亿例 约 8,000 万 2025 年 G7 市场 20 岁及以上成人 2 型糖尿病患者约 8,000 万例	审批状态 Orforglipron 2025 年 11 月：局长国家优先审评券 (CNPV)：美国 FDA（肥胖症及相关健康问题） Retatrutide 截至目前尚无监管申报活动 实际和预期上市时间 Orforglipron 2026 年：美国（T2DM） 2027 年：欧盟（肥胖症和 T2DM）、日本（肥胖症和 T2DM）、英国（肥胖症和 T2DM）、美国（肥胖症） Retatrutide 2028 年：欧盟（肥胖症）、日本（T2DM）、英国（肥胖症）、美国（肥胖症和 T2DM） 2029 年：欧盟（T2DM）、英国（T2DM） 预计专利到期时间 Orforglipron - 专利预计从 2038 年开始陆续到期 Retatrutide - 专利预计从 2038 年开始陆续到期
---	---	--

尽管 GLP-1RA 已彻底重塑超重 / 肥胖及 2 型糖尿病 (T2DM) 的治疗格局，并有望为心血管疾病、肾脏并发症等其他疾病带来获益，但受成本高昂及胃肠道副作用影响，其真实世界用药依从性始终未达理想水平。用药依从性不足已导致部分患者出现体重反弹、血糖控制不佳等问题，也凸显了行业在给药方式、耐受性及可负担性方面持续创新的迫切需求。

Orforglipron 和 retatrutide 等新型疗法分别聚焦给药途径优化与药效升级两大方向，通过独特作用机制突破现有疗法局限。二者有望成为各自细分领域的“首创性药物”—— orforglipron 是首个进入 III 期临床试验的口服非肽类小分子 GLP-1RA，retatrutide 则是首个靶向“三重 G”机制（GLP-1、GIP 及胰高血糖素受体）的药物。二者的协同发力，或将推动超重 / 肥胖及 T2DM 治疗范式向更贴合患者核心需求的方向深度转型。

为什么列为值得关注的药物？

Orforglipron

orforglipron 是首个进入 III 期临床试验的口服非肽类小分子 GLP-1 RA。该药物可在一天中任意时间服用，无需受进食或饮水限制，相较于注射类 GLP-1RA，其在用药便利性与可及性上实现了突破性进展。更重要的是，其用药灵活性显著优于口服司美格鲁肽（诺和忻[®]，诺和诺德），后者的给药限制较多（需空腹服用，且服药后至少 30 分钟内不得进食、饮水或服用其他药物），导致患者依从性偏低。

与肽类 GLP-1RA 相比，orforglipron 的生产工艺更简化、成本更具优势，且无需冷藏储存，这一特性有望推动 GLP-1RA 疗法在全球范围内的普及。此外，

礼来已提前储备价值 5.48 亿美元的上市前库存，这一举措彰显了公司对该药物无供应限制、全面上市的信心。

截至目前，全球 III 期临床试验顶线数据显示，orforglipron 的疗效非劣于甚至优于多数已上市 GLP-1RA 产品（包括口服司美格鲁肽），且安全性、耐受性与已获批的注射类 GLP-1RA 保持一致。其中，针对肥胖症的 ATTAİN-1 和 ATTAİN-2 两项 III 期临床试验所获数据，有望支持该药物于 2025 年底提交首个监管审批申请。尽管 ATTAİN-1 试验中 12.4% 的减重率低于预期约 16%，但该结果仍足以支撑其申请监管审批。针对 2 型糖尿病 (T2DM) 适应症，礼来计划于 2026 年上半年向监管机构提交临床试验数据。

ATTAIN-1（全球 III 期）：3,127 例肥胖或超重且合并体重相关并发症（不含 T2DM）的成年患者

治疗估计结果 *	6 mg orforglipron	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	安慰剂
主要终点				
第 72 周体重变化百分比	-7.5%	-8.4%	-11.2%	-2.1%
关键次要终点				
体重降低 ≥ 10% 的受试者比例	33.3%	40.0%	54.6%	12.9%
体重降低 ≥ 15% 的受试者比例	15.1%	20.3%	36.0%	5.9%

主要终点完成时间：

- 2025 年 7 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 10 月

ATTAIN-2（全球 III 期）：1,600 例肥胖或超重合并 T2DM 的成年患者

治疗估计结果 *	3 mg orforglipron	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	安慰剂
主要终点				
第 72 周体重变化百分比	-5.1%	-7.0%	-9.6%	-2.5%
关键次要终点				
体重降低 ≥ 10% 的受试者比例	22.6%	31.2%	45.6%	9.0%
体重降低 ≥ 15% 的受试者比例	6.8%	14.4%	26.0%	3.0%
HbA1c 较平均基线 8.1% 的变化百分比	-1.2%	-1.5%	-1.7%	-0.5%
实现 HbA1c <7% 的受试者比例	64.6%	75.9%	75.5%	30.5%
实现 HbA1c <6.5% 的受试者比例	52.5%	57.6%	66.6%	15.4%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 8 月

ATTAIN-J（仅在日本进行的 III 期临床试验）：238 例肥胖且合并至少一种肥胖相关健康问题（高血压、血脂异常或 T2DM）的成年患者

Orforglipron vs 安慰剂

主要终点：

- 第 72 周体重变化平均百分比
- 第 72 周体重降低 $\geq 5\%$ 的受试者比例

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 6 月

ATTAIN-OSA（全球 III 期）：合并肥胖或超重的阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 患者，无论是否接受气道正压通气 (PAP) 治疗

Orforglipron vs 安慰剂

主要终点：

- 呼吸暂停低通气指数 (AHI) 较基线的变化

预计主要终点完成时间：

- 2026 年 11 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 1 月

ATTAIN-MAINTAIN（仅在美国进行的 III 期临床试验）：300 例肥胖或超重且合并体重相关并发症（不含 T2DM），且在 SURMOUNT-5 临床试验中已完成 Zepbound®（替尔泊肽，礼来）治疗的受试者

Orforglipron vs 安慰剂

主要终点：

- 第 52 周时，维持 SURMOUNT-5 试验中所实现体重降幅的比例

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 1 月

ACHIEVE-1（全球 III 期）：559 例仅通过饮食和运动无法有效控制血糖的 T2DM 成年患者

治疗估计结果 *	3 mg orforglipron	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	安慰剂
主要终点				
第 40 周 HbA1c 较平均基线 8.0% 的变化百分比	-1.24%	-1.47%	-1.48%	-0.41%
关键次要终点				
第 40 周体重降幅	-4.5%	-5.8%	-7.6%	-1.7%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 4 月

ACHIEVE-2（全球 III 期）：888 例接受二甲双胍治疗但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

顶线治疗估计结果 *	3 mg orforglipron	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	10 mg 安达唐®（达格列净，阿斯利康）
主要终点				
第 40 周 HbA1c 较平均基线 8.1% 的变化百分比	-1.2%	-1.5%	-1.6%	-0.8%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 9 月

ACHIEVE-3（全球 III 期）：1,698 例接受二甲双胍治疗但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

顶线治疗估计结果 *	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	7 mg 诺和忻（口服司美格鲁肽）	14 mg 诺和忻（口服司美格鲁肽）
主要终点				
第 52 周 HbA1c 变化百分比	-1.7%	-1.9%	-1.2%	-1.5%
关键次要终点				
第 52 周体重较基线（97.0kg，即 213.9 磅）变化百分比	-6.1%	-8.2%	-3.9%	-5.3%
实现 HbA1c <5.7% 的受试者比例	21.4%	31.4%	7.4%	11.7%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 8 月

ACHIEVE-4（全球 III 期）：2,749 例心血管风险增加的 T2DM 以及肥胖或超重成年患者

Orforglipron vs 甘精胰岛素

主要终点：

- 首次发生任何主要不良心血管事件（MACE-4）的时间

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 3 月

ACHIEVE-5（全球 III 期）：520 例接受甘精胰岛素治疗（联合或不联合二甲双胍和 / 或 SGLT-2 抑制剂）但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

顶线治疗估计结果 *	3 mg orforglipron	12 mg orforglipron	36 mg orforglipron	安慰剂
主要终点				
第 40 周 HbA1c 较平均基线 8.5% 的变化百分比 (甘精胰岛素剂量滴定)	-1.6%	-1.9%	-1.8%	-0.8%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 9 月

ACHIEVE-J（仅在日本进行的 III 期临床试验）：401 例仅通过饮食和运动、或联合口服降糖药治疗但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

Orforglipron

主要终点：

- 第 52 周治疗期间出现的不良事件 (TEAEs) 发生情况：整体安全性与现有 GLP-1RA 一致，报告的胃肠道事件包括便秘、呕吐及鼻咽炎

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 6 月

* 不考虑患者用药依从性及停药因素的治疗效果，反映真实世界用药模式下的疗效特征

为什么列为值得关注的药物？

Retatrutide

Retatrutide 有望成为首款靶向胰高血糖素、GIP 及 GLP-1 受体的三靶点激动剂，其为单一肽类分子，旨在调控多条对机体能量稳态至关重要的代谢通路。相较于仅靶向一个或两个受体的现有疗法，retatrutide 有潜力实现前所未有的代谢调节效果，不仅可减少热量摄入，还能通过激活胰高血糖素受体提升能量消耗，减重效果可能优于 Zepbound/Mounjaro[®]（替尔泊肽）。

在肥胖适应症 II 期临床试验中，retatrutide 成为首个实现所有受试者体重降幅均 $\geq 5\%$ 的药物。研究结果显示，受试者在治疗 48 周时平均减重达 24.2%，达到“手术级减重”（如胃旁路手术）水平，且最高剂量组约 25% 的患者达到 $\geq 30\%$ 的减重幅度。该药物安全性表现良好，耐受性与 GLP-1RA 的药理学特征相符。

在一项针对肥胖合并非代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH) 患者的亚组研究中，retatrutide 可使肝脏脂肪减少高达 82%，86% 的患者肝脏脂肪水平恢复至正常标准 ($\leq 5\%$)。

Retatrutide 与司美格鲁肽（诺和泰[®]，诺和诺德）在 T2DM 领域的头对头试验同样具备重要临床意义，皮下注射司美格鲁肽是目前在 HbA1c 控制及减重领域疗效最突出的 GLP-1RA 之一。因此，若该试验能证明 retatrutide 在血糖控制及减重效果上的非劣效性或优效性，将为其构建优于现有疗法的显著市场竞争优势。

目前，旨在验证并拓展 II 期结果的关键性 III 期临床试验正在推进中。其中 III 期 TRIUMPH-4 试验的顶线数据显示，retatrutide 可为肥胖或超重合并膝骨关节炎 (OA) 患者带来显著减重效果，同时疼痛症状及躯体功能也得到明显改善。

TRIUMPH-1（全球 III 期）：2,300 例肥胖或超重成年患者，合并膝骨关节炎 (OA) 或阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 亚组

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点：

- 第 80 周与第 104 周体重变化百分比
- OA 亚组：西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数 (WOMAC) 疼痛亚量表评分变化情况
- OSA 亚组：每小时呼吸暂停低通气指数 (AHI) 事件的变化情况

预计主要终点完成时间：

- 2026 年 4 月

预计研究完成时间：

- 2026 年 5 月

在 retatrutide 的延长期研究中，受试者在 80 周安慰剂对照治疗 80 周后，将继续接受 retatrutide 治疗 24 周，主要终点为第 104 周的体重变化百分比。

TRIUMPH-3（全球 III 期）：1,800 例肥胖合并心血管疾病的成年患者

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点：

- 第 80 周体重变化百分比

预计主要终点完成时间：

- 2026 年 4 月

预计研究完成时间：

- 2026 年 5 月

TRIUMPH-2（全球 III 期）：1,000 例肥胖或超重的 T2DM 成年患者，合并 OSA 患者亚组

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点：

- 第 80 周体重变化百分比
- 每小时 AHI 事件的变化情况

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 5 月

TRIUMPH-4（全球 III 期）：400 例肥胖或超重合并膝骨关节炎 (OA) 的成年患者

顶线治疗估计结果 *	9 mg retatrutide	12 mg retatrutide	安慰剂
主要终点			
第 68 周体重变化百分比	-20.0%	-23.7%	-4.6%
WOMAC 疼痛亚量表评分的变化情况	-4.0 点 (-67.2%)	-3.7 点 (-62.6%)	-2.1 点 (-35.1%)
不良事件			
恶心	38.1%	43.2%	10.7%
腹泻	34.7%	33.1%	13.4%
便秘	21.8%	25.0%	8.7%
呕吐	20.4%	20.9%	0.0%
食欲减退	19.0%	18.2%	9.4%
感觉异常	8.8%	20.9%	0.7%
停药率			
因不良事件导致，包括受试者认为减重过度的情况	12.2%	18.2%	4.0%

主要终点及研究完成时间：

- 2025 年 12 月

TRIUMPH-5（全球 III 期）：800 例肥胖成年患者

Retatrutide vs 替尔泊肽

主要终点：

- 第 80 周体重变化百分比

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 12 月

TRIUMPH-7（全球 III 期）：586 例肥胖或超重合并慢性腰痛的成年患者

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点：

- 第 72 周数字评分量表（NRS）评估的疼痛强度变化

- 第 72 周体重变化百分比

预计主要终点及研究完成时间：

- 2027 年 9 月

TRIUMPH-6（在加拿大、英国和美国进行的 III 期临床试验）：
643 例肥胖成年患者，评估体重维持效果

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点：

- 第 116 周体重变化百分比

预计主要终点及研究完成时间：

- 2028 年 8 月

* 不考虑患者用药依从性及停药因素的治疗效果，反映真实世界用药模式下的疗效特征

TRIUMPH-OUTCOMES (全球 III 期) : 1,000 例肥胖或超重合并动脉粥样硬化性心血管疾病 (ASCVD) 和 / 或慢性肾病 (CKD) 的成年患者

Retatrutide (逐步增加剂量直至最大耐受剂量) vs 安慰剂

主要终点 :

- 复合心血管疾病终点首次发生时间 (非致死性心肌梗死、非致死性脑卒中、心血管死亡或因心力衰竭导致住院或急诊)
- 复合慢性肾病终点首次发生时间 (终末期肾病、估算肾小球滤过率 (eGFR) 持续下降 $\geq 40\%$ 或心血管 / 肾脏死亡)

预计主要终点及研究完成时间 :

- 2026 年 2 月

TRANSCEND-T2D-2 (在北美和南美进行的 III 期临床试验) : 1,250 例接受二甲双胍和 / 或 SGLT-2 抑制剂治疗但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

Retatrutide vs 诺和泰

主要终点 :

- 第 80 周 HbA1c 变化情况

预计主要终点完成时间 :

- 2026 年 8 月

预计研究完成时间 :

- 2027 年 1 月

TRANSCEND-T2D-1 (在印度、墨西哥和美国进行 III 期临床试验) : 480 例仅靠饮食和运动无法有效控制血糖的 T2DM 成年患者

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点 :

- 第 40 周 HbA1c 变化情况

预计主要终点完成时间 :

- 2026 年 1 月

预计研究完成时间 :

- 2026 年 2 月

TRANSCEND-T2D-3 (全球 III 期) : 合并肾功能不全、仅接受基础胰岛素治疗 (联合或不联合二甲双胍和 / 或 SGLT-2 抑制剂) 但血糖控制不佳的 T2DM 成年患者

Retatrutide vs 安慰剂

主要终点 :

- 第 52 周 HbA1c 变化情况

预计主要终点完成时间 :

- 2026 年 9 月

预计研究完成时间 :

- 2026 年 10 月

orforglipron 和 retatrutide 将如何影响肥胖症和 2 型糖尿病市场？

当前全球范围内，处于 III 期临床试验阶段的肥胖治疗药物包括 CagriSema、orforglipron、retatrutide 和 survodutide（勃林格殷格翰）。这些药物均突破了单纯减重的范畴，重点聚焦在肥胖合并症的治疗，如心血管疾病（CVD）、阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）、骨关节炎（OA）、慢性肾病（CKD）及代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH），这一差异化特征，或将进一步提升其在肥胖及 T2DM 领域的市场渗透率。其中，survodutide 作为 GLP-1/ 胰高血糖素双重受体激动剂，预计将比 retatrutide 早一年在美国上市，成为首款采用胰高血糖素创新机制的肥胖症治疗药物。

orforglipron 和 retatrutide 有望扩大 GLP-1RA 类药物的患者覆盖范围。

正在进行的头对头临床试验（如 ACHIEVE-2、ACHIEVE-3 和 TRIUMPH-5）的结果，将对这两款药物在肥胖及 T2DM 市场的定位起到关键决定作用。

Orforglipron

口服给药方式、便捷灵活的服用特性及稳定的整体疗效，将成为驱动其市场渗透的核心引擎。

在针对 T2DM 的 ACHIEVE 系列试验中，该药物已展现出显著的 HbA1c 降幅及减重效果，成为追求非注射方案患者的优质选择。相较于口服司美格鲁肽（诺和忻），orforglipron 的生物利用度更高、给药方案更简洁，这些优势有望进一步提升其临床吸引力；此外，其便捷的口服剂型或可帮助其在治疗路径中获得更早的临床应用机会，与 DPP-4 抑制剂等传统口服降糖药形成竞争。

在 ACHIEVE-2 和 ACHIEVE-3 试验中，orforglipron 各剂量组在降低 T2DM 患者 HbA1c 方面，均优于对照组（分别为安达唐和诺和忻）。其整体安全性与耐受性与既往研究一致，最常见不良事件为轻至中度胃肠道反应，未出现新的安全性信号。

值得关注的是，ATTAIN-MAINTAIN 试验若能取得阳性结果，将为 orforglipron 开辟新的市场机会，使其成为停用 Zepbound（替尔泊肽，礼来）之后维持体重的优选药物。

从市场前景来看，预测到 2033 年，orforglipron 在 G7 国家 T2DM 及肥胖患者中的市场份额将分别达到约 3% 和 12%。但需注意的是，截至 2033 年，包括 orforglipron 在内的口服 GLP-1RA 产品，恐难撼动皮下注射 GLP-1RA 剂型的市场主导地位。

Retatrutide

与 orforglipron 不同，retatrutide 的研发更侧重肥胖适应症。若 retatrutide 在血糖控制及减重结果上能证明非劣效性或优效性，将有望成为 Zepbound/ Mounjaro 等已上市注射类 GLP-1 疗法的强劲竞争对手。

凭借预期的优效性，retatrutide 有望从现有 GLP-1RA 疗法中抢占可观的市场份额。但受其作用机制（三靶点激动）、给药途径（皮下注射）及预期高昂成本的影响，该药物大概率将遵循临床“阶梯治疗”原则开具处方，这一模式与当前 T2DM 领域皮下注射 GLP-1RA 的处方习惯基本一致。

尽管目前市场对胰高血糖素类似物的认知度偏低，或将影响 retatrutide 上市后在肥胖治疗领域的初期推广速度，但三大核心优势仍赋予其强劲的增长潜力：相较于现有疗法更显著的减重获益、以合并症为核心设计的全面 III 期临床试验项目、以及与替尔泊肽头对头研究中展现的更优数据表现。

2028 年后，retatrutide 有望成为肥胖药物市场的核心增长引擎，其市场拓展路径，或将复刻诺和诺德从 Wegovy 到 CagriSema 的迭代模式，抓住替尔泊肽 2030 年年中专利到期前的窗口期，推动患者过渡至这一新一代药物分子。

这两种药物填补了哪些治疗空白？

尽管当前多数 GLP-1RA 为注射剂型，但医生通常不将给药途径视为主要障碍。需注意的是，尽管 GLP-1RA 已对体重及 T2DM 管理产生革命性影响，但其高价格、耐受性问题及疗效不足等问题，仍导致较高停药率，进而引发体重反弹及血糖控制不佳等不良结局。此外，在美国等核心市场，GLP-1 单靶点及 GLP-1/GIP 双靶点激动剂价格依旧高昂，医保支付覆盖范围有限。

随着 orforglipron（无需空腹口服）等更便捷药物，以及对肥胖及 T2DM 疗效更优的 GLP-1 双靶点 / 三靶点激动剂陆续上市，用药依从性不足、医保支付覆盖有限等核心障碍有望逐步缓解，进而让 GLP-1 类疗法惠及更广泛患者群体。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

诺和忻（口服司美格鲁肽）已有疗效数据以及备皮下注射剂型临床数据加持，因此，ACHIEVE-3 试验中 orforglipron 与诺和忻的头对头结果，或将直接成为决定其后续市场推广成败的关键。此外，orforglipron 还需证明其在 HbA1c 降低、减重及临床结局方面的显著获益，才能与现有降糖疗法展开有效竞争。否则，orforglipron 不仅难以获得临床医生的认可，更无法与主流治疗方案形成差异化优势，最终难以在市场中站稳脚跟。

Retatrutide 不仅上市时间晚于竞争对手，还将面临 CagriSema、Wegovy（司美格鲁肽肥胖适应症）及司美格鲁肽仿制药的直接竞争，这可能成为其上市后的核心障碍。受访内分泌科医生强调，胰高血糖素成分相关的副作用，仍需在更大规模临床试验中深入验证，以明确其长期安全性。

值得注意的是，心血管安全性是监管机构与临床医生的核心考量因素。因此，这两款药物若能展现出积极的心血管获益，将不仅是满足监管的硬要求，更是赢得肥胖及 2 型糖尿病 (T2DM) 领域医生与支付方认可的重要筹码。

111 亿美元

2031 年 orforglipron 在 G7 市场肥胖症治疗领域的预计销售额*

52 亿美元

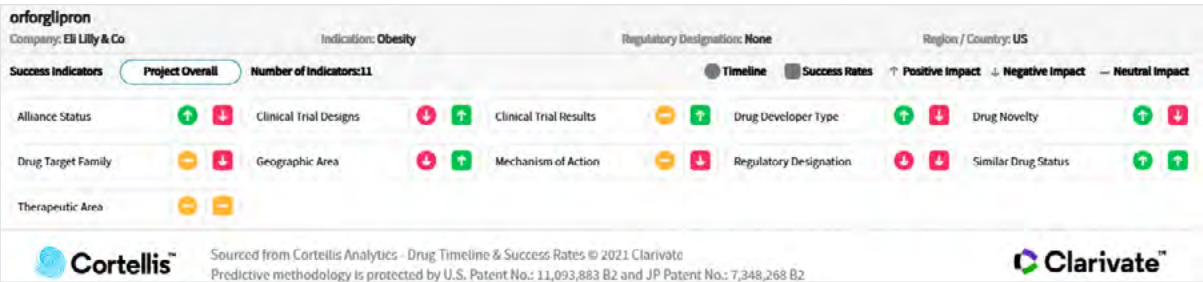
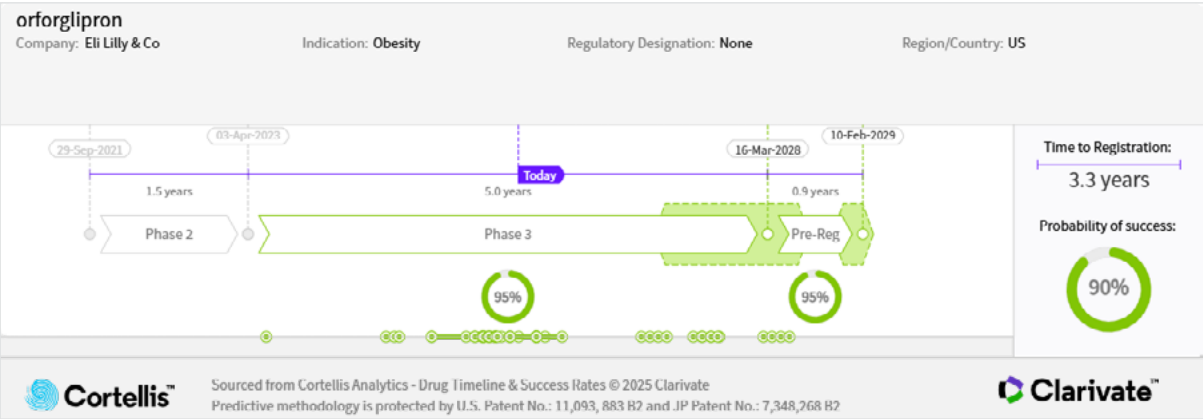
2031 年 orforglipron 在 G7 市场 2 型糖尿病治疗领域的预计销售额*

* 由于肥胖症与 2 型糖尿病患者群体存在重叠，因此，所报告的销售额并未对每个市场进行完全独立的划分。

“ 若将 orforglipron 与口服司美格鲁肽对比，前者使用起来更方便一些，因为它没有空腹服用的限制。至于减重效果，我认为这两种药物不相上下。”

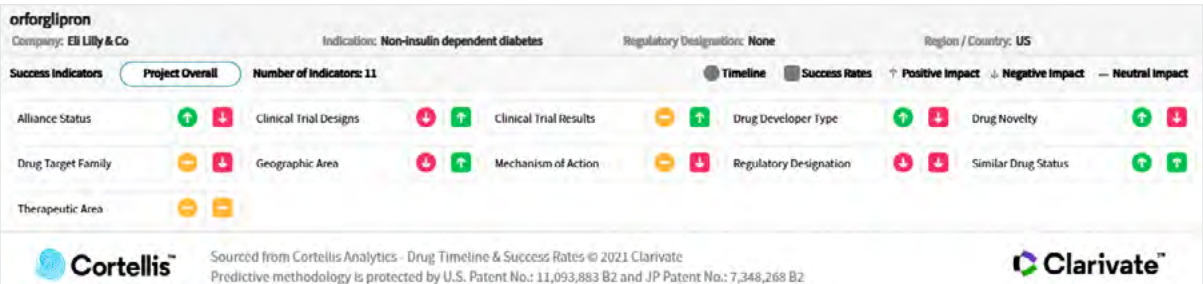
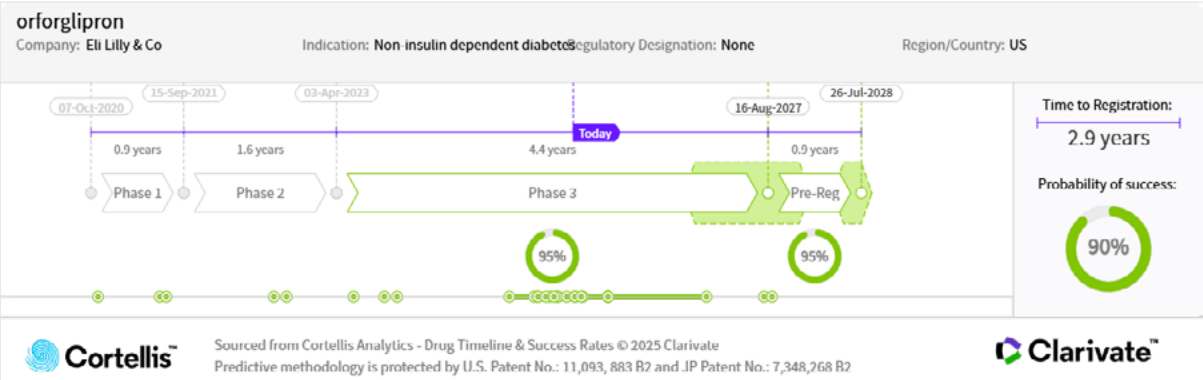
内分泌科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，**orforglipron** 作为肥胖症治疗药物在美国注册成功的概率为 90%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

Cortellis 数据表明，**orforglipron** 作为 2 型糖尿病治疗药物在美国注册成功的概率为 90%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 8 月 25 日。

100 亿美元

2031 年 retatrutide 在 G7 市场肥胖症治疗领域的
预计销售额*

201 亿美元

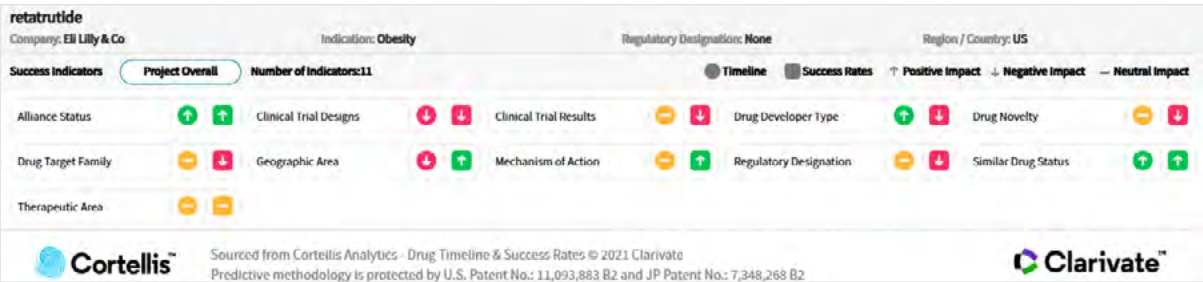
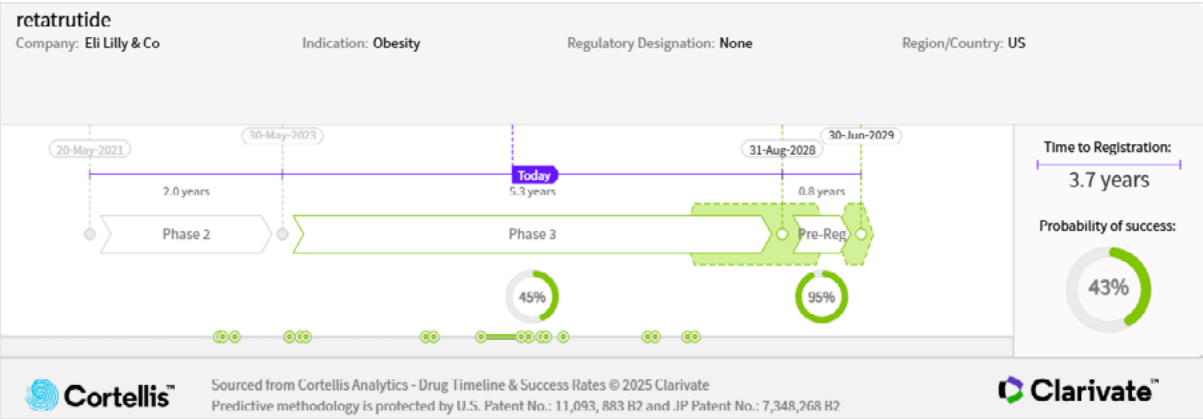
2031 年 retatrutide 在 G7 市场 2 型糖尿病治疗领
域的预计销售额*

* 由于肥胖症与 2 型糖尿病患者群体存在重叠，因此，所报告的销售额并未对每个市场进行完全独立的划分。

“ 我们仍需等待 retatrutide 的 III 期临床试验结果。如果其减重疗效与司美格鲁肽或替尔泊肽相当，它将成为一款极具临床价值的治疗选择。retatrutide 的关键在于平衡两大核心诉求——在疗效不逊于现有药物的前提下，进一步提升耐受性。当前临床应用的药物仍存在较多副作用，这已是困扰诸多患者的核心问题。”

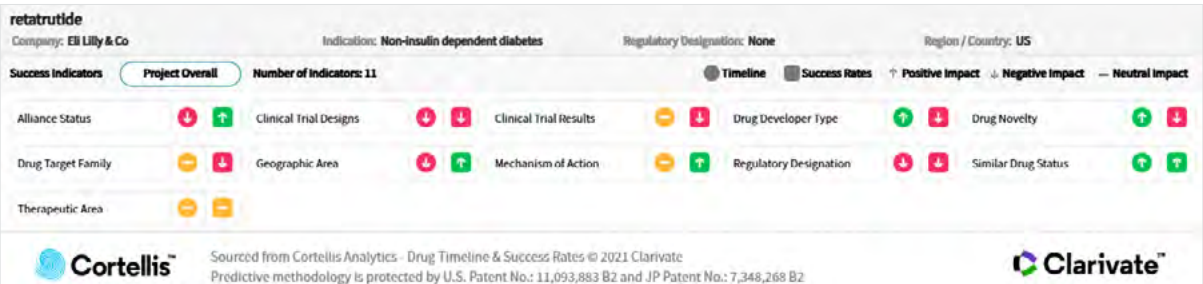
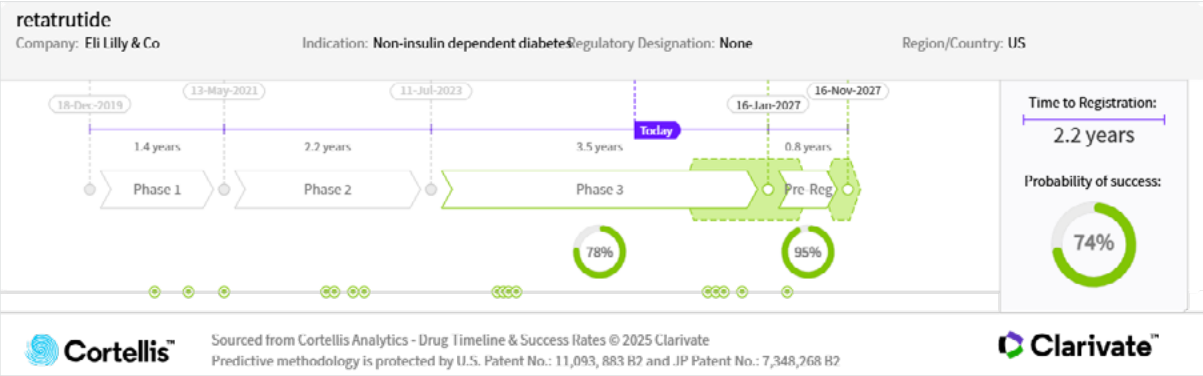
内分泌科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，retatrutide 作为肥胖症治疗药物在美国注册成功的概率为 43%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

Cortellis 数据表明，retatrutide 作为 2 型糖尿病治疗药物在美国注册成功的概率为 74%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 8 月 25 日。

02

填补罕见病治疗缺口

迄今为止，全球已知的罕见病超过 7,000 种，但获得 FDA 或 EMA 批准的罕见病治疗药物仅约 500 种（美国国家罕见病组织，2025 年），诊断与有效治疗之间仍存在巨大缺口。

对于制药企业而言，进入这一领域需采取颠覆性策略——从战略规划到执行、从洞察分析到落地，全面重构患者的诊疗路径。

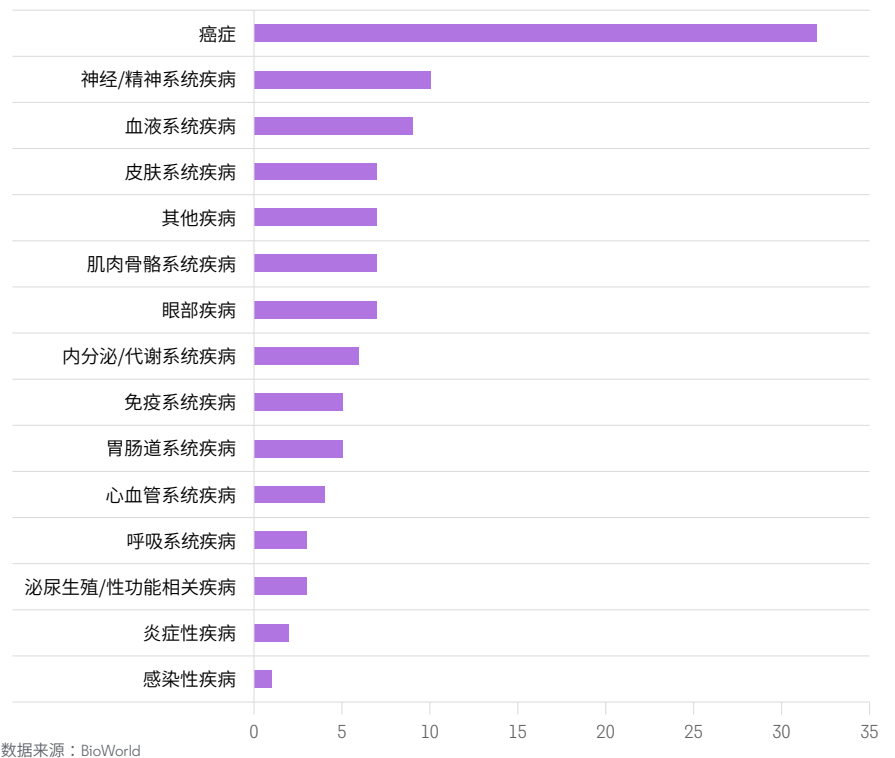
[点击此处预约网络研讨会：《高山景行，长风破浪——2026 年全球和中国最值得关注的药物》](#)

罕见病患者的共通之处在于其临床表现具有显著特殊性：症状本身罕见，随病程进展还可能动态演变，常出现误诊或漏诊。从数据来看，欧盟每 12 人中就有 1 人患有罕见病（EMA，2025b）；美国《孤儿药法案》（Orphan Drug Act）（1983 年）将美国患病人数少于 20 万的疾病定义为罕见病。由于疾病的独特性，患者在诊疗过程中通常需要接触众多相关方，往往在不同医疗机构间辗转以求确诊，平均确诊时间长达 5 年（欧洲罕见病组织，无具体日期）。而医疗服务人员对罕见病及其治疗方案的认知不足，进一步加剧了诊断的延迟。

目前，罕见病领域的药物研发仍以癌症为重点。

2025 年全球获得儿科罕见病资格认定（RPDD）或孤儿药资格认定（ODD）的 108 种药物中，有 32 种（29.6%）属于癌症治疗药物（图 1）。不过，制药企业也正在拓展其他治疗领域，如神经 / 精神疾病和血液系统疾病。政策方面，新药加速审评审批通道、儿科罕见病资格认定和孤儿药资格认定等多重激励政策，不仅持续推动罕见病新药研发进程，更能切实保障患者及时获取所需治疗药物，有效改善其诊疗困境。

图 1：2025 年获得儿科罕见病资格认定或孤儿药资格认定的产品（按治疗领域分类，截至 2025 年 9 月 3 日）



同时，全球各国监管机构也正持续加速审评审批通道并推进协同审评机制。例如，2025 年 1 月 12 日，欧盟开始实施新的卫生技术评估 (HTA) 法规，通过联合临床评估 (JCAs) 等流程来强化协作，推动 HTA 在欧洲范围内更快落地、更广泛可及 (EMA, 2025a)。此新规初期仅适用于新型癌症治疗药物及所有先进治疗药品 (ATMPs)，但自 2028 年 1 月起，其适用范围将进一步扩展至孤儿药。

此外，美国在 2025 年通过的 H.R.1 法案延长了孤儿药的独占保护期。此前，这一独占保护期是自药物首次获得孤儿药资格认定之日起的 7 年，现在则是从该药首个非罕见病适应症获批后才开始计算。

这一调整实际上延长了孤儿药的保护期限：无论药物拥有多少个已获批的罕见病适应症，只要其尚未扩展到非罕见病适应症，就能持续享有豁免医保谈判的独占权益。

在罕见病药物的市场准入方面，鉴于罕见病单个适应症对应的患者群体规模普遍较小，制药企业需采用与传统药物不同的商业化新模式，最大化市场准入的效率与覆盖面。例如，针对全球每 200 万人中仅 1 人患有的遗传性铜蓝蛋白缺乏症 (Miyajima, 2015)，Kedrion Biopharma 开发的一款在研血浆源性疗法，于 2025 年 8 月获得 FDA 授予的孤儿药认定 (Kedrion Biopharma, 2025 年)。针对这类患者群体极其小众的罕见病，企业需将“以患者为中心”的理念深度融入研发与商业化全流程，重点聚焦于患者精准诊断与筛查、提升早期用药可及性，同时提供诊疗全周期的个性化随访与针对性支持服务。

科睿唯安建议, 针对罕见病药物的市场推广, 企业可围绕疾病认知普及、患者组织合作、全球关键意见领袖 (KOL) 赋能及临床新证据生成等多维度, 系统构建强大的罕见病药物市场推广能力, 以全面提升药物可及性。企业通过持续积累行业洞见, 并与利益相关方共创解决方案, 不仅能进一步扩大患者覆盖范围, 更有助于实现患者预后的切实改善, 进而创造可持续的长期价值。

如需了解更多罕见病信息, 请下载电子书《关注“斑马人群”: 为罕见病患者提供创新药物》。

图 2：深度认知并落地执行罕见病患者全病程路径

	增长领域	评估指标	行动措施
患者旅程 疑似症状 ↑ 转诊 ↓ 诊断 治疗 随访	患者识别	• 患病率 • 发病率 • 确诊时长	• 提高疾病认知度 • 提升转诊人员和机构专业认知 • 优化区域转诊路径（如制定转诊指南） • 加强筛查工作（如人工智能辅助筛查、家系图谱筛查、新生儿筛查）
	患者治疗	• 需求未满足程度 vs 标准治疗方案 (SOC) • 竞品或在研管线数量	• 推动识别患者的治疗转化，优化多学科团队（MDT）诊疗模式 • 最大化早期患者群体的获益窗口期 • 成为优于标准治疗（SOC）的优选方案 • 确保最佳给药剂量
	患者与照护者体验	• 中重度疾病患者比例 • 儿童与成年患者比例 • 照护者支持程度	• 为儿童患者照护者提供支持 • 增强患者的自我管理能力 • 按需提供以患者为中心的支持计划
市场拓展	市场准入与上市	• 已上市国家 / 地区数量 • 已获批国家 / 地区数量 • 最优上市顺序	• 需要时，为患者提供用药支持 • 需要时，提供医保谈判支持 • 推动在下一批国家 / 地区上市 • 推动新适应症上市
数字化	数字化与全渠道	• 渠道偏好 • 数字化成熟度	• 面向所有利益相关方推行全渠道模式 • 强化并借力第三方数字化资源

数据来源：科睿唯安

Exdensur (depemokimab)

哮喘

填补罕见病治疗缺口

如需获取最新动态，请访问 [Exdensur](#) 页面。

生产商
葛兰素史克
类型
靶向白细胞介素 (IL)-5 的单克隆抗体
用法
- 每半年一次皮下注射，用于治疗青少年和成人哮喘 - 同时，正在开发用于其他 IL-5 介导的疾病，包括慢性鼻窦炎伴息肉 (CRSwNP)、嗜酸性肉芽肿性多血管炎 (EGPA) 及高嗜酸性粒细胞综合征

影响
约 1,440 万
2025 年 G7 市场 12 个月内出现症状或需药物控制的中度 / 重度哮喘病例数约为 1,440 万例

审批状态
2025 年 1 月：
- 上市许可申请 (MAA) 受理：欧盟 EMA (2 型炎症型哮喘及 CRSwNP) - NDA 受理：日本厚生劳动省 (2 型炎症型哮喘及 CRSwNP 辅助维持治疗)
2025 年 3 月：
BLA 受理：美国 FDA (2 型炎症型哮喘及 CRSwNP 辅助维持治疗)
2025 年 12 月：
获得 EMA 人用药品委员会 (CHMP) 积极意见：2 型炎症型哮喘及 CRSwNP 辅助维持治疗
2025 年 12 月 15 日：
批准：英国 MHRA (2 型炎症性哮喘及 CRSwNP)
2025 年 12 月 16 日：
批准：美国 FDA (具有嗜酸性粒细胞表型的重度哮喘)
实际和预期上市时间
2026 年：日本、美国 2027 年：欧盟
预计专利到期时间
专利预计从 2041 年 开始陆续到期

Exdensur 是首个获批用于治疗重度哮喘的超长效生物制剂，给药周期长达半年一次。相比当前市场上每月或每两个月给药一次的 IL-5 抑制剂，该药在用药便利性上具备显著优势。

Exdensur 的长半衰期使其具备持续抑制广泛炎症的潜力，尤其对 2 型炎症具有针对性抑制作用。目前该药临床探索已拓展至哮喘、鼻窦炎等多种 2 型炎症性疾病。积极的临床试验顶线数据显示，在为期一年的治疗周期内，该药对重度哮喘及慢性自发性鼻窦炎伴鼻息肉 (CRSwNP) 均展现出明确的有效性。

为什么列为值得关注的药物？

Exdensur 是首款经 III 期临床试验评估并获批用于治疗重度哮喘的超长效生物制剂。其核心竞争力在于长半衰期与高结合亲和力的特性，持续抑制关键致病因子 IL-5，可支持每 6 个月给药一次的治疗方案。葛兰素史克 (GSK) 为 depemokimab 开展的确证性 III 期临床研究已取得关键进展，包括针对重度哮喘的 SWIFT-1、SWIFT-2 试验，以及针对 CRSwNP 的 ANCHOR-1、ANCHOR-2 试验，这些研究均顺利达到主要终点。

针对重度哮喘，还有两项 III 期研究正在进行：一项是开放标签扩展研究 (AGILE)，另一项是补充研究 (NIMBLE)，用于评估严重哮喘患者从现有 IL-5 抑制剂新可来（美泊利珠单抗，葛兰素史克）或凡舒卓[®]（本瑞利珠单抗，阿斯利康）转为 Exdensur 后的疗效与安全性。

SWIFT-1 与 SWIFT-2 的临床试验结果，成为葛兰素史克向监管机构递交上市申请的核心支撑。

SWIFT-1 (全球 III 期) : 395 例未得到有效控制的嗜酸粒细胞表型重度哮喘患者

Exdensur vs 安慰剂

主要终点 :

- 52 周治疗期间哮喘年化急性发作率 (AAER) : 0.46 次 / 年 vs 1.11 次 / 年

次要终点 :

- 52 周治疗期间圣乔治呼吸问卷 (SGRQ) 评分较基线变化 : -13.03 分 vs -9.67 分 (评分越低表示患者生活质量越好)

不良事件 (AE) 发生率 :

- 两组均为 73%

主要终点及研究完成时间 :

- 2023 年 11 月

SWIFT-2 (全球 III 期) : 397 例未得到有效控制的嗜酸粒细胞表型重度哮喘患者

Exdensur vs 安慰剂

主要终点 :

- 52 周治疗期间哮喘年化急性发作率 (AAER) : 0.56 次 / 年 vs 1.08 次 / 年

次要终点 :

- 52 周治疗期间圣乔治呼吸问卷 (SGRQ) 评分较基线变化 : -14.80 分 vs -12.49 分 (评分越低表示患者生活质量越好)

不良事件 (AE) 发生率 :

- 72% vs 78%

主要终点及研究完成时间 :

- 2024 年 4 月

NIMBLE (全球 III 期) : 1,719 例嗜酸粒细胞表型重度哮喘患者, 已接受美泊利珠单抗或本瑞利珠单抗治疗至少一年并显示出临床获益

Exdensur+ 模拟美泊利珠单抗或本瑞利珠单抗的安慰剂 vs 美泊利珠单抗或本瑞利珠单抗 + 模拟 Exdensur 的安慰剂

主要终点 :

- 52 周治疗期间哮喘年化急性发作率 (AAER)

主要终点及研究完成时间 :

- 2025 年 9 月

AGILE (全球 III 期) : 641 例已完成 SWIFT-1 或 SWIFT-2III 期研究的嗜酸粒细胞表型重度哮喘患者

开放标签研究

主要终点 :

- 52 周治疗期间不良事件 (AE) 和严重不良事件 (SAE) 发生率 : 63%
- 出现免疫原性的受试者人数
- 哮喘年化急性发作率 (AAER) : 0.47 vs 0.48 (安慰剂)

主要终点及研究完成时间 :

- 2025 年 5 月

ANCHOR-1 (全球 III 期) :
276 例慢性鼻窦炎伴鼻息肉 (CRSwNP) 成年患者

Exdensusur vs 安慰剂

主要终点 :

- 52 周治疗期间内镜下鼻息肉总评分 : -0.7 vs -0.3
- 鼻塞言语反应量表 (VRS) 评分 : -0.23 vs -0.46

不良事件 (AE) 发生率 :

- 74% vs 79%

主要终点完成时间 :

- 2024 年 7 月

研究完成时间 :

- 2024 年 8 月

ANCHOR-2 (全球 III 期) :
264 例慢性鼻窦炎伴鼻息肉 (CRSwNP) 成年患者

Exdensusur vs 安慰剂

主要终点 :

- 52 周治疗期间内镜下鼻息肉总评分 : -0.6 vs -0.2
- 鼻塞言语反应量表 (VRS) 评分 -0.25 vs -0.46

不良事件 (AE) 发生率 :

- 76% vs 80%

主要终点完成时间 :

- 2024 年 7 月

研究完成时间 :

- 2024 年 8 月



Exdensur 将如何影响哮喘病市场？

- 在新型生物制剂、重症哮喘小分子药物及便捷性更佳的复方吸入剂等多重因素驱动下，G7 国家哮喘治疗市场规模预计将实现稳步增长，从 2023 年的 208 亿美元攀升至 2033 年的 267 亿美元。
- 其中，生物制剂的推广应用将成为核心增长引擎。随着新可来、凡舒卓、达必妥[®]（度普利尤单抗，赛诺菲/再生元）等现有生物制剂的渗透率提升，叠加 Exdensur 这一超长效 IL-5 抑制剂的上市，不仅将进一步助推市场扩容，还将推动哮喘治疗向“更精准、更个性化”的方向转型。
- 值得注意的是，抗细胞因子生物制剂虽成本高昂，但其显著的疗效优势仍将持续拉动销售额增长；预计到 2033 年，生物制剂在哮喘治疗市场的占比有望提升至 37%，其中 IL-5 类药物（含 depemokimab）的合并销售额将达 45 亿美元。
- 从区域市场来看，美国、法国和英国将成为药物治疗哮喘人群增长最快的地区；2023 至 2033 年间，这三个国家接受药物治疗的哮喘患者年增长率预计为 0.5%-0.6%。

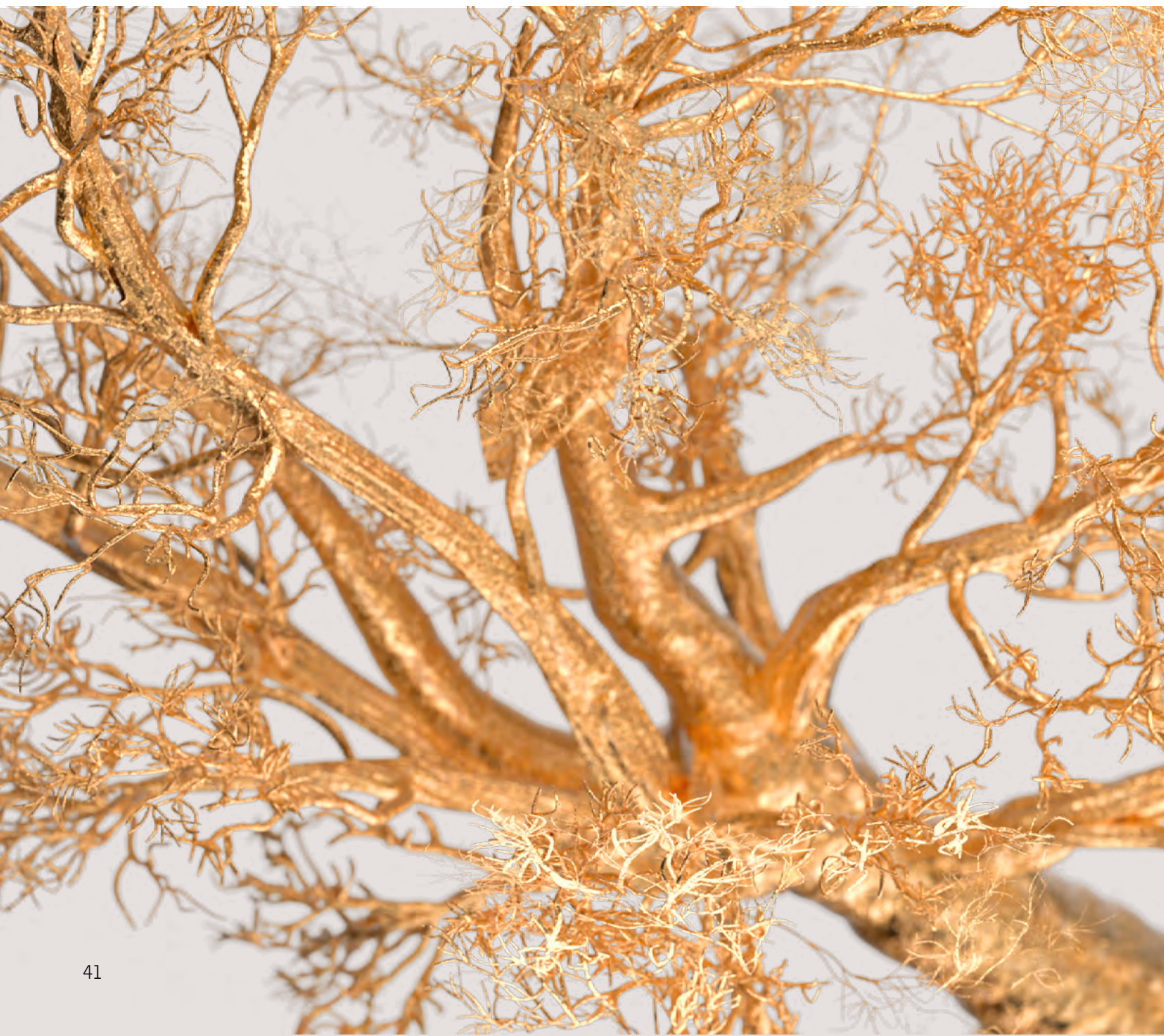
Exdensur 填补了哪些治疗空白？

哮喘及急性发作不仅影响患者生活质量，还因急诊、住院给医疗体系带来压力。而且，现有疗法给药频繁导致患者依从性差。Depemokimab 的疗效与安全性已获临床试验数据充分验证，可改善患者疾病管理；并且，每六个月一次的给药频率受到医患双方的青睐，可直接解决重度哮喘患者的用药依从性障碍。

科睿唯安采访的 KOL 指出，每六个月一次的给药频率可大幅减少患者就诊次数，易获得患者广泛认可；此外，依托该疗法的长效稳定疗效，患者的疾病管理理念从“被动控制症状”升级为“主动追求更好预后”，医生也得以与患者系统探讨实现哮喘临床缓解的可行性，推动诊疗模式向“以临床缓解为目标”转型。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

重度哮喘治疗领域的市场竞争预计将大幅加剧。随着监管机构与医保支付方对成本控制的关注度持续提升，以生物制剂、小分子药物为代表的价格高昂的新型疗法，在定价与报销政策方面或将面临挑战，难以获得有利支持。



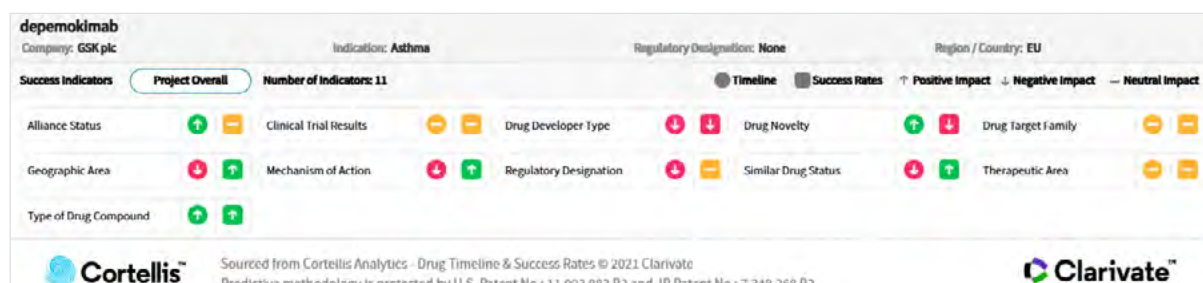
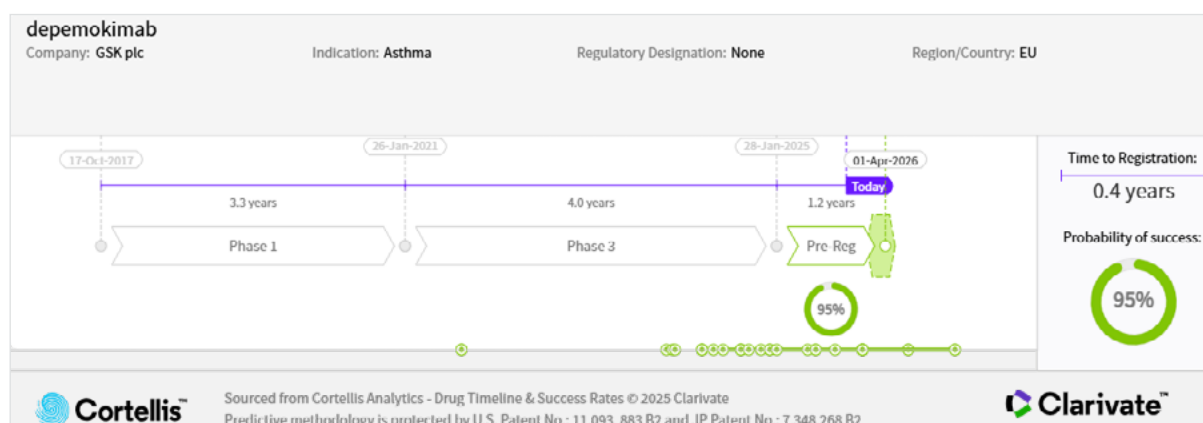
5.1 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“我认为 depemokimab 长达 6 个月的药效持续时间极具临床价值，这为探索哮喘缓解治疗模式提供了可能，因为患者无需频繁就医，治疗依从性有望显著提升。”

过敏科医生，来自西班牙

Cortellis 数据表明，**Exdensur** 在欧盟注册成功的概率为 95%。



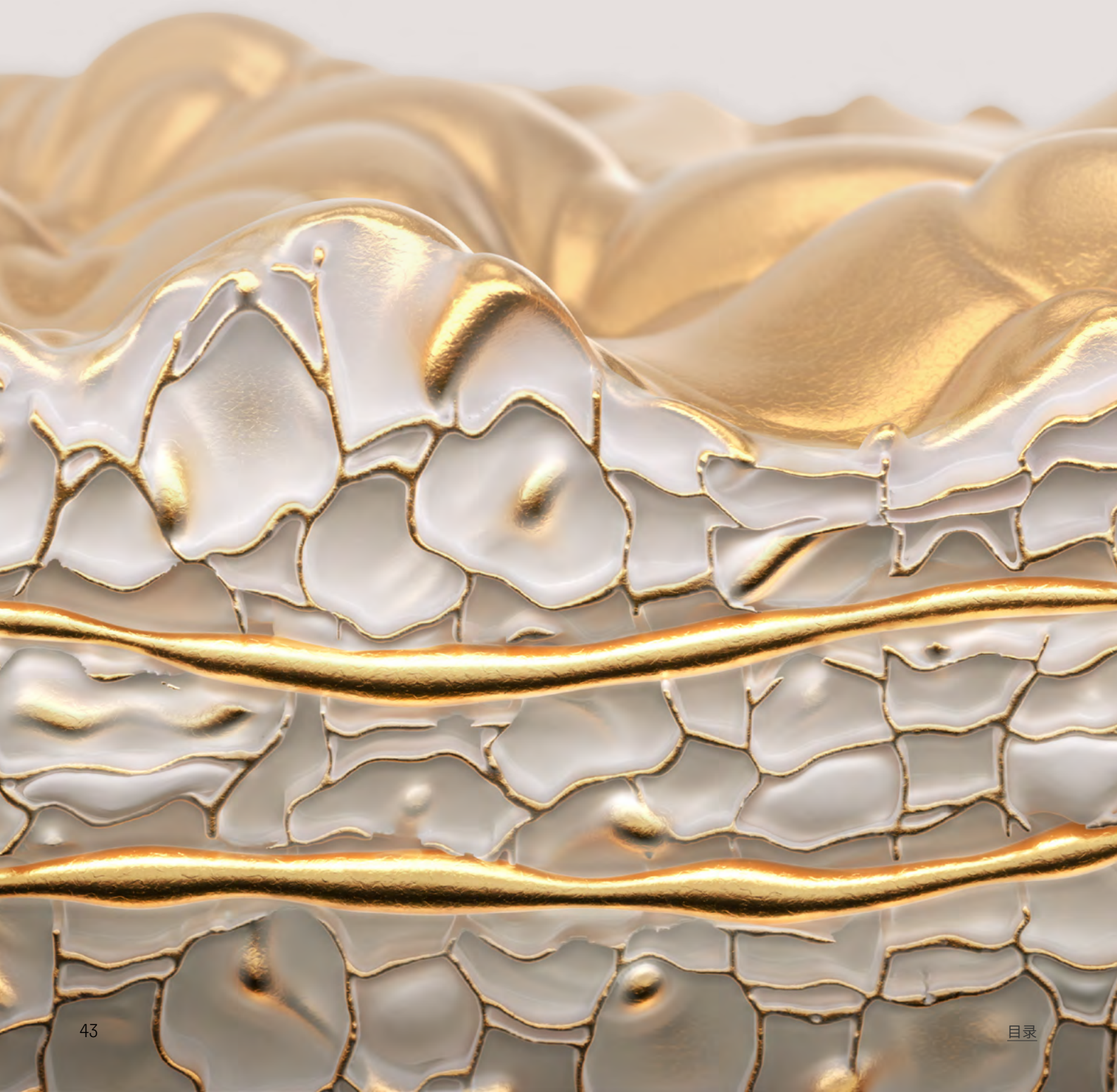
数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [Exdensur](#) 页面。

lcotrokinra

斑块状银屑病

填补罕见病治疗缺口



如需获取最新动态，请访问 [icotrokinra](#) 页面。

生产商 强生 类型 IL-23 受体拮抗剂 用法 • 每日一次口服给药，用于治疗斑块状银屑病 • 同时正在评估其用于治疗银屑病关节炎和溃疡性结肠炎	影响 约 1,170 万 2025 年 G7 市场斑块状银屑病确诊病例数约为 1,170 万例	审批状态 2025 年 7 月： • NDA 提交：美国 FDA 2025 年 9 月： • MAA 提交：欧盟 EMA 实际和预期上市时间 • 2026 年：美国 • 2027 年：欧盟、日本 预计专利到期时间 • 专利预计从 2041 年开始陆续到期
---	---	--

lcotrokinra 有望成为靶向阻断 IL-23 受体的首款获批口服肽类药物。IL-23 受体在中重度斑块状银屑病及溃疡性结肠炎的炎症反应过程中发挥着关键作用。2017 年，Protagonist Therapeutics 与强生达成该药的授权与合作协议。

III 期临床试验顶线数据显示，lcotrokinra 具备成为银屑病领域临床一线口服治疗药物的潜力。若试验结果得到进一步验证，该药将迅速在银屑病市场确立一线治疗地位，甚至有可能成为优先于注射类生物制剂的治疗选择。因此，lcotrokinra 或将重塑银屑病治疗格局，为患者提供兼具疗效与便利性的非注射类治疗选择，精准满足患者长期以来对便捷用药的核心需求。

为什么列为值得关注的药物？

强生针对 lcotrokinra 治疗银屑病开展了全面且严谨的临床研发项目，包括五项确证性 III 期临床研究，其中两项 (ICONIC-ADVANCE 1、2) 是头对头研究，对照药物是目前疗效最优的口服银屑病治疗药物颂狄多（氘可来昔替尼，百时美施贵宝）。更值得关注的是，在 ICONIC-ASCEND 临床研究中，强生选择头对头挑战喜达诺[®]（乌司奴单抗，强生），这是银屑病治疗领域首个采用口服药物与注射类生物制剂进行头对头

对照的临床试验。若该试验取得成功，lcotrokinra 将凭借更便捷的给药方式重塑银屑病治疗格局，并改变患者对银屑病的治疗选择。

ICONIC-TOTAL、ICONIC-LEAD、ICONIC-ADVANCE 1 和 ICONIC-ADVANCE 2 临床试验的结果，为强生向监管机构递交上市申请提供了支持。

ICONIC-TOTAL（全球 III 期）：311 例青少年（>12 岁）及成人中重度斑块状银屑病病患者，病程至少 26 周，至少接受过一种局部治疗且疗效未达到预期标准

Icotrekinra vs 安慰剂

主要终点：

- 第 16 周研究者整体评估 (IGA) 评分达到 0 或 1 分且较基线改善至少 2 级的受试者比例：57% vs 6%

次要终点：

- 第 16 周头皮特异性研究者整体评估 (ss-IGA) 评分达到 0 或 1 分的受试者比例：66% vs 11%
- 第 16 周生殖器静态医师整体评估 (sPGA-G) 评分达到 0 或 1 分的受试者比例：77% vs 21%
- 第 16 周手足部位医师整体评估 (hf-PGA) 评分达到 0 或 1 分的受试者比例：42% vs 26%

安全性：

- 安全性评估良好，未发现新的安全性信号
- 第 16 周不良事件 (AE) 发生率：50% vs 42%
- 第 16 周严重不良事件 (SAE) 发生率：0.5% vs 1.9%

主要终点完成时间：

- 2024 年 6 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 6 月

ICONIC-LEAD（全球 III 期）：684 例青少年（>12 岁）及成人斑块状银屑病病患者，病程至少 26 周

Icotrekinra vs 安慰剂

主要终点：

- 第 16 周银屑病面积和严重程度指数 (PASI) 改善至少 90% (PASI 90) 应答率：49.6% vs 4.4%
- 第 16 周达到 IGA 0/1 分且较基线改善 ≥ 2 级的受试者比例：64.7% vs 8.3%

第 16 周不良事件 (AE) 发生率：

- 49.3% vs 49.1%

主要终点完成时间：

- 2024 年 7 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 4 月

ICONIC-ADVANCE 1（全球 III 期）：中重度斑块状银屑病成年患者，病程至少 26 周

Icotrekinra vs 安慰剂 vs 颂狄多

主要终点：

- 第 16 周 PASI 90 应答率：55% vs 4%（安慰剂）
- 第 16 周达到 IGA 0/1 分且较基线改善 ≥ 2 级的受试者比例：68% vs 11%（安慰剂）

安全性（ADVANCE-1 和 ADVANCE-2）：

- 至第 16 周，不良事件 (AE) 表现与安慰剂组相似
- 至第 24 周，icotrekinra 总体不良事件发生率低于颂狄多

主要终点完成时间：

- 2024 年 9 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 6 月

ICONIC-ADVANCE 2（全球 III 期）：中重度斑块状银屑病成年患者，病程至少 26 周

icotrokinra vs 安慰剂 vs 维狄多

主要终点：

- 第 16 周 PASI 90 应答率：57% vs 1%（安慰剂）
- 第 16 周达到 IGA 0/1 分且较基线改善 ≥ 2 级的受试者比例：70% vs 9%（安慰剂）

主要终点完成时间：

- 2024 年 11 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 9 月

PASI 90 作为主要终点指标，是生物制剂（如 IL-17 抑制剂、IL-23 抑制剂）临床研究中普遍采用的一项严格疗效评估标准。相比之下，多数口服药物竞品仅以 PASI 75 应答率作为评估指标。这一评估标准的差异，或将助力 icotrokinra 确立疗效更优的治疗定位。

此外，处于 III 期阶段的 ICONIC-PsA 1 研究和 ICONIC-PsA 2 研究将评估 icotrokinra 对比安慰剂在活动性银屑病关节炎治疗中的疗效和安全性；处于 IIb 期阶段的 ANTHEM-UC 研究则正在评估 icotrokinra 在中重度活动性溃疡性结肠炎治疗中的治疗潜力。

ICONIC-ASCEND（全球 III 期）：752 例中重度斑块状银屑病成年患者，病程至少 26 周

icotrokinra vs 喜达诺 vs 安慰剂

主要终点：

- 第 16 周 PASI 90 应答率
- 第 16 周达到 PGA 0/1 分且较基线改善 ≥ 2 级的受试者比例

预计主要终点完成时间：

- 2026 年 3 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 8 月

Icotrokinra 将如何影响斑块状银屑病市场？

- 未来，全球银屑病治疗市场预计将保持近 1% 的年均增长率，市场规模从 2024 年的 254 亿美元稳步增至 2034 年的 275 亿美元。这一增长的核心驱动因素包括两方面：一是非肿瘤坏死因子 (TNF) 类生物制剂（如 IL-17 抑制剂、IL-23 抑制剂）的临床渗透率持续提升；二是以 icotrokinra 为代表的、具有差异化作用机制的新型口服药物陆续上市，进一步丰富治疗选择。
- 其中，IL-23 抑制剂凭借显著疗效、相较于 IL-17 抑制剂更具优势的给药便利性及良好的安全性，预计将继续稳居市场主导地位。
- 值得关注的是，以 icotrokinra 为代表的新型口服药物，将成为推动中重度斑块状银屑病患者治疗覆盖率与销售额增长的关键力量：该领域患者治疗覆盖率预计从 2024 年的 17.6% 提升至 2034 年的 19.4%，对应销售额有望在 2034 年达到 246 亿美元。
- 具体来看，icotrokinra 依托强效的 IL-23 受体靶向阻断机制，叠加相较于注射类生物制剂更便捷的口服剂型优势，预计将在 2034 年成为银屑病领域处方量最大的口服治疗药物。
- 此外，随着 icotrokinra 的上市与市场普及，叠加艾伯维旗下喜开悦®（瑞莎珠单抗）已建立的坚实销售基础，IL-23 抑制剂赛道的市场竞争力将进一步强化。预计到 2034 年，该类药物将超越银屑病领域所有其他生物制剂，在主要市场的销售额将达到 128 亿美元。

lcotrokinra 填补了哪些治疗空白？

尽管已上市的注射类 IL-23 抑制剂已将给药周期从每周一次延长至三个月一次，但医患双方对每年一次的长效治疗方案仍存在明确偏好。lcotrokinra 凭借口服给药的核心优势，有望精准满足这一需求：提供更便捷的治疗选择，减轻患者的治疗负担与就医频次压力。不过，口服疗法目前市场渗透率仍较低，核心原因在于其疗效与安全性尚未达到生物制剂的现有水平。尽管如此，lcotrokinra 通过与颌狄多开展头对头临床试验，仍

有望证明其在不引发严重副作用的前提下，可实现与生物制剂相当的疗效缓解。

此外，科睿唯安采访的 KOL 指出，一款临床疗效确切的 IL-23 抑制剂不仅能获得患者广泛青睐，还可助力患者更顺畅地从其他口服疗法切换至该方案；KOL 进一步强调，相较于颌狄多，lcotrokinra 的适用范围更广泛，可覆盖更多中重度斑块状银屑病患者群体。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

未来十年，随着多款新药陆续上市，中重度银屑病靶向治疗市场竞争将日趋激烈，形成涵盖生物制剂及靶向口服疗法（如欧泰乐[®]（阿普米司特，安进）、颌狄多）的成熟治疗布局。在此格局下，包括 lcotrokinra 在内的新一代疗法，必须展现出明确的临床差异化优势，才能

打破现有成熟生物制剂的市场壁垒，推动皮肤科医生优先选择口服制剂。值得注意的是，lcotrokinra 在第 16 周的 PASI 90 应答率相对较低，这可能使皮肤科医生认为皮下注射类 IL-23 抑制剂疗效更优，进而直接限制其在重度银屑病患者中的处方推广。

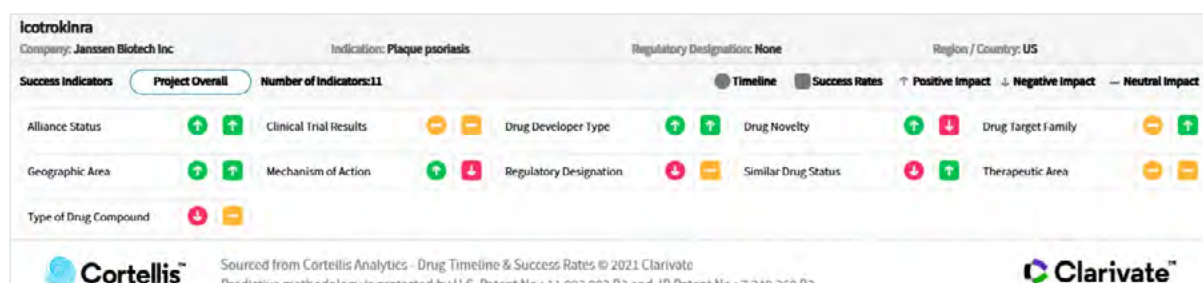
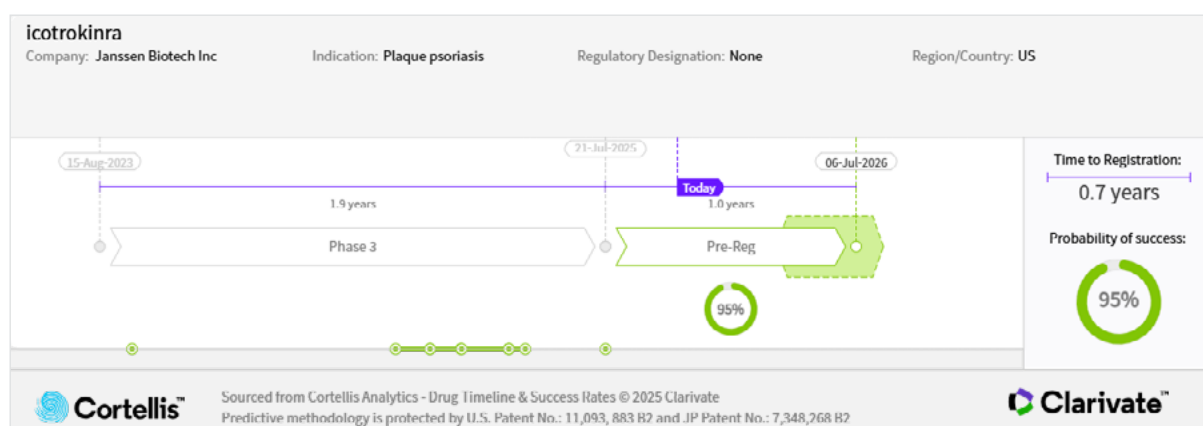
15 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“我认为 icotrokinra 是目前最具前景的在研口服银屑病治疗药物。其不仅疗效显著，且安全性特征良好。该药预计将用于阿普米司特治疗之后的序贯治疗场景，并有潜力替代 TNF- α 抑制剂、司库奇尤单抗等生物制剂。随着 icotrokinra 的上市与市场普及，颌狄多的临床应用占比可能会有所下降。”

皮肤科医生，来自日本

Cortellis 数据表明，icotrokinra 在美国注册成功的概率为 95%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [icotrokinra](#) 页面。

VOYXACT[®] (sibeprenlimab)

免疫球蛋白 A 肾病 (IgAN)

填补罕见病治疗缺口



如需获取最新动态，请访问 [VOYXACT](#) 页面。

生产商 - 大冢制药株式会社 类型 - 靶向 APRIL（增殖诱导配体）的单克隆抗体 用法 - 每 4 周一次皮下注射，用于治疗免疫球蛋白 A 肾病 (IgAN) - 同时正在评估其用于治疗干燥综合征	影响 约 52.8 万 2025 年 G7 市场 IgAN 终生患病的确诊病例数约为 52.8 万例	审批状态 2024 年 2 月： - 突破性疗法认定：美国 FDA 2025 年 3 月： - BLA 提交：美国 FDA 2025 年 5 月： - 优先审评：美国 FDA 2025 年 11 月 25 日： - 加速批准：美国 FDA（降低存在疾病进展风险的原发性免疫球蛋白 A 肾病 (IgAN) 成人患者的蛋白尿水平） 实际和预期上市时间 2026 年：美国 2028 年：日本 2029 年：欧盟
--	---	--

VOYXACT 是一款同类首创新型选择性 APRIL 抑制剂，有望成为 IgA 肾病 (IgAN) 治疗领域具有重大影响的疾病修饰类药物。在迄今为止开展 IgA 肾病临床试验中，该药不仅在尿蛋白降幅方面展现出同类最优的疗效特征，更在各剂量范围内建立了良好的安全性数据，是推动 IgA 肾病治疗格局演进的核心治疗药物。

作为大塚制药首款获批上市的生物制品，它标志着该公司在开展目前规模最大的 IgA 肾病临床试验后，迎来了商业化进程的重要里程碑。

VOYXACT 靶向 IgA 肾病发病机制中的核心驱动因子增殖诱导配体 (APRIL)，通过减少半乳糖基缺陷 IgA1 (Gd-IgA1) 的产生及后续免疫复合物的形成发挥作用。凭借这一作用机制，该药突破传统单纯对症治疗的局限，直击疾病根本病因，从根源上遏制疾病进展。

为什么列为值得关注的药物？

VOYXACT 由大塚制药全资子公司 Visterra 设计并研发，通过降低 IgA 及 Gd-IgA1 水平，减少免疫复合物形成所需的底物。该药凭借积极的 II 期临床试验结果获得 FDA 突破性疗法认定，其 BLA 申请则进一步获确证性 III 期 VISIONARY 试验中期数据的关键支持。

VISIONARY 试验中期分析结果令人瞩目：治疗 9 个月时尿蛋白水平相比安慰剂降低 51.2%，这一数据创下目前 IgA 肾

病 III 期临床试验的最佳纪录，显著优于同类竞品。例如：TARPEYO[®]（布地奈德，旭化成旗下 Calliditas Therapeutics AB），9 个月时尿蛋白水平较安慰剂降低 31%；VANRAFIA[®]（阿曲生坦，诺华），9 个月时相比降低 36.1%；飞赫达（伊普可泮，诺华）。此外，该疗效指标也超过了未来潜在的竞争对手 atacicept (Vera Therapeutics)，后者的 III 期中期分析显示治疗 36 周时尿蛋白水平较安慰剂降低 42%。

全球 II 期研究：155 例 IgAN 成年患者

VOYXACT (低剂量 2 mg/kg、中剂量 4 mg/kg、高剂量 8 mg/kg) vs 安慰剂

主要终点：

- 第 12 个月时尿蛋白 / 肌酐比值 (UPCR) 变化：低剂量组较基线下降 47.2%、中剂量组降低 58.8%、高剂量组降低 62.0%、安慰剂组降低 20.0%

次要终点：

- 第 12 个月时估算肾小球滤过率 (eGFR) 较基线的最小二乘均值的变化情况：低剂量组 -2.7 ml/min/1.73 m²、中剂量组 -0.2 ml/min/1.73 m²、高剂量组 -1.5 ml/min/1.73 m²、安慰剂组 -7.4 ml/min/1.73 m²
- 不良事件：78.6% vs 71.1%

主要终点完成时间：

- 2023 年 5 月

研究完成时间：

- 2023 年 6 月
-

美国 II/III 期开放标签研究：600 例 IgAN 成年患者

VOYXACT (400 mg)

主要终点：

- 不良事件 (AEs)

次要终点：

- 第 12 个月、第 24 个月时的 eGFR
- 第 12 个月、第 24 个月时的 24 小时尿蛋白 / 肌酐比值 (UPCR)
- 第 12 个月、第 24 个月时的临床缓解情况
- 24 个月内慢性肾病的进展时间

预计主要终点及研究完成时间：

- 2028 年 12 月

VISIONARY (全球 III 期)：530 例接受最大耐受剂量标准治疗的 IgAN 成年患者

VOYXACT (400 mg) vs 安慰剂

主要终点：

- 第 9 个月时 24 小时 UPCR 变化情况：相比安慰剂组降低 51.2%

次要终点：

- 第 24 个月时 eGFR

不良事件：

- 治疗相关不良事件 (TEAEs) 发生率：76.3% vs 84.5%
- 严重治疗相关不良事件发生率：3.9% vs 5.4%

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 12 月
-

VISIONARY (全球 III 期)：530 例接受最大耐受剂量标准治疗的 IgAN 成年患者

VOYXACT (400 mg) vs 安慰剂

主要终点：

- 第 9 个月时 24 小时 UPCR 变化情况：相比安慰剂组降低 51.2%

次要终点：

- 第 24 个月时 eGFR

不良事件：

- 治疗相关不良事件 (TEAEs) 发生率：76.3% vs 84.5%
- 严重治疗相关不良事件发生率：3.9% vs 5.4%

预计主要终点及研究完成时间：

- 2026 年 12 月

VOYXACT 将如何影响免疫球蛋白 A 肾病市场？

- IgA 肾病治疗领域正持续扩容，新型靶向疗法（例如 VOYXACT、Vera Therapeutics 的 atacicept）陆续涌入市场，不仅丰富了临床治疗选择，更将重塑现有市场格局，行业竞争也随之日趋激烈。
- VOYXACT 凭借同类首创的选择性 APRIL 抑制优势、便捷的给药方式（每 4 周皮下注射，患者可居家自行操作），以及经临床试验证实的同类最优尿蛋白降低疗效，有望获得广泛临床应用。
- 此外，该药对 APRIL 的选择性靶向作用，具备潜在更优的安全性特征，可减少脱靶免疫效应。
- 若该药物实现预期临床应用，有望推动 IgA 肾病治疗整体市场规模扩容，而非仅对现有市场份额进行重新分配。这不仅因为更多患者将获得早期治疗机会，更核心的是其对因治疗的作用机制将推动 IgA 肾病治疗策略，从传统支持治疗为主，转变为对症治疗与对因治疗并重的联合治疗新模式。这一发展逻辑与改善全球肾脏病预后组织 (KDIGO) 2025 年发布的临床实践指南 (Floege 等人, 2025 年) 提出的“双重协同新策略”高度契合，即同时靶向疾病潜在的免疫介导驱动因素与由此引发的肾脏损伤, 实现“对因治疗 + 肾损伤管理”的协同干预。VOYXACT 通过选择性抑制 APRIL，从根源上干预疾病进展，高度适配这一策略，因此有望在疾病的更早阶段被纳入临床治疗。

VOYXACT 填补了哪些治疗空白？

IgA 肾病是一种进展性慢性肾脏疾病，即便采用当前疗效最佳的标准治疗方案，仍有大量患者会进展至终末期肾病 (ESKD)。根据《KDIGO 2025 临床实践指南》，IgA 肾病治疗目前聚焦于两大核心方向：一是管理肾单位丢失引发的后续后果，二是干预疾病的核心发病机制。当前多数治疗方案侧重控制血压和蛋白尿（二者均为肾单位丢失引发的典型后果），却未能针对 IgA 肾病免疫病理学的核心致病机制开展干预；而 sivecatorlimab 通过靶向参与 IgAN 发病

机制的细胞因子 APRIL，实现了对疾病的精准对因干预。VOYXACT 采用预充式注射器皮下注射给药，患者每 4 周可居家自行操作，无需为持续治疗频繁前往医院就诊。

相比已获批的 IgA 肾病靶向治疗药物，如 TARPEYO、FILSPARI® (sparsentan, Traveo Therapeutics)、FABHALTA 和 VANRAFIA，VOYXACT 便捷的给药方式将大幅降低治疗相关的就医负担，进而显著提升患者生活质量。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

真实世界数据及长期疗效与安全性数据，尤其是维持 eGFR 稳定性的长期疗效数据，是确保 VOYXACT 实现广泛临床应用的关键前提。在竞争日益激烈的市场中，相较于已获批药物及在研新兴疗法，VOYXACT 除要保持疗效优势外，还需在安全性、给药便利性及成本效益等方面构建差异化竞争力，形成独特的临床价值锚点。此外，要成功融入不断演进的治疗范式（如 KDIGO 2025

版指南中倡导的“双重协同新策略”），还需通过全面的医师教育、充分的真实世界证据积累，夯实临床应用基础，推动治疗理念落地。同时，由于靶向治疗药物普遍定价较高，该药或面临支付方的阶梯审核 (step-edits)，需通过严格的事前授权方可获得使用许可；若获批适应症仅限于高危患者群体，其可覆盖的患者规模将大幅缩减，直接限制市场渗透潜力。



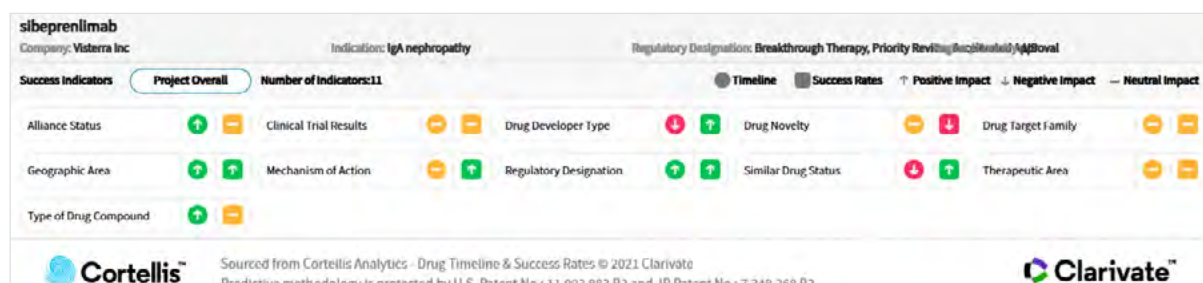
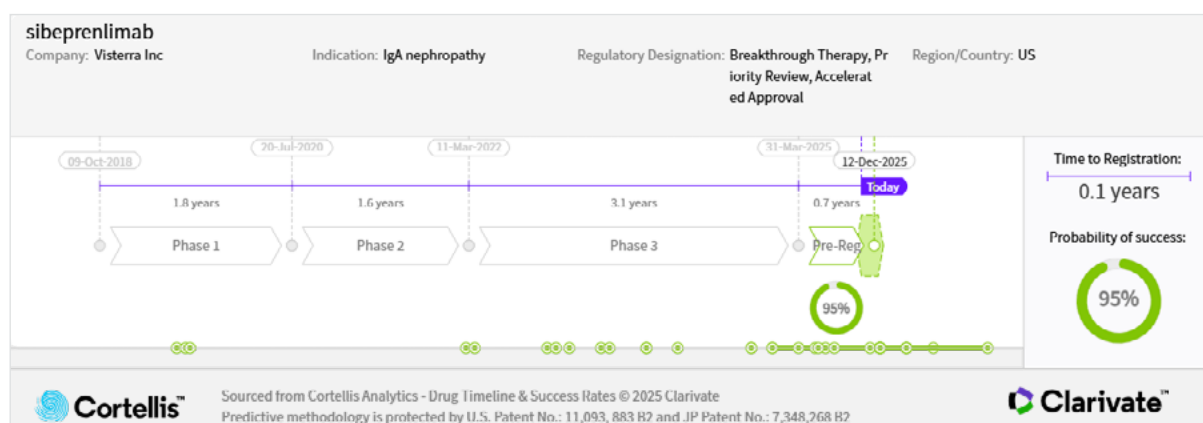
9.55 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“ APRIL 这一通路拥有坚实的遗传学证据支持，在靶向疾病核心发病机制的治疗领域中，堪称最具潜力的方向之一，我对这类靶向药物的临床前景充满期待。”

肾脏科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，VOYXACT 在美国注册成功的概率为 95%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [VOYXACT](#) 页面。

Tolebrutinib

多发性硬化症

填补罕见病治疗缺口

如需获取最新动态，请访问 [tolebrutinib](#) 页面。

生产商 - 赛诺菲 类型 - 布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 抑制剂 用法 - 每日一次口服给药，用于治疗非复发性继发进展型多发性硬化症 (nrSP-MS)	影响 约 22.9 万 2025 年 G7 市场 SP-MS 确诊病例数约为 22.9 万例	审批状态 2024 年 12 月： - 突破性疗法认定：美国 FDA 2025 年 3 月： - 优先审评：美国 FDA (nrSP-MS 及减缓成年患者与复发活动无关的残疾进展) 2025 年 12 月 15 日： - PDUFA 日期原定于 2025 年 12 月 28 日，现将推迟至 2026 年 实际和预期上市时间 2026 年：欧盟、美国 2027 年：日本
---	--	---

Tolebrutinib 是一款潜在的同类首创、可穿透血脑屏障的 BTK 抑制剂，专为治疗多发性硬化症 (MS) 研发。该药通过穿透血脑屏障，在中枢神经系统 (CNS) 中达到治疗有效暴露量，能够直接调控 B 淋巴细胞以及疾病相关的小胶质细胞——这两类细胞是引发持续性神经炎症、进而导致患者残疾进展的核心驱动因素。

这一创新机制使其显著区别于传统 MS 治疗药物（后者大多聚焦于外周炎症的调控）。MS 疾病领域仍存在巨大未满足医疗需求，**tolebrutinib** 通过靶向进展型 MS 的核心炎症病理过程，有望延缓神经退行性变，为该疾病的治疗带来变革性突破。

为什么列为值得关注的药物？

Tolebrutinib 有望成为首款获批用于治疗 nrSP-MS 的疗法。针对该患者群体开展的确证性 III 期 HERCULES 试验显示，该药具备显著疗效及可耐受的安全性特征，进一步印证了其差异化优势——靶向与复发无关的残疾进展机制。该关键研究结果为赛诺菲向美国 FDA 和欧盟 EMA 递交上市申请提供了核心支撑，预计欧盟地区的审批结果将于 2026 年第一季度公布。尽管 **tolebrutinib** 在

两项针对复发型 MS 的 III 期临床试验（GEMINI 1 和 GEMINI 2）中，未达到相较于奥巴捷®（特立氟胺，赛诺菲）降低年复发率 (ARR) 的主要终点，但仍成功将 6 个月确认残疾进展 (CDP) 的发生延缓了 29%，这一数据与 III 期 HERCULES 临床试验在 nrSP-MS 受试者群体中观察到的 31% CDP 延缓数据基本一致，进一步佐证了其延缓残疾进展的核心疗效。

GEMINI 1 与 GEMINI 2（全球 III 期）：
1,873 例复发性多发性硬化症患者

Tolebrutinib vs 奥巴捷

主要终点：

- 年复发率 (ARR)：0.12 vs 0.12（GEMINI 1 与 GEMINI 2 合并分析）
- 年复发率 (ARR)：0.13 vs 0.12 (GEMINI 1)
- 年复发率 (ARR)：0.11 vs 0.11 (GEMINI 2)

次要终点：

- 6 个月确认的残疾进展 (6mCDP)（基于扩展残疾状态量表 (EDSS) 评估）：29%（对比奥巴捷）
- 合并安全性数据：在各治疗组间均衡
- 肝酶升高：5.6% vs 6.3%

主要终点及研究完成时间：

- 2024 年 7 月

HERCULES（全球 III 期）：
1,131 例 nrSP-MS 成年患者

Tolebrutinib vs 安慰剂

主要终点：

- 6 个月确认的残疾进展 (6mCDP)：31%（对比安慰剂）

确认残疾改善率：

- 10% vs 5%

肝酶升高：

- 4.1%（对比安慰剂）

主要终点及研究完成时间：

- 2024 年 8 月

Tolebrutinib 将如何影响多发性硬化症市场？

- 目前，多发性硬化症 (MS) 治疗领域的在研管线活跃且多元化，多款药物正聚焦填补核心未满足的医疗需求。
- 随着 tolebrutinib、fenebrutinib (罗氏)、frexalimab (赛诺菲) 及 orelabrutinib (Zenas BioPharma 与北京诺诚健华) 等新型疾病修饰疗法的上市，MS 患者的药物治疗率将显著提升，这一趋势在进展型 MS 领域将更为突出。
- 预计到 2034 年，G7 国家市场中 BTK 抑制剂的销售额将突破 71 亿美元，其中约 29 亿美元来自进展型 MS 细分市场。
- Tolebrutinib 凭借其潜在的突破性治疗模式，有望重塑进展型 MS 的治疗格局，尤其是相较于注射剂型疗法，其口服给药方式所具备的便捷性，将成为核心竞争优势。
- 凭借在针对 nrSP-MS 治疗的 III 期 PERSEUS 临床试验中取得的里程碑式成功，tolebrutinib 在该患者群体中的应用前景备受行业看好；叠加同类首创的先发优势，预计该药将快速获得市场认可，并有望在 nrSP-MS 患者群体中占据最高市场份额。
- 上市后，tolebrutinib 将与罗可适[®] (奥瑞利珠单抗，罗氏 / 基因泰克) 展开直接竞争，并可能分流其部分销售额。目前，罗可适凭借广泛的适应症标签及先发优势，在 G7 国家 MS 药物治疗患者中占据 21% 的最高市场份额。

Tolebrutinib 填补了哪些治疗空白？

nrSP-MS 领域存在巨大的未满足治疗需求，核心原因在于该适应症目前尚无获批治疗药物。对于 nrSP-MS 患者而言，无复发并不代表残疾进展的停止，患者可能出现疲劳、认知功能下降、平衡与步态障碍、膀胱 / 肠道或性功能丧失等症状。这一现状凸显了临床对“直接作用于中枢神经系统、延缓疾病进展并改善生活质量”疗法的迫切需求。然而，现有 MS 治疗药物多靶向外周 B 细胞和 T 细胞，对中枢神经系统内的持续性神

经炎症及固有免疫活动（二者是残疾进展的关键驱动因素）在很大程度上未实现有效干预。Tolebrutinib 凭借穿透血脑屏障的特性，可直接调控中枢内的致病细胞（B 淋巴细胞与疾病相关小胶质细胞），精准填补了这一治疗空白。

此外，若 tolebrutinib 的适应症标签扩展至 涵盖“与复发无关的残疾进展”，该药将为复发型 MS 患者提供新的治疗选择，这一“非复发相关残疾进展”现

象在整个 MS 疾病谱系中均有存在。据科睿唯安采访的 KOL 表示，BTK 抑制剂或可开辟独特应用场景，例如罗可适治疗后的维持治疗，或用于罗可适治疗期间出现“无复发但出现残疾进展”的患者群体。不过在复发型多发性硬化症治疗领域，罗氏的 fenebrutinib 若能成功兑现其在复发预防和残疾进展延缓两大关键治疗目标上的潜力，则该药或有可能成为优于 tolebrutinib 的临床优选方案。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

Tolebrutinib 的商业化进程仍面临多重挑战，具体可归纳为以下几方面：首先，nrSP-MS 在整个 MS 市场中属于相对小众的适应症。因此在 tolebrutinib 适应症标签完成扩展前，这一局限或将限制其初期销售额的增长。其次，即便在 nrSP-MS 领域，tolebrutinib 的市场机会也可能遭遇竞品冲击，不仅有靶向 CD40L 的单克隆抗体 frexalimab 等不同机制药物的竞争，还面临同类 BTK 抑制剂的后期挑战，如诺诚健华与 Zenas BioPharma 合作开发的奥布替尼，已进入 PP-MS 和 nrSP-MS 的 III 期临床试验阶段。

再次，BTK 抑制剂类药物在注册临床试验中曾多次因肝损伤问题遭遇临床暂停。尽管 tolebrutinib 是同类中首个针对 MS 提交上市申请的药物，但在更多数据充分验证其风险 - 获益平衡前，临床医师可能对处方该药持谨慎态度。不过，fenebrutinib（罗氏）和 remibrutinib（诺华）后续公布的试验数据，有望为 BTK 抑制剂类药的整体安全性提供佐证。

另外，FDA 还推迟了该药的 PDUFA 审批日期，原因是赛诺菲在审评期间递交的补充数据分析资料，被 FDA 认定为新药申请的“重大修订”；2025 年 12 月，审评日期再度延期，赛诺菲预计将

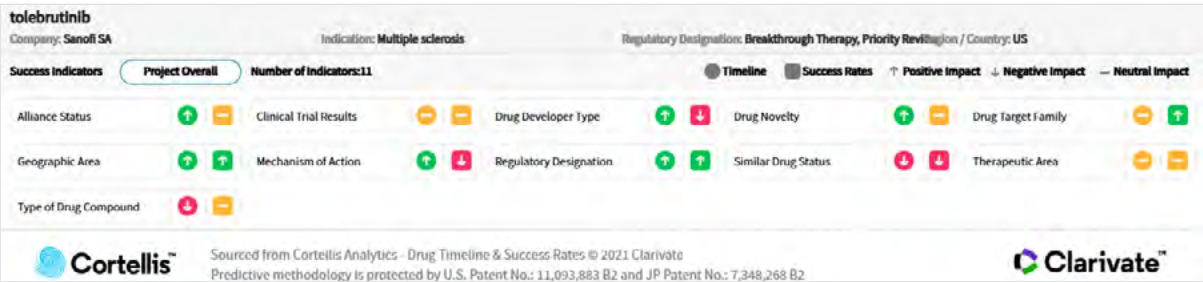
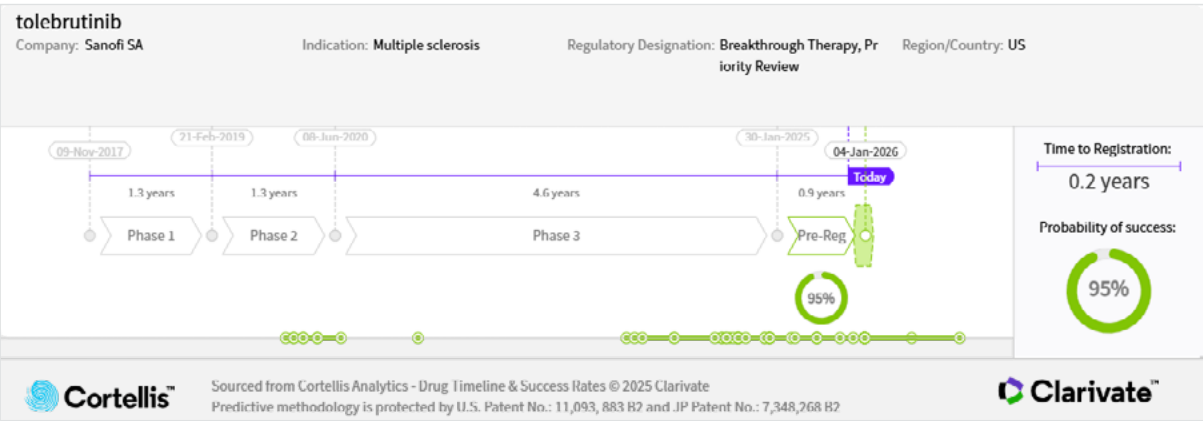
在 2026 年第一季度收到 FDA 的进一步指导意见。除 nrSP-MS 适应症的新药申请被 FDA 延期外，根据 PERSEUS 的 III 期临床试验的失败结果，赛诺菲还决定终止推进 tolebrutinib 用于 PP-MS 治疗的监管注册申请。这项纳入 767 名成年 PP-MS 患者的全球 III 期临床试验结果显示，与安慰剂相比，tolebrutinib 未能显著降低患者的 6 个月确认残疾进展 (CDP) 风险。综合来看，尽管上述一系列进展将制约 tolebrutinib 的商业化潜力，但该药若最终获批 nrSP-MS 适应症，仍有望跻身重磅炸弹级药物行列，并切实满足该患者群体亟待解决的重大未满足医疗需求。

由于 PERSEUS III 期临床试验结果在 2025 年底才公布，相关销售预测正进行修订，并将同步更新至“[tolebrutinib](#)”页面。

“ 这款药物在更难治疗的 MS 患者群体中展现出疗效，且其疗效与一线标准治疗药物特立氟胺相当，这一点极具价值。 ”

神经科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，[tolebrutinib](#) 在美国注册成功的概率为 95%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [tolebrutinib](#) 页面。

03

蛋白降解剂重塑肿瘤靶向治疗疆界

为攻克传统疗法难以触及的疾病，制药行业持续探索针对“不可成药”蛋白的新型策略。这类蛋白的表面往往缺乏可供传统小分子药物结合、具有可成药性的结合口袋。

靶向蛋白降解 (TPD) 技术是其中极具潜力的方向，其核心机制是利用细胞自身的蛋白降解系统，选择性下调或清除致病性蛋白。

[点击此处预约网络研讨会：《高山景行，长风破浪——2026 年全球和中国最值得关注的药物》](#)

尽管蛋白降解剂已在临床应用近 70 年，但其作用机制长期未能明确。最具代表性的分子胶类药物沙利度胺 (thalidomide)，其分子靶点与作用模式直至近 20 年才得以阐明。如今，蛋白水解靶向嵌合体 (PROTACs) 与分子胶降解剂 (MGDs) 实现快速发展，已成为该领域研究最广泛、临床进展最领先的两大技术方向。

2024 年，靶向蛋白降解剂领域的合作交易数量突破两位数，显示出行业对该技术颠覆难治性疾病治疗格局的坚定信心。2024 年已披露的近 20 笔研究合作及早期授权交易，总金额最高可达 132.5 亿美元。其中，总部位于波士顿的 Monte Rosa Therapeutics 表现突出，于 2024 年与诺华达成一项价值 22.5 亿美元的研发与商业化授权协议 (Osborne, 2024c)。

基础技术创新的竞争态势同样白热化，美国与中国的专利申请量处于全球领先地位（图3）。根据 Cortellis 数据，过去10年（2016年-2025年8月15日），全球范围内针对 PROTACs、MGDs 及 E3 泛素连接酶相关专利共计 717 项，其中美国机构申请 319 项（占比 44.5%），中国机构申请 265 项（占比 37%），位列全球第二。

机构层面的专利竞争中，总部位于纽黑文的 Arvinas 公司位居榜首（图4），其创新成果已转化为可观的商业价值。诺华与 Arvinas 达成全球研发与商业化协议，承诺支付最高 10.9 亿美元（含 1.5 亿美元预付款），以获得后者的 PROTAC 候选药物 RV-766 的相关权益，该药物是第二代雄激素受体（AR）降解剂，用于治疗前列腺癌（Osborne, 2024a）。

Arvinas 另一款进入后期研发阶段的候选药物 ARV-471 (vepedgestrant) 是一款靶向雌激素受体（ER）的 PROTAC 降解剂，正与辉瑞合作开展 ER 阳性乳腺癌的临床试验，其 PDUFA 日期已定为 2026 年 6 月 5 日（BioWorld, 2025a）。作为该领域的领军企业，Arvinas 在 2019 年便推出全球首个进入临床试验

的 PROTAC 药物 ARV-110，用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）（Mullard, 2019）。百济神州旗下的 BGB-16673 是一款靶向 BTK 的 PROTAC 降解剂，用于治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL），已展现出积极的临床结果。公司计划于 2026 年在全球范围内提交 BGB-16673 用于 CLL 的加速批准申请，预计 2027 年实现首次获批，该药也被纳入本报告“最值得关注的药物”名单。

学术与本土企业的创新同样活跃：密歇根大学近期披露的降解剂专利，涉及包含希佩尔-林道综合征（VHL 病）肿瘤抑制因子结合结构域与信号转导和转录激活因子 3（STAT3）靶向结构域的 PROTACs，有望覆盖多种适应症（BioWorld, 2025d）；与此同时，海思科医药近期获得 SMARCA2 降解诱导剂 PROTACs 相关专利，该技术据称对肺癌治疗具有潜在应用价值（BioWorld, 2025b）。

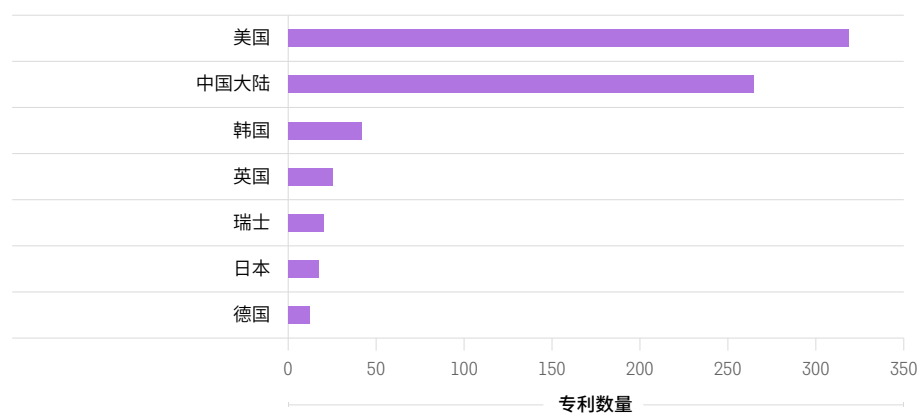
当前 MGDs 与 PROTACs 研发还面临诸多共性设计挑战，例如 MGDs 依赖不可预测的蛋白-蛋白相互作用，PROTACs 则因尺寸较大、结构复杂，在细胞渗透性、代谢稳定性及口服生物利用度方面

存在短板。为此，多家企业正推进下一代降解剂技术的研发，致力于解决这些痛点。

新一代降解剂包括：降解剂-抗体偶联物（DACs）：该技术以抗体药物偶联物（ADC）为基础，将有效载荷替换为降解剂，提升靶向递送效率；溶酶体靶向策略：内体-溶酶体途径靶向，如 Lycia Therapeutics 公司开发的溶酶体靶向嵌合体（LYTACs），正在开展治疗 IgE 介导疾病及格雷夫斯病（Graves' disease）的研究（BioWorld, 2025c）；自噬-溶酶体途径靶向：如 AUTOTAC Bio 公司开发的自噬靶向嵌合体（AUTOTAC），目前处于肿瘤治疗的研发阶段（BioWorld, 2024）。Cereblon E3 泛素连接酶调节剂（CELMoDs）：如被列入本报告“最值得关注的药物”之一的 mexigdomide（百时美施贵宝），可增强 cereblon 与其底物的结合能力，从而实现疾病相关靶点更强效、更快速的降解。

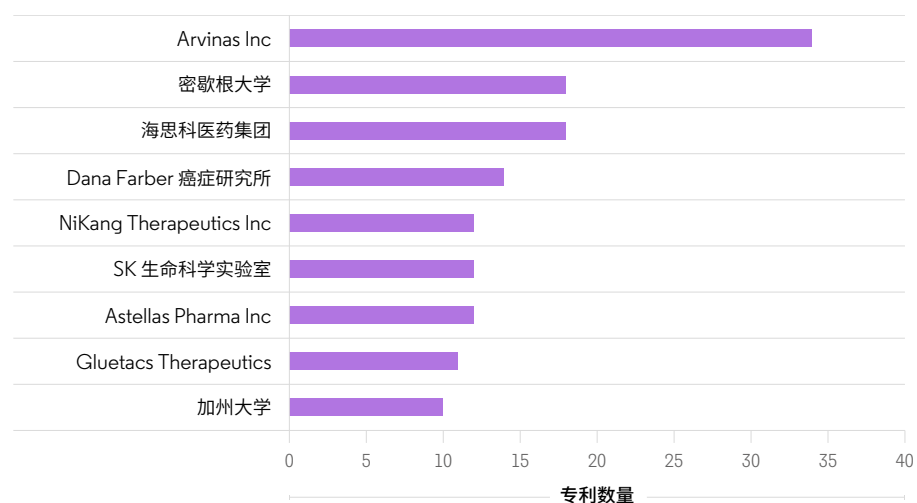
如需进一步了解靶向蛋白降解剂市场格局，请下载报告《[靶向蛋白质降解剂——利用细胞降解途径解决“不可成药”靶点](#)》。

图 3：过去 10 年全球 PROTACs、MGDs 及 E3 泛素连接酶相关专利申请量领先的国家 / 地区（>10 项专利；按首次公开日期统计；2016 年 -2025 年 8 月 15 日）



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库

图 4：过去 10 年全球 PROTACs、MGDs 及 E3 泛素连接酶相关专利申请量领先的机构（>10 项专利；按首次公开日期统计；2016 年 -2025 年 8 月 15 日）



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库

BGB-16673

慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤

重塑蛋白降解剂靶向治疗疆界

如需获取最新动态，请访问 [BGB-16673](#) 页面。

生产商 - 百济神州 类型 - 靶向 BTK 的嵌合式降解激活化合物 (CDAC) 用法 - 每日一次口服给药，用于治疗复发或难治性慢性淋巴细胞白血病 / 小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL) - 同时正在评估其用于以下适应症：复发或难治性华氏巨球蛋白血症 (WM)、套细胞淋巴瘤 (MCL) 和滤泡性淋巴瘤 (FL) 等其他复发性或难治性 B 细胞恶性肿瘤，以及慢性自发性荨麻疹 (CSU)	影响 约 3.4 万 2025 年 G7 市场既往接受治疗的 (二线及二线以上) CLL 和 SLL 新增病例数约为 3.4 万例	审批状态 2023 年 12 月： - 孤儿药资格认定：美国 FDA (MCL) - 快速通道认定：美国 FDA (复发或难治性 MCL) 2024 年 8 月： - 快速通道认定：美国 FDA (既往接受过 ≥ 2 种治疗 (包括 BTK 抑制剂和 BCL-2 抑制剂) 的 R/R CLL/SLL 患者) 2024 年 12 月： - 孤儿药资格认定：美国 FDA (WM 和 FL) 2025 年 7 月： - 优先审评药物 (PRIME) 认定：欧盟 EMA (既往接受过 BTK 抑制剂治疗的 WM 患者) 实际和预期上市时间 2027 年：欧盟、美国 2029 年：日本
--	--	--

BGB-16673 是一款潜在首创性 (first-in-class) 蛋白降解剂，旨在促进野生型及突变型布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 的降解，包括那些在疾病进展中常见的耐药性突变型 BTK。

早期临床数据已验证 BGB-16673 在临床前研究中展现的优异特征，若能成功获批，该药有望成为 B 细胞恶性肿瘤领域的变革性治疗方案。尽管其针对 CLL/SLL 的研发推进最为迅速，但也要看到，该药具备降解野生型及耐药突变型 BTK 的双重核心优势，对血液系统肿瘤多个适应症均展现出了治疗活性。

为什么列为值得关注的药物？

布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 是淋巴系统恶性肿瘤的核心驱动因子，与传统 BTK 抑制剂仅通过抑制 BTK 蛋白活性发挥作用的模式不同，BGB-16673 以诱导 BTK 蛋白降解为核心作用机制。基于这一独特机制优势，其 I/II 期 CaDAnCe-101 研究的临床试验结果备受行业关注。早期数据显示，BGB-16673 在 BTK 野生型及突变型疾病中均展现出良好的安全性、耐受性及初步抗肿瘤活性。百济神州计

划基于 CaDAnCe-101 研究数据，将于 2026 年在全球范围内提交 BGB-16673 治疗慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 的加速批准申请，预计 2027 年实现首次获批；同时，针对华氏巨球蛋白血症 (WM) 的注册临床试验也已进入规划阶段。

目前，多项 I/II 期及 III 期临床试验正在持续推进，进一步系统评估 BGB-16673 在多个适应症中的安全性与有效性。

CaDAnCe-101 (全球 I/II 期) : B 细胞恶性肿瘤患者 (含滤泡性淋巴瘤 (FL)、WM、复发 / 难治性 CLL/SLL、复发 / 难治性 MCL), 均接受过至少 2 线治疗

BGB-16673 剂量递增及扩展阶段

主要终点 :

- 客观缓解率 (ORR)
- 不良事件发生人数 (AEs)
- 最大耐受剂量 (MTD)/ 最大给药剂量 (MAD)
- 扩展阶段推荐剂量

既往接受过 ≥ 2 线治疗后复发或难治性患者中期分析结果 :

- ORR
 - CLL/SLL: 85.3% (包括既往接受共价 / 非共价 BTK 抑制剂、BCL-2 抑制剂治疗的患者, 以及伴 / 不伴 BTK 突变、17p 缺失 (del(17p))、TP53 突变的患者)
 - WM : 85.7%, (包括既往接受共价 / 非共价 BTK 抑制剂治疗的患者, 以及伴 / 不伴 BTK 突变、TP53 突变的患者)
 - FL : 37.5%
- 首次缓解的中位时间
 - CLL/SLL : 2.8 个月
 - WM : 1.0 个月
 - FL : 2.7 个月
- ≥ 3 级 TEAEs
 - CLL/SLL : 61.8%
 - WM : 61.9%
 - FL : 20.8%

预计主要终点完成时间 :

- 2026 年 11 月

预计研究完成时间 :

- 2029 年 11 月

CaDAnCe-302 (全球 III 期) : 250 例既往接受过 BTK 抑制剂和 BCL-2 抑制剂治疗的复发或难治性 CLL/SLL 患者

BGB-16673 单药治疗 vs 研究者选择的治疗方案 :

- Idelalisib + 利妥昔单抗
- 苯达莫司汀 + 利妥昔单抗
- 维奈克拉 + 利妥昔单抗

主要终点 :

- 无进展生存期 (PFS)

预计主要终点完成时间 :

- 2028 年 5 月

预计研究完成时间 :

- 2030 年 2 月

CaDAnCe-303（仅限中国进行的 III 期）：150 例既往接受过共价 BTK 抑制剂治疗的复发或难治性 CLL/SLL 患者

BGB-16673 单药治疗 vs 研究者选择的治疗方案：

- 苯达莫司汀 + 利妥昔单抗
- 利妥昔单抗 + 高剂量甲泼尼龙

主要终点：

- 无进展生存期 (PFS)

预计主要终点及研究完成时间：

- 2029 年 11 月

CaDAnCe-304（全球 III 期临床试验）：500 名既往接受过共价 BTK 抑制剂治疗的复发或难治性 CLL/SLL 患者

BGB-16673 单药治疗 vs 捷帕力®（匹妥布替尼，礼来）

主要终点：

- 无进展生存期 (PFS)

预计主要终点及研究完成时间：

- 2028 年 4 月



BGB-16673 将如何影响慢性淋巴细胞白血病 / 小淋巴细胞淋巴瘤治疗市场？

- 慢性淋巴细胞白血病 / 小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL) 是非霍奇金淋巴瘤 (NHL) 治疗市场中规模最大的细分领域，全球主要市场的 CLL/SLL 治疗药物销售额预计将从 2024 年的 120 亿美元增长至 2029 年的峰值 152 亿美元。这一增长的核心驱动力源于人口老龄化推动的 CLL/SLL 发病率上升——未来 10 年，该疾病发病率预计将提升 17.5%。当前，BTK 抑制剂已主导主要市场的 CLL/SLL 药物销售，2024 年市场占比超 75%；尽管预计 2028 年起共价 BTK 抑制剂销售额将因仿制药冲击出现大幅下滑，但 BGB-16673 的新型 BTK 靶向机制（诱导蛋白降解），有望助力 BTK 靶向疗法在 2034 年前持续维持 CLL/SLL 治疗领域销售额领先的地位。
- 我们预计，BGB-16673 有望成为复发 / 难治性 (R/R) CLL/SLL 的核心治疗选择：该药将先获批用于三线及以上后线治疗场景，后续依托其与当前标准治疗方案头对头对比的 III 期研究数据，进一步拓展至二线治疗场景。BGB-16673 采用每日给药方案，直至疾病进展或患者出现不可耐受毒性。鉴于其治疗周期较长，且 R/R CLL/SLL 市场规模呈显著且持续的增长态势，这两大因素将共同推动该药实现强劲销售额。
- 此外，百济神州正在 I/II 期 BGB-16673-104 研究中，探索用于多种 R/RB 细胞恶性肿瘤治疗的 BGB-16673 联合用药方案。联用的药物包括百济神州自研的共价 BTK 抑制剂百悦泽（泽布替尼）、在研 BCL-2 抑制剂 sonrotoclax，以及基因泰克 (Genentech) 的 CD20/CD3 双特异性抗体皓罗华（莫妥珠单抗）与高罗华 (glofitamab)。这一研发方向或将推动以 BGB-16673 为基础的联合疗法广泛应用于多个 B 细胞恶性肿瘤领域，进一步巩固其在血液肿瘤领域的核心市场地位。

BGB-16673 填补了哪些治疗空白？

目前，二线及三线难治性 CLL/SLL 患者（既往接受过共价 BTK 抑制剂、BCL2 抑制剂和 / 或非共价 BTK 抑制剂治疗的患者群体）的治疗选择极为有限，构成该领域的核心未满足医疗需求。目前的共价 BTK 抑制剂在临床应用中易诱导耐药突变，进而导致 CLL/SLL、WM 及 MCL 等患者出现疾病进展；尽管非共价 BTK 抑制剂捷帕力 (Jaypirca) 在既往接受过共价 BTK 抑制剂治疗的患者中展现出较高的缓解率，但仍存在缓解

持续时间短、后续治疗选择匮乏的显著短板。相比之下，BGB-16673 凭借可同时降解野生型及突变型 BTK 的双重能力，对多种耐药相关 BTK 突变均具有明确抑制活性的作用，有望为广大复发 / 难治性 (R/R) 患者提供新型且有效的口服治疗选择。这一独特机制不仅可与非共价 BTK 抑制剂形成临床互补，还能在疗效持久性上具备更显著优势，进而为其奠定面向广阔市场的商业基础。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

若想在复发 / 难治性 (R/R) 疾病的早期治疗场景中站稳脚跟，并覆盖规模更大、商业价值更高的患者群体，BGB-16673 与非共价 BTK 抑制剂的头对头对比数据至关重要，例如针对匹妥布替尼开展的 CaDAnCe-304 头对头研究。III 期研究的安全性表现将直接决定 BGB-16673 的市场渗透能力，尤其需重点关注早期临床试验中已观察到的 ≥ 3 级毒性反应

(如中性粒细胞减少症)。若 III 期数据未能体现更优的安全性优势，或将显著限制其临床推广与应用。当前 BTK 靶向治疗领域竞争格局拥挤，且治疗成本居高不下，支付方在报销谈判中大概率会要求提供充分的成本 - 效益证据。这一要求将直接对 BGB-16673 的市场准入进程及定价策略构成核心挑战，影响其市场覆盖速度与规模。

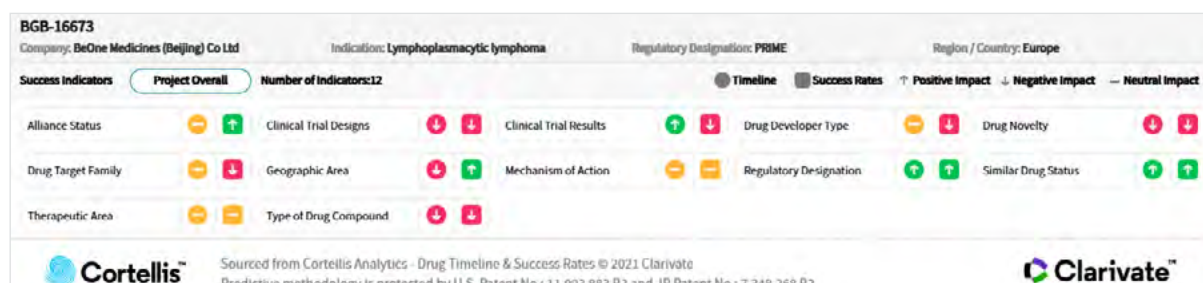
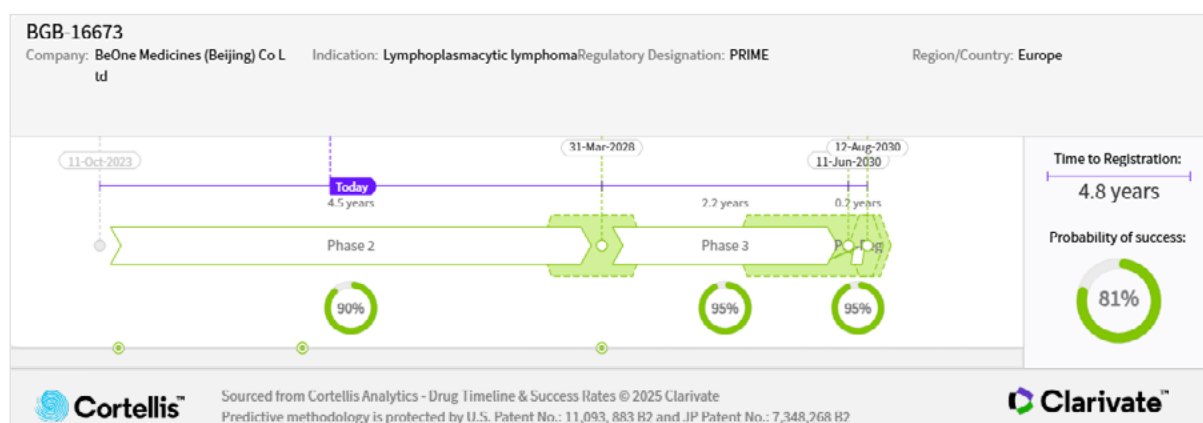
11.9 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“ BGB-16673 有望成为 CLL/SLL 治疗领域的革命性突破。其疗效令人印象深刻，尤其是针对二线及三线难治性患者群体，且安全性特征与现有 BTK 抑制剂基本一致。总体而言，我对该药物的整体评价十分积极。”

血液肿瘤科医生，来自意大利

Cortellis 数据表明，BGB-16673 在欧盟注册成功的概率为 81%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [BGB-16673](#) 页面。

Mezigdomide

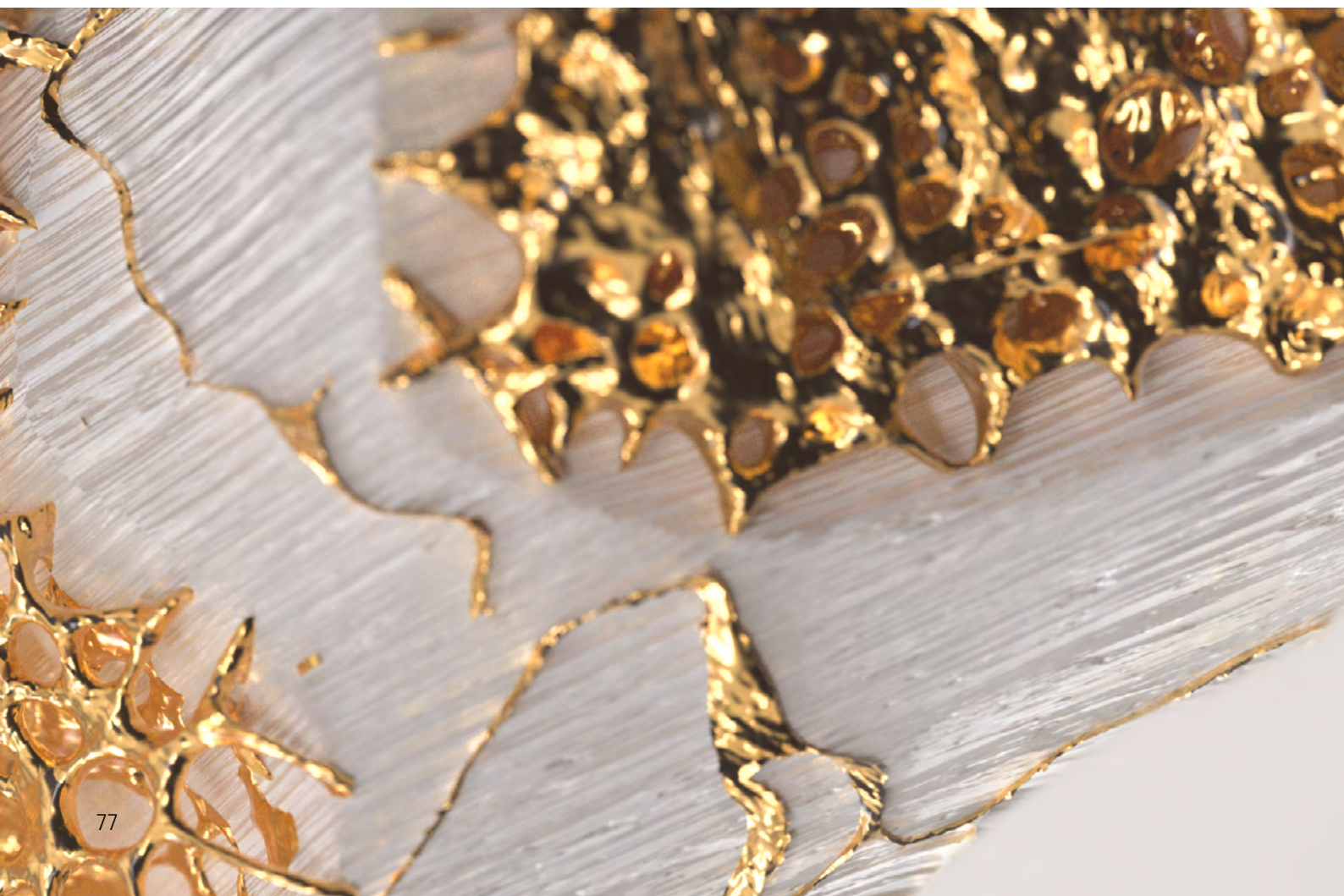
多发性骨髓瘤

重塑蛋白降解剂靶向治疗疆界



如需获取最新动态，请访问 [mezigdomide](#) 页面。

生产商 百时美施贵宝	影响 约 9.4 万 2025 年 G7 市场复发或难治性多发性骨髓瘤（二线至七线）新增病例数约为 9.4 万例	审批状态 截至目前尚无监管审评和批准活动
类型 Cereblon E3 泛素连接酶调节剂 (CELMoD)		实际和预期上市时间 2026 年：美国 2027 年：欧盟、日本
用法 口服给药，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤 (R/R MM)		预计专利到期时间 专利预计从 2040 年开始陆续到期



Mezigdomide 是一款第二代 cereblon E3 泛素连接酶调节剂 (CELMoD)，可以降解造血细胞发育与分化过程中的关键转录因子 Ikaros 和 Aiolos，兼具抗骨髓瘤活性与免疫刺激双重作用。

目前，mezigdomide 正通过两项全球 III 期临床试验，评估其与其他已获批疗法（如安进的凯洛斯 [卡非佐米]、地塞米松）联合治疗晚期多发性骨髓瘤患者的疗效与安全性。基于 I/II 期临床试验的积极结果，该药有望为既往接受过免疫调节药物 (IMiDs) 治疗的复发 / 难治性多发性骨髓瘤患者带来全新治疗选择。

为什么列为值得关注的药物？

为应对可预见的仿制药竞争，mezigdomide 是百时美施贵宝生命周期管理战略的核心组成部分，旨在替代 IMNOVID/POMALYST（泊马度胺）。该公司另一款在研多发性骨髓瘤药物 iberdomide 被定位为瑞复美（来那度胺）的更具耐受性替代方案。而 mezigdomide 则聚焦于成为泊马度胺的强效替代药物，主攻骨髓瘤后期治疗线及难治性患者群体，包括对来那度胺、泊马度胺等现有免疫调节药物 (IMiDs) 产生耐药的患者。

I/II 期临床试验的积极结果为这一战略定位提供了坚实支撑，进而推动 mezigdomide 进入关键性 III 期研究阶段。其中，I/II 期 MM-001 研究展现出显著疗效，即便对 3 种药物（IMiDs、蛋白酶体抑制剂和抗 CD38 抗体）产生耐药性的 R/R MM 患者仍能展现治疗活性。此外，该药在既往耐药的患者中仍保持显著活性，且与其他标准治疗药物具有明确协同作用。

MM-001（全球 I/II 期）：201 例既往接受过至少三线治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤患者

Mezigdomide + 地塞米松

主要终点：

- 客观缓解率 (ORR)：41%
- 最大耐受剂量 (MTD)：29% 的患者因治疗相关不良事件 (TRAEs) 需降低剂量
- 药代动力学特征
- 安全性：77% 的患者出现中性粒细胞减少，65% 发生感染

次要终点：

- 无进展生存期 (DOR)：中位 7.6 个月
- 无进展生存期 (PFS)：中位 4.4 个月

MM-002（全球 I/II 期）：424 例既往接受过至少一线治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤患者

治疗方案：mezigdomide + 以下药物：

- 万珂[®]（硼替佐米，强生 / 千禧制药）+ 地塞米松（A 队列、D 队列）
- 凯洛斯（卡非佐米）+ 地塞米松（C 队列）
- EMLICITI（elotuzumab，百时美施贵宝）+ 地塞米松
- 赛可益（艾沙妥昔单抗，赛诺菲）+ 地塞米松
- 兆珂（达雷妥尤单抗，强生）+ 地塞米松

	A 队列（既往中位治疗线数：3 线）	C 队列（既往中位治疗线数：2 线）	D 队列（既往中位治疗线数：1 线）
主要终点			
ORR	75%	85.2%	85.7%
次要终点			
中位 PFS	12.3 个月	13.5 个月	17.5 个月
中位 DOR	10.9 个月	11.9 个月	19.4 个月
安全性			
因不良事件（AEs）导致的停药率	7.1%	14.8%	—

SUCCESSOR-1 (III 期) : 既往接受过一至三线治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤患者

Mezigdomide + 万珂 + 地塞米松 vs IMNOVID/POMALYST + 万珂 + 地塞米松

主要终点 :

- 无进展生存期 (PFS)

次要终点 :

- ORR
- 总生存期 (OS)
- 完全缓解 (CR) 率
- 微小残留病 (MRD) 阴性率
- 健康相关生活质量 (HR-QOL)

预计主要终点完成时间 :

- 2025 年 11 月

预计研究完成时间 :

- 2033 年 11 月

SUCCESSOR-2(III 期) : 既往接受过至少一线治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤患者

Mezigdomide + 凯洛斯 + 地塞米松 vs 凯洛斯 + 地塞米松

主要终点 :

- 无进展生存期 (PFS)

次要终点 :

- ORR
- 总生存期 (OS)
- 完全缓解 (CR) 率
- 微小残留病 (MRD) 阴性率
- 健康相关生活质量 (HR-QOL)

预计主要终点完成时间 :

- 2026 年 2 月

预计研究完成时间 :

- 2029 年 7 月

Mezigdomide 将如何影响多发性骨髓瘤市场？

- 全球主要市场多发性骨髓瘤治疗药物的市场规模预计将从 2024 年的 217 亿美元增长至 2034 年的 425 亿美元，年复合增长率达 7.0%。
- 驱动市场增长的核心因素主要包括两方面：一是现有核心疗法的持续渗透，尤其是瑞复美 /REVLIMID、兆珂 /DARZALEX、双特异性抗体和 CAR-T 细胞疗法，其临床应用的持续普及与适应症向早期治疗线的拓展，将成为增长主力；二是新兴疗法的增量贡献，预计 2034 年该类疗法合计销售额将达 86 亿美元，整体贡献相对温和。
- 值得关注的是，复发 / 难治性多发性骨髓瘤细分市场（2-7 线治疗）的增长潜力更为突出：销售额预计将从 2024 年的 138 亿美元（占多发性骨髓瘤总市场的 64%）攀升至 2034 年的 295 亿美元（占总市场的 70%）；其中，二线治疗场景预计将在 2034 年成为最具商业价值的细分领域，销售额有望达到 126 亿美元。
- 在这一预测期内，多款新型疗法如能获批，将丰富复发 / 难治性多发性骨髓瘤的治疗选择，具体包括：CELMoD 类药物 mezigdomide 和 iberdomide，百时美施贵宝的 CAR-T 细胞疗法 arlocabtagene autoleucel，吉利德旗下 Kite 公司与 Arcellx 联合开发的 anitocabtagene autoleucel 等。然而，由于二线及以上治疗场景目前缺乏明确的优选药物共识，这些新型疗法上市后或将面临白热化的市场竞争。

Mezigdomide 填补了哪些治疗空白？

多发性骨髓瘤是全球第二大常见血液系统恶性肿瘤，预后欠佳，且随疾病进展，患者缓解期逐步缩短，治疗挑战性显著提升，而有效治疗选择却相对有限。相较于传统免疫调节药物（IMiDs），CELMoD 类药物可增强 cereblon 与其底物的结合亲和力，进而更强效、快

速地降解疾病驱动靶点。作为第二代 CELMoD，mezigdomide 凭借这一机制优势，有望攻克现有标准治疗（含 IMiDs 方案）的耐药瓶颈，为对 IMiDs、蛋白酶体抑制剂等药物耐药的复发 / 难治性患者，提供全新、有效的治疗选择。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

首先，多发性骨髓瘤后期治疗市场竞争日益激烈，新型治疗手段的持续涌现，进一步挤压了存量市场空间，mezigdomide 需在激烈竞争中凸显差异化优势。其次，医生对新型作用机制疗法的初期接受度可能受限。作为具有独特作用机制的第二代 CELMoD，mezigdomide 初期可能因医生对其临床应用场景、疗效特征的熟悉度不足，影响处方渗透率的快速提升。再者，需直面泊马度胺的直接竞争压力。泊马度胺仿制药已在欧洲正式上市，预计 2026

年 3 月进入美国市场，其显著的价格优势，或将分流 mezigdomide 的目标患者群体。最后，监管批准存在不确定性。含 mezigdomide 的治疗方案能否顺利获批，取决于其在 III 期 SUCCESSOR-1 和 SUCCESSOR-2 两项关键试验中能否证明优越性（相较于现有标准治疗），且安全性与耐受性需达到临床可接受水平。而目前，试验相关数据尚未公布，直接为其监管审批进程带来一定的不确定性。

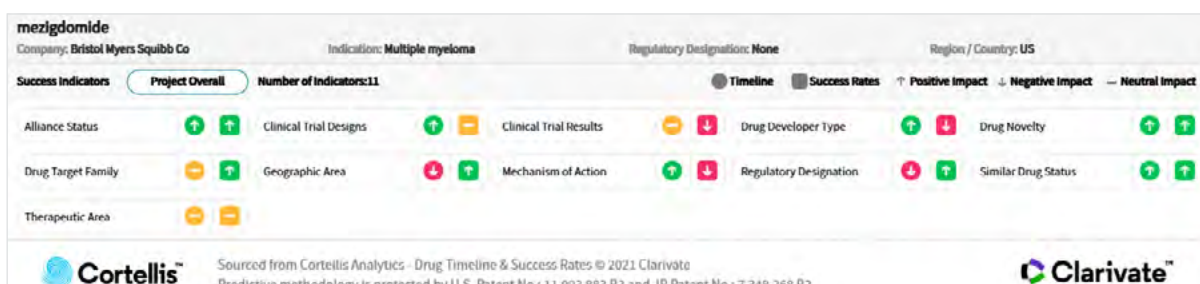
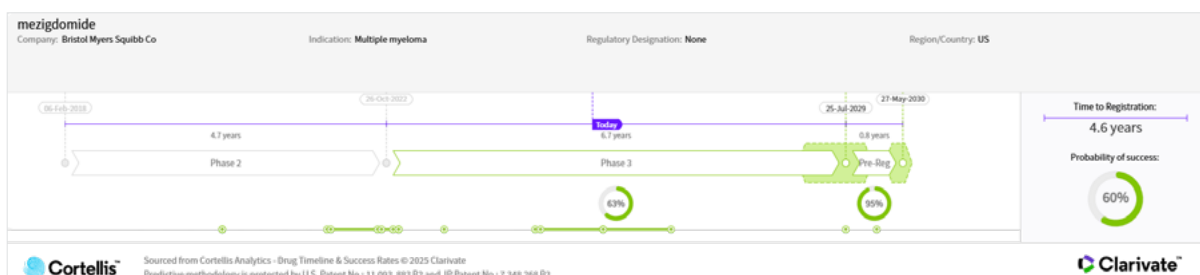
14.7 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“ mezigdomide 在髓外病变的多发性骨髓瘤患者中已展现出十分显著的疗效。此外，在 BCMA 靶向治疗后进展的患者群体中，我们对 mezigdomide 和 iberdomide 开展了相关评估，结果显示这两款药物均具备明确的治疗活性。”

血液肿瘤科医生，来自西班牙

Cortellis 数据表明，mezigdomide 在美国注册成功的概率为 60%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 11 月 4 日。

如需获取最新动态，请访问 [mezigdomide](#) 页面。

04

构建女性健康研究新范式

“女性健康”这一术语不仅涵盖女性特有疾病，还包括那些对女性影响更为显著、病理机制上与男性存在性别差异的疾病。

这一认知推动了相关框架的建立，用于区分不同类型的女性健康相关疾病，例如美国国立卫生研究院 (NIH) 制定的框架，将女性健康研究项目划分为四大类别：(1) 女性特有疾病；(2) 相比男性，女性中更常见和 / 或发病率更高的疾病；(3) 针对女性研究不足的疾病；(4) 女性发病率高的疾病 (Temkin 等，2023)。

[点击此处预约网络研讨会：《高山景行，长风破浪——2026 年全球和中国最值得关注的药物》](#)

长期以来，女性在健康研究和资金支持中未能获得平等对待，导致了性别偏见与相关疾病的认知局限。而改变这种认知的努力，才刚刚开始。例如，尽管到 2014 年，美国国立卫生研究院 (NIH) 资助的所有临床试验中女性参与者约占一半，但她们的纳入比例并不能与疾病的

患病率或疾病负担水平相匹配 (Clayton 和 Collins，2014 年)。此外，许多对女性影响更为显著的疾病（包括头痛 / 偏头痛、认知障碍、精神疾病以及多种癌症），其获得的资金支持与其造成的疾病负担并不匹配，仍存在资金不足的问题 (Smith，2023 年)。

在本节介绍的药物治疗相关癌症中，卵巢癌的全球发病率位列全球第 18 位，同时也是女性第八大常见癌症（世界卫生组织，2022 年）。然而，由于卵巢癌通常无明显症状且缺乏有效的筛查方案，实际发病率可能被低估。这也意味着全球大多数女性患者在确诊时，病情已处于转移阶段（Allemani 等，2025）。因此，卵巢癌在全球不同地区的五年净生存率差异较大：印度仅为 16%，哥斯达黎加则达到 57%（Allemani 等，2018）。从历史来看，该疾病领域的资金投入一直不足，尤其与该疾病的高死亡率极不相称。例如，前列腺癌每损失一人年寿命对应的平均资助额为 180 万美元，而卵巢癌仅为 9.7 万美元（Spencer 等，2019）。2016 至 2020 年间，在全球公共及慈善机构提供的 245 亿美元癌症研究资金中，卵巢癌仅获得其中的 2.1%，即 5.25 亿美元（McIntosh 等，2023 年）。

相比之下，乳腺癌则受益于大量研究资金支持，而且自 20 世纪 80 年代起，全球多国已推行乳腺癌人群筛查项目，并建立了完善、标准化的治疗指南与诊疗路径。因此，全球乳腺癌五年净生存率较高，从印度的 66% 到美国的 91% 不等（Allemani 等，2018）。在资金投入与致死率比值这一指标上，乳腺癌排名第二，仅次于前列腺癌研究（Spencer 等，2019 年）；2016 至 2020 年间，在全球公共及慈善机构提供的癌症研究资金中，乳腺癌获得其中的 11.2%，即 27 亿美元（McIntosh 等，2023 年）。如

今，新一代治疗药物更具个性化，能够靶向治疗曾经被认为无法治愈的乳腺癌亚型。

对于男女均会罹患的某些癌症，研究界与医学界逐渐认识到：在同等治疗条件下，女性的健康结局往往更差（Temkin，2023 年）。例如，膀胱癌女性患者的复发风险、疾病进展风险以及癌症特异性死亡风险均高于男性患者（Sung 等，2021 年）。这一差异部分原因可归结于女性确诊年龄偏大，而这可能与诊断延迟相关。血尿是促使人们接受膀胱癌检查的首要症状，但与男性相比，女性出现血尿后被转诊至泌尿科并接受膀胱镜检查的概率更低（Ark 等，2017 年；Garg 等，2014 年）。尽管雌激素在膀胱癌发病风险及其结局中的作用尚不明确，但初步研究结果显示，雌激素可能具有保护作用（Doshi 等，2023 年）；未来的研究也许能为进一步揭示性别特异性因素提供更多参考。

正如本节重点介绍的药物所示，对女性健康的关注度提升、围绕性别健康公平的监管框架完善，以及资金投入的持续增加，为制药企业提供了介入这一市场的契机，有望助力解决全球女性群体长期未被满足的健康需求。

如需进一步了解女性健康领域的市场格局，请下载报告 [《重新探索女性健康：2025 年最值得关注的公司》](#)。

Gedatolisib

乳腺癌

构建女性健康研究新范式

如需获取最新动态，请访问 [gedatolisib](#) 页面。

生产商 • Celcuity 类型 • 泛磷脂酰肌醇 3- 激酶 (PI3K)/ 哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 双重抑制剂 用法 • 静脉给药（每 28 天为一个治疗周期，每周给药一次，连续 给药 3 周），用于治疗激素受体 (HR) 阳性 / 人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性转移性乳腺癌 • 同时正在评估其用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC)	影响 约 9.4 万 2025 年 G7 市场既往未经治疗的（一线）HR 阳性 /HER2 阴性转移性乳腺癌新发病例数约为 9.4 万例 约 11.9 万 2025 年 G7 市场既往接受治疗的（二线及三线）HR 阳性 /HER2 阴性转移性乳腺癌新发病例数约为 11.9 万例	审批状态 2022 年 1 月： • 快速通道认定：美国 FDA 2022 年 7 月： • 突破性疗法认定：美国 FDA 2025 年 9 月： • 启动滚动式新药申请 (NDA) 程序，通过实时肿瘤学审评 (RTOR) 计划提交：美国 FDA（HR 阳性 / HER2 阴性晚期乳腺癌） 2025 年 11 月： • NDA 提交：美国 FDA（HR 阳性 / HER2 阴性晚期乳腺癌） 实际和预期上市时间 • 2026 年：欧盟、美国 预计专利到期时间 • 专利预计从 2042 年开始陆续到期
--	---	---

Gedatolisib 是一款潜在的同类首创泛 PI3K/mTOR 抑制剂，凭借同时靶向 I 类 PI3K 家族全部四种亚型 (α 、 β 、 γ 、 δ) 及 mTOR 激酶的独特优势，有望破解激素受体 (HR) 阳性 / 人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性乳腺癌患者对标准内分泌治疗耐药的难题。

相较于阿培利司 (alpelisib) 等亚型特异性 PI3K 抑制剂，该药对 PI3K/mTOR 通路的抑制范围更广，这一特性不仅有望提升疗效，还能覆盖更广泛的患者群体。III 期临床试验结果显示，与现有疗法的临床数据相比，该药在改善患者临床结局方面展现出“改变临床实践”的显著潜力。

为什么列为值得关注的药物？

Gedatolisib 已基于关键 III 期 VIKTORIA-1 试验中 *PIK3CA* 野生型队列的阳性顶线数据，通过实时肿瘤学审评 (RTOR) 程序提交滚动式新药申请 (NDA)。该试验为 HR 阳性 /HER2 阴性晚期乳腺癌药物研发史树立了多项新里程碑，在疾病进展或死亡风险降低方面取得了前所未有的突破，同时显著延长了患者的中位无进展生存期 (PFS)。尽管上述核

心数据聚焦于 *PIK3CA* 野生型人群，但 gedatolisib 已明确证实其抗肿瘤细胞活性不受 *PIK3CA* 突变状态限制。这一特性为其适应症拓展奠定了关键基础。目前，在 III 期临床试验 VIKTORIA-2 中，该药物正作为一线治疗方案，针对内分泌治疗耐药的 HR 阳性 /HER2 阴性晚期乳腺癌患者开展进一步研究。

VIKTORIA-1（全球 III 期）：701 例局部晚期或转移性 HR 阳性 /HER2 阴性乳腺癌患者，均为既往接受 CDK4/6 抑制剂联合芳香化酶抑制剂治疗后出现疾病进展或治疗期间病情进展

Gedatolisib + 氟维司群 + 爱博新[®]（哌柏西利，辉瑞）（三联疗法）vs gedatolisib + 氟维司群（双联疗法）vs 氟维司群（单药疗法），允许从单药组交叉至三联或双联组

PIK3CA 野生型晚期乳腺癌患者数据 (n=392)：

- 主要终点：
 - 中位无进展生存期 (PFS)：9.3 个月（三联疗法）vs 7.4 个月（双联疗法）vs 2 个月（单药疗法）
 - 在预设亚组中，PFS 获益一致，包括内脏及肝转移患者
- 次要终点：
 - 中位总生存期 (OS)（数据截至 2025 年 5 月 30 日的中期分析，已观察到 48% 的事件）：23.7 个月（校正风险比：0.69, $P=0.13$ ；三联疗法）vs 未达到（校正风险比：0.74, $P=0.21$ ；双联疗法）vs 18.5 个月（单药疗法）
- 疾病进展或死亡风险降低：76%（三联疗法）vs 67%（双联疗法）vs 单药疗法
- 氟维司群单药治疗期间疾病进展：n=108，其中 63 例 (58.3%) 交叉治疗：
 - 交叉至三联疗法组：n=52 (48.1%)
 - 交叉至双联疗法组：n=11 (10.2%)

安全性与耐受性：

- 发生 ≥ 1 次严重不良事件 (SAE) 的患者比例：10.8%（三联疗法）vs 9.2%（双联疗法）vs 0.8%（单药疗法）
- 因治疗相关不良事件 (TRAEs) 导致研究治疗终止的患者比例：2.3%（三联疗法）vs 3.1%（双联疗法）vs 0%（单药疗法）

- 因 TRAE 导致死亡的比例：1.5%（三联疗法）vs 0%（双联疗法）vs 0%（单药疗法）
- 三联疗法 vs 双联疗法 vs 单药疗法，最常见 3 级 TRAE 发生率：
 - 中性粒细胞减少症 (52.3% vs 0% vs 0.8%)
 - 口炎 (19.2% vs 12.3% vs 0%)
 - 皮疹 (4.6% vs 5.4% vs 0%)
 - 高血糖 (2.3% vs 2.3% vs 0%)
- 三联疗法 vs 双联疗法，主要 4 级 TRAE 发生率：
 - 中性粒细胞减少症 (10.0% vs 0.8%)
 - 白细胞减少症 (0.8% vs 0%)
 - 肺炎 (0% vs 0.8%)
- 三联疗法 vs 双联疗法 vs 单药疗法，最常见 AE 发生率：
 - 口炎 (69.2% vs 56.9% vs 0%)
 - 中性粒细胞减少症 (65.4% vs 1.5% vs 0.8%)
 - 皮疹 (27.7% vs 32.3% vs 0%)
 - 高血糖 (9.2% vs 11.5% vs 0%)

主要终点完成时间：

- 2025 年 6 月

预计研究完成时间：

- 2026 年 12 月

VIKTORIA-2（全球 III 期）：638 例局部晚期或转移性 HR 阳性 /HER2 阴性乳腺癌患者，均为辅助内分泌治疗期间或治疗结束后 12 个月内疾病进展，且无既往全身治疗史

Gedatolisib + 氟维司群 + 研究者选择的爱博新或凯丽隆[®]（瑞波西利，诺华） vs 氟维司群 + 爱博新或凯丽隆

主要终点：

- PFS

预计主要终点完成时间：

- 2027 年 12 月

预计研究完成时间：

- 2028 年 12 月



Gedatolisib 将如何影响乳腺癌市场？

- HR 阳性 /HER2 阴性乳腺癌患者群体的药物销售额是整体乳腺癌药物市场的核心增长引擎，预计将从 2024 年的 165 亿美元增长至 2030 年的峰值 378 亿美元。
- 当前，该领域药物研发进展正在迅速推进，多款新型内分泌治疗药物正在转移性乳腺癌领域开展临床评估，以解决患者对激素治疗的耐药性问题，这些药物包括：选择性雌激素受体降解剂 (SERDs)、选择性雌激素受体调节剂 (SERMs)、蛋白水解靶向嵌合体 (PROTAC) 雌激素受体 (ER) 降解剂、完全雌激素受体拮抗剂 (CERANs)；同时，PI3K/Akt 通路新型抑制剂（如 gedatolisib）及细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6 (CDK4/6) 抑制剂（如 atimociclib）的研发也在同步推进。
- 尽管二线及更后线治疗领域的利润空间低于一线市场，但 vepdegestrant（入选 2025 年最值得关注的药物）、imlunestrant、palazestrant、lasofoxifene、gedatolisib 和 zanidatamab 等新兴疗法的陆续上市，有望驱动该细分领域显著增长。
- 具体而言，根据 III 期临床试验的顶线结果，gedatolisib 的疗效优势已得到初步验证，有望成为 HR 阳性 /HER2 阴性晚期乳腺癌二线治疗的新标准疗法。

Gedatolisib 填补了哪些治疗空白？

突破内分泌治疗耐药瓶颈。当前，内分泌治疗耐药仍是导致 HR 阳性 /HER2 阴性晚期乳腺癌患者预后不佳的关键症结。在解决这类药物的内分泌治疗耐药问题上，gedatolisib 精准填补了这一核心治疗空白。具体来看，针对既往已接受 CDK4/6 抑制剂治疗的 *PIK3CA* 野生型肿瘤患者，现有治疗方案的中位 PFS 仅为 2-4 个月，存在显著未满足医疗需求。Gedatolisib 可精准覆盖这一高危耐药亚群，填补该细分人群的治疗空白。与现有疗法相比，gedatolisib 可能具备差异化的安全性特征，其高血糖不良反应相对较轻，这一优势有望延长患者的治疗持续时间，同时提升用药依从性。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

HR 阳性 /HER2 阴性乳腺癌治疗领域已形成多款药物上市、适应症持续扩展的格局，涵盖 CDK4/6 抑制剂、新型 SERDs、PI3K 亚型抑制剂等多类机制药物。这一趋势预计将引发核心治疗人群（如内分泌耐药、CDK4/6 抑制剂治疗失败人群）的激烈角逐，进而可能限制包括 gedatolisib 在内的单一疗法的市场渗透空间与增长潜力。并且，作为创新型泛 PI3K/mTOR 抑制剂，gedatolisib 的研发成本与临床价值决定了其大概率采取高价策略，这一特性可能会影响其市场渗透率，尤其在医疗费用管控严格的市场中，这一问题将更为突出。

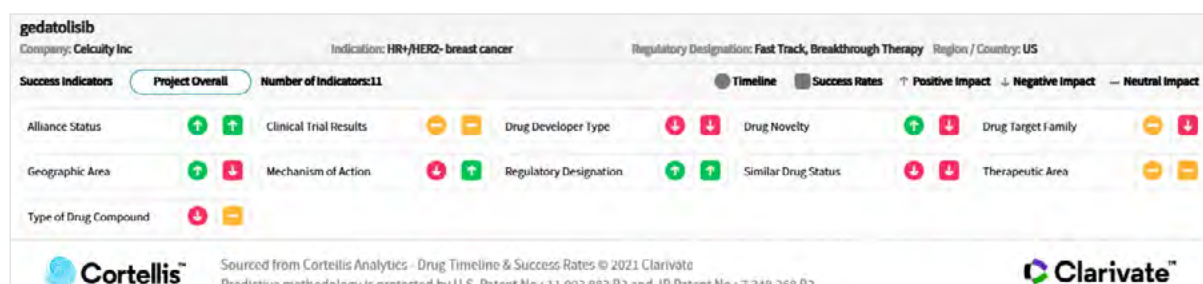
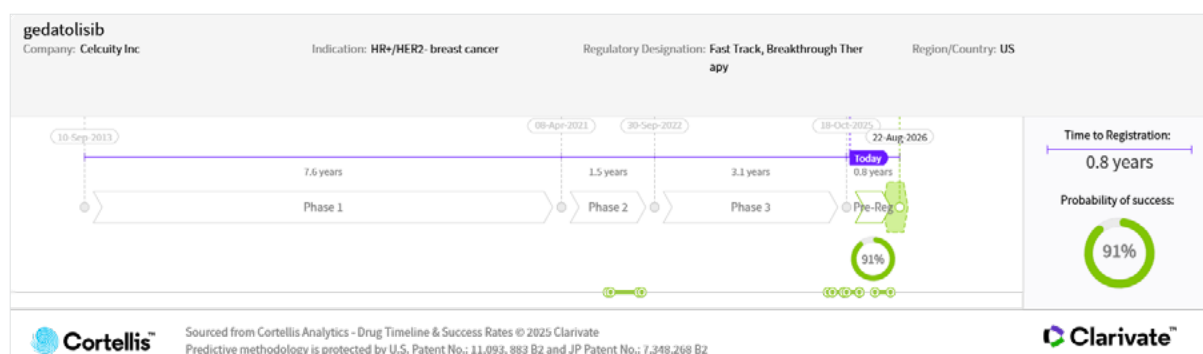
10.8 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“我对阿培利司（PI3K α 选择性抑制剂）的临床应用价值完全不认可，它不仅毒性较强，疗效也十分有限。因此，我热切期待新型 PI3K 抑制剂的问世，尤其希望这类药物能具备远优于阿培利司的治疗指数。”

肿瘤内科医生，来自法国

Cortellis 数据表明，gedatolisib 在美国注册成功的概率为 91%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 11 月 6 日。

如需获取最新动态，请访问 [gedatolisib](#) 页面。

INLEXZO (TAR-200)

膀胱癌

构建女性健康研究新范式

如需获取最新动态，请访问 [INLEXZO](#) 页面。

生产商 - 强生 类型 - 抗代谢药（核苷类似物） 用法 - 通过 TAR-200 药物递送系统，进行膀胱内给药吉西他滨，每 3 周一次，最长持续 6 个月（诱导期）；随后每 12 周给药一次，最长持续 18 个月（维持期）；用于治疗对卡介苗 (BCG) 无反应、伴有原位癌 (CIS) 伴或不伴乳头状肿瘤的高危非肌层浸润性膀胱癌 (NMIBC)。 - 同时正在评估其用于治疗肌层浸润性膀胱癌 (MIBC)	影响 约 2.7 万 2025 年 G7 市场 NMIBC 新增病例数约为 2.7 万例	审批状态 2023 年 12 月： - 突破性疗法认定：美国 FDA 2025 年 1 月： - 根据 RTOR 项目提交 NDA：美国 FDA 2025 年 7 月： - 优先审评：美国 FDA 2025 年 9 月： - 批准上市：美国 FDA 实际和预期上市时间 2025 年：美国 2026 年：欧盟、日本 预计专利到期时间 - 专利预计从 2034 年开始陆续到期
---	---	--

INLEXZO 是首款获批的膀胱内给药系统，其设计旨在实现细胞毒性药物（即吉西他滨）在膀胱内的长效、持续局部释放，从而能够在膀胱内达到较高的局部药物浓度，同时降低全身毒性。这一特性填补了高危非肌层浸润性膀胱癌 (HR-NMIBC) 患者对有效、微创、保膀胱疗法的显著未满足医疗需求，尤其适用于卡介苗 (BCG) 无应答患者，并有望改变此类患者的治疗范式。

该药获批用于治疗对卡介苗 (BCG) 无反应、伴有原位癌 (CIS) 伴或不伴乳头状肿瘤的高危非肌层浸润性膀胱癌 (NMIBC)，依据的是关键 IIb 期 SunRISe-1 试验结果。该试验显示，药物在患者人群的完全缓解 (CR) 率达 82.4%，其中 51% 的患者完全缓解状态维持至少 1 年。

为什么列为值得关注的药物？

INLEXZO 的核心设计亮点在于采用“吉西他滨膀胱内给药系统 + 导尿管 + 插管探针”的组合式包装，通过导尿管即可完成膀胱内植入，使用便捷且创伤小。每个治疗周期内，给药系统可在膀胱内持续留存 3 周，最长可完成 14 个周期治疗，能充分保障局部药物浓度的稳定性。临床试验结果已证实 INLEXZO 单药治疗的疗效，目前还在评估 INLEXZO 与其他在研药物（如强生的 PD-1 单克隆抗体 cetrelimab）的联合治疗效果，进一步提升药物的疗效水平并延长应答持久性。

从研发进展来看，INLEXZO 已在主要市场启动 III 期临床试验，同步探索单药及联合治疗方案在非肌层浸润性膀胱癌 (NMIBC) 和肌层浸润性膀胱癌 (MIBC) 中的治疗价值。凭借其独特的局部给药优势、已验证的疗效数据及联合治疗潜力，该药物未来有望超越现有免疫检查点抑制剂，成为临床医师的优选治疗方案。

SunRISe-1（全球 IIb 期）：200 例对 BCG 无应答、且不适合或拒绝接受根治性膀胱切除术的 NMIBC 患者

	INLEXZO + cetrelimab	INLEXZO 单药治疗 伴有原位癌 (CIS) 伴 或不伴乳头状肿瘤的 HR-NMIBC	cetrelimab 单药治疗	INLEXZO 仅用于乳头状病变 HR-NMIBC
主要终点				
完全缓解 (CR) 率	67.9%（中心确认）	82.4%（中心确认）	46.4%（中心确认）	—
无病生存期 (DFS)	—	—	—	中位值未达； 85.3%（6 个月）、 81.1%（9 个月）、 70.2%（12 个月）
次要终点				
中位缓解持续时间 (DOR)	无法估算	25.8 个月	8.6 个月	—
DOR 率	76.3%（12 个月）	52.9%（≥ 12 个月）	38.5%（12 个月）	—
根治性膀胱切除术豁免率		86.6%（12 个月）； 75.5%（24 个月）		
总生存 (OS) 率	98.0%（12 个月）	98.7%（6 个月）； 94.7%（12 个月）	100%（12 个月）	98%（9 个月）
安全性				
TRAE	92.5%		53.6%	80.8%
≥ 3 级 TRAE	37.7%	12.9%	7.1%	13.5%

主要终点完成时间：

- 2025 年 7 月

预计研究完成时间：

- 2027 年 9 月

SunRISe-3（全球 III 期）：1,135 例未接受过 BCG 治疗的 HR-NMIBC 患者

INLEXZO 单药或 INLEXZO + cetrelimab vs 膀胱内卡介苗

主要终点：

- 无事件生存期 (EFS)

预计主要终点及研究完成时间：

- 2029 年 9 月

SunRISe-5（全球 III 期）：272 例经 BCG 治疗后复发、仅表现为乳头状病变、不伴有 CIS 的 HR-NMIBC 患者，且不适合或拒绝接受根治性膀胱切除术

INLEXZO vs 研究者选择的单药膀胱内化疗

主要终点：

- 无疾病生存期 (DFS)

预计主要终点完成时间：

- 2030 年 11 月

预计研究完成时间：

- 2031 年 4 月

SunRISe-4（全球 II 期）：122 例不适合或拒绝接受新辅助铂类化疗、且计划实施根治性膀胱切除术的 MIBC 患者

INLEXZO + cetrelimab vs cetrelimab 单药治疗

中期分析结果：

- 病理完全缓解 (pCR) 率 (疗效可评估组, 中位随访 23.5 周)：42% vs 23%
- 病理总缓解 (pOR) 率：60% vs 36%
- TRAE (安全组, 中位随访 10.2 周)：72% vs 44%
- ≥ 3 级 TRAE：11% vs 5%
- 因 TRAE 导致治疗中断比例：9% vs 8%

预计研究完成时间：

- 2027 年 3 月

INLEXZO 将如何影响膀胱癌市场？

- 在美国，卡介苗 (BCG) 仍是 HR-NMIBC 患者的标准治疗方案，但 BCG 全球供应短缺问题已对部分高危患者的治疗连续性造成显著影响，这一临床痛点为新型疗法的市场切入创造了关键契机。
- 从免疫治疗赛道来看，尽管免疫检查点抑制剂的患者应答率有限，但可瑞达[®]（帕博利珠单抗，默沙东）在 BCG 无应答且伴有 CIS 的 NMIBC 患者中仍维持稳定的市场渗透率。未来，针对 BCG 初治和 BCG 无应答人群，更多免疫检查点抑制剂预计将陆续上市，其中皮下注射剂型因操作便捷更受泌尿科医师青睐，有望进一步驱动该类药物的市场扩容。据预测，到 2033 年，主要市场中 NMIBC 领域的 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂销售额将接近 20 亿美元。
- INLEXZO 的成功获批则将打破这一格局，凭借其保膀胱、微创为核心的差异化优势，为市场带来了具有“改变治疗范式”潜力的创新疗法，精准填补了 BCG 短缺及免疫治疗应答率不足背景下的临床未满足需求，比免疫检查点抑制剂更具备显著竞争壁垒。与此同时，INLEXZO 也将面临其他新型疗法的直接竞争，包括病毒载体疗法 ADSTILADRIN[®] (nadofaragene firadenovec, 辉凌制药)，以及联合卡介苗使用的 ANKTIVA[®] (nogapendekin alfa inbakicept, ImmunityBio)。
- 此外，CG Oncology 公司的在研药物 cretostimogene grenadenorepvec (溶瘤病毒类膀胱内给药药物) 一旦获批，也可能对临床实践产生深远影响，成为 INLEXZO 的强劲竞争对手。
- 值得关注的是，强生正依托 INLEXZO 的同一给药平台，开发另一款膀胱内给药系统 TAR-210。该系统搭载 erdafitinib，专门针对携带 *FGFR* 突变的 NMIBC 患者。若 INLEXZO 实现商业化成功，将为 TAR-210 及其他基于该平台的适应症拓展提供强大的技术与市场背书，进而覆盖更多难治性膀胱癌亚型，释放平台型产品的长期价值。

INLEXZO 填补了哪些治疗空白？

当前，NMIBC 的治疗选择存在显著局限，尤其对于 BCG 治疗无应答的患者，未满足需求尤为迫切。具体来看：BCG 治疗需通过膀胱内灌注给药，且患者给药后需接受数小时的医学观察；而对于 BCG 无应答的患者，临床通常推荐根治性膀胱切除术，该手术会给患者生活带来不可逆的重大影响，不仅并发症发病率高，还会严重损害患者生活质量。进一步而言，NMIBC 患者以老年群体为主，这类人群往往不愿或因身体状况不适合接受根治性膀胱切除术，进一步加剧了临床治疗需求的缺口。

INLEXZO 的问世精准填补了上述空白：作为保膀胱治疗方案，该疗法可在门诊环境下完成植入操作，全程耗时不到 5 分钟，无需全身麻醉，植入后也无需即时监测，大幅简化了治疗流程；植入后，该装置在膀胱内可留存约 3 周，持续释放吉西他滨，长效的给药方案大幅减少

了患者的就医频次，提升了用药便利性；同时，其良好的耐受性最大限度降低了治疗负担，提升了患者长期治疗的依从性。通过帮助患者避免根治性手术、完整保留膀胱功能，INLEXZO 为临床提供了安全、有效且微创的治疗选择，切实解决了 NMIBC（尤其 BCG 无应答人群）的核心未满足需求。

科睿唯安采访的 KOL 指出，INLEXZO 作为一款便捷的膀胱内给药方案，总体耐受性良好，对功能储备有限的患者具有重要临床价值。KOL 强调，该疗法在 BCG 无应答人群中展现出的持久强效应答及较低的治疗终止率，使其有望成为希望避免根治性手术患者的优选治疗方案。这些观点共同凸显了 INLEXZO 在改善患者生活质量、拓展不适宜膀胱切除术患者治疗选择方面的重要潜在价值。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

长期疗效与安全性验证：INLEXZO 需在更广泛的真实世界人群中，进一步证实其持久的长期疗效及安全性特征的。这是创新疗法获得临床广泛认可、实现市场渗透的核心前提。患者人群局限：目前 INLEXZO 的适应症人群仅限于 BCG 无应答的 HR-NMIBC 患者，该群体规模相对较小，直接制约了其销售潜力的释放。临床接受度挑战：该疗法的市场推广部分依赖于医师对“器械介导膀胱内给药操作”的熟悉程度，而传统

治疗方式的使用惯性可能影响其临床接纳速度。现有疗法竞争压力：已上市的标准疗法（如 BCG、免疫检查点抑制剂）及其他新型疗法的竞争，将进一步分流目标患者，对 INLEXZO 的市场渗透率形成制约。适应症拓展需求：要解锁更大的目标市场、实现长期商业化成功，关键在于推动适应症拓展——包括向 BCG 初治 HR-NMIBC 人群延伸，或开发联合治疗方案，以覆盖更广泛的膀胱癌患者群体。

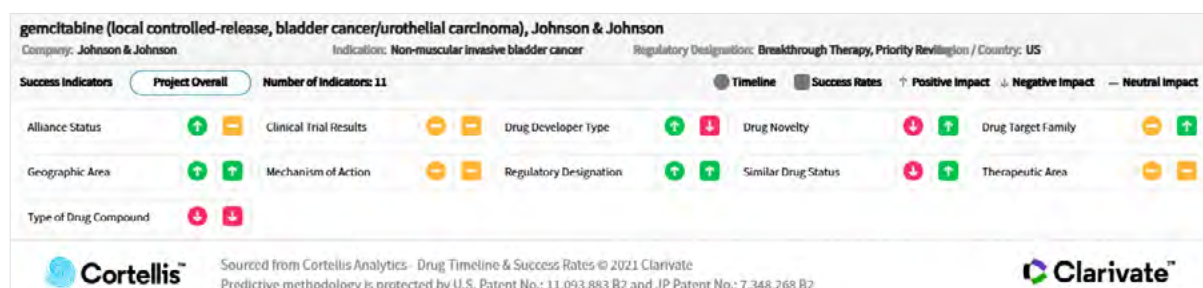
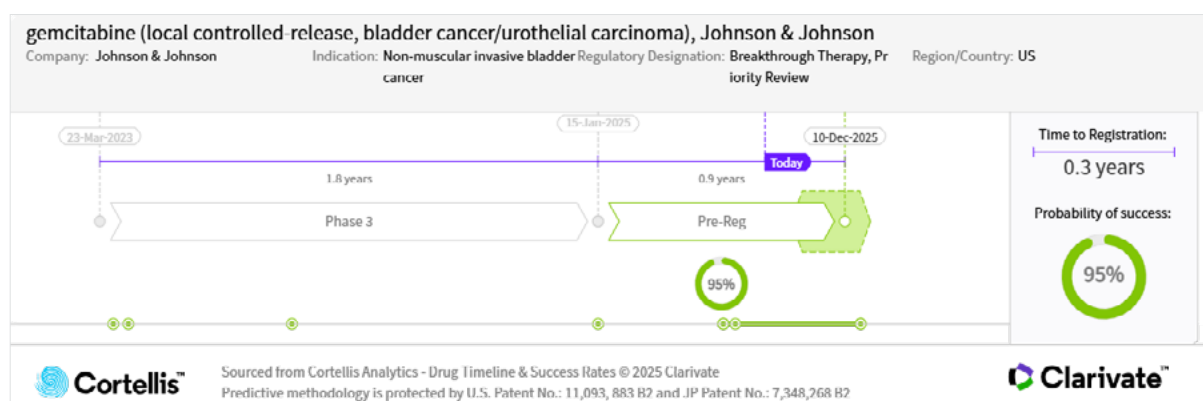
18 亿美元

2031 年在 G7 市场的预计销售额

“ TAR-200 给药系统无需每周重复给药，极大提升了患者的用药便利性。无论从患者还是医生角度看，我都认为其具备巨大的临床应用潜力。该系统不仅安全性特征优异，还拥有多项差异化核心优势。说实话，这是当前膀胱癌治疗领域中最令我振奋的创新进展。”

肿瘤内科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，INLEXZO 在美国注册成功的概率为 95%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 8 月 25 日。

如需获取最新动态，请访问 [INLEXZO](#) 页面。

Relacorilant

卵巢癌与皮质醇增多症（库欣综合征）

构建女性健康研究新范式



如需获取最新动态，请访问 [relacorilant](#) 页面。

生产商 - Corcept Therapeutics 类型 - 选择性糖皮质激素受体拮抗剂 (SGRA) 用法 - 每日口服给药，用于治疗铂耐药卵巢癌、内源性皮质醇增多症（库欣综合征）以及与肾上腺腺瘤或肾上腺增生相关的皮质醇增多症 - 同时正在评估其用于治疗前列腺癌	影响 约 3.7 万 2025 年 G7 市场铂耐药卵巢癌（二线至六线）新增病例数约为 3.7 万例	审批状态 2018 年 10 月： - 孤儿药资格认定：美国 FDA（胰腺癌与库欣综合征） 2019 年 5 月： - 孤儿药资格认定：欧盟委员会 (EC)（库欣综合征） 2023 年 7 月： - 孤儿药资格认定：欧盟委员会 (EC)（铂耐药卵巢癌） 2025 年 3 月： - NDA 受理：美国 FDA（库欣综合征） 2025 年 9 月： - NDA 受理：美国 FDA（铂耐药卵巢癌） 2025 年 12 月 30 日： - FDA PDUFA 日期（皮质醇增多症） 2026 年 7 月 11 日： - FDA PDUFA 日期（铂耐药卵巢癌） 实际和预期上市时间 2025 年：美国（库欣综合征） 2026 年：欧盟、美国（卵巢癌） 预计专利到期时间 - 专利预计从 2033 年开始陆续到期
---	---	--

Corcept 公司收到关于 relacorilant 用于治疗皮质醇增多症患者的完整回复函：FDA 针对 relacorilant 用于治疗因皮质醇增多症（库欣综合征）所致高血压的新药申请发出完整回复函（CRL）。FDA 认为，为完成获益 - 风险评估，需要提供更多疗效证据。（2025/12/31）

选择性糖皮质激素受体拮抗剂 (SGRA) relacorilant 正成为铂耐药卵巢癌与内源性皮质醇增多症（即库欣综合征）两大高需求领域的潜力治疗药物。皮质醇作为一种关键激素，既与肿瘤耐药机制密切相关，也参与代谢功能紊乱的病理过程；relacorilant 的核心创新在于通过精准调控皮质醇活性发挥治疗作用，其全新作用机制与现有疗法形成显著差异，具备独特临床竞争力。

目前，relacorilant 已有两项新药申请 (NDA) 正在 FDA 审评中，有望成为首个同时针对铂耐药卵巢癌和皮质醇增多症的同类首创药物。基于这一研发进展，该药物预计在 2026 年于两大治疗领域同时实现突破，为治疗选择有限的患者精准赋能，重塑相关疾病的治疗范式。

为什么列为值得关注的药物？

铂耐药卵巢癌领域：在关键性 III 期 ROSELLA 临床试验中，relacorilant 展现出令人信服的临床疗效：与白蛋白结合型紫杉醇单药治疗相比，relacorilant 联合白蛋白结合型紫杉醇治疗可显著延长铂耐药卵巢癌患者的无进展生存期 (PFS) 和总生存期 (OS)，且未增加额外毒性。Relacorilant 的核心优势体现在：临床结局积极且安全性特征良好，无需依赖生物标志物筛选患者，可逆转皮质醇诱导的化疗耐药，采用口服给药方式，便捷性更优。这些特征使其能精准匹配铂耐药卵巢癌患者高度未满足的临床需求，有望在该人群中占据重要市场份额。

皮质醇增多症领域：relacorilant 已针对皮质醇增多症提交了新药申请 (NDA)，有望为该小众适应症带来全新治疗选择。III 期 GRACE 和 GRADIENT 试验数据显示，该药物可显著改善患者高血压、高血糖等症状，且未观察到与孕激素受体活性相关的严重不良事件。相较于部分已获批的皮质醇增多症治疗药物，relacorilant 具备更优的差异化安全性特征，有望在该小众领域形成核心竞争壁垒。

II 期临床试验（全球）：178 例铂耐药复发性高分化上皮性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌患者，既往至少接受过 1 线治疗

relacorilant + ABRAXANE（白蛋白结合型紫杉醇，百时美施贵宝）vs ABRAXANE 单药治疗

主要终点：

- 中位无进展生存期 (PFS) : 5.6 个月 (relacorilant 间歇给药) / 5.3 个月 (relacorilant 连续给药) vs 3.8 个月

次要终点：

- 客观缓解率 (ORR) : 35.7% (relacorilant 间歇给药) / 35.2% (relacorilant 连续给药) vs 35.8%
- 中位缓解持续时间 (DOR) : 5.5 个月 (relacorilant 间歇给药) / 3.79 个月 (relacorilant 连续给药) vs 3.65 个月
- 中位 OS : 13.9 个月 (relacorilant 间歇给药) / 11.3 个月 (relacorilant 连续给药) vs 12.2 个月

ROSELLA（全球 III 期）：381 例铂耐药复发性高分化上皮性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌患者，既往治疗不超过 3 线

relacorilant + ABRAXANE vs ABRAXANE 单药治疗

共同主要终点：

- 中位 PFS : 6.5 个月 vs 5.5 个月
- 中位 OS : 16.0 个月 vs 11.5 个月

次要终点：

- ORR : 36.9% vs 30.1%

安全性评估良好

GRACE（全球 III 期）：152 例库欣综合征合并 2 型糖尿病 / 糖耐量异常和 / 或高血压未控制患者

relacorilant vs 安慰剂

- 开放标签阶段：relacorilant 治疗 22 周
- 随机撤药阶段：开放标签阶段有应答的患者随机分配至 relacorilant 组或安慰剂组治疗 12 周

主要终点：

- 血压控制维持情况（随机撤药阶段）：relacorilant 组 vs 安慰剂组 OR=0.17(P=0.02)

最常见不良事件：

- 背痛 (16.7% vs 18.8%)
- 头痛 (10% vs 12.5%)
- 关节痛 (10% vs 9.4%)

GRADIENT（全球 III 期）：137 例肾上腺腺瘤或肾上腺增生导致的皮质醇增多症患者

relacorilant vs 安慰剂

主要终点：

- 第 22 周血压控制情况：-6.6 mmHg vs -2.1 mmHg

Relacorilant 将如何影响铂耐药卵巢癌市场？

- 在铂耐药卵巢癌的二线及三线治疗场景中，主要市场药物销售额预计将实现显著增长：从 2024 年的 7.2 亿美元（占主要市场卵巢癌总销售额的 19%），攀升至 2034 年的 23 亿美元（占比提升至 39%）。
- 值得关注的是，以铂耐药患者为主的四线至六线治疗领域，尽管目前是卵巢癌市场中规模最小的细分板块之一，但增长潜力突出——该人群对应的药物销售额预计将增长逾两倍，从 2024 年的 3,000 万美元增至 2034 年的 1.1 亿美元。
- 这一市场增长的核心驱动因素将是多机制新药的陆续获批，包括 relacorilant 等抗糖皮质激素药物、免疫疗法、激酶抑制剂、抗体药物偶联物 (ADC) 在内的创新疗法，将精准匹配铂耐药患者的核心未满足需求，成为市场规模扩容的关键引擎。
- 从临床治疗现状来看，当前二线及以上铂耐药卵巢癌的标准治疗方案仍为单药化疗 ± 贝伐珠单抗（联合用药可改善患者无进展生存期）；但随着 relacorilant 等疗效更优的新型疗法获批，这一传统治疗格局有望被打破。
- Relacorilant 的独特价值尤为凸显：其无需生物标志物筛选的优势，可覆盖无法接受靶向治疗的广泛患者群体，为这类缺乏有效治疗选择的患者提供新方案，进而抢占更广阔的市场份额。

Relacorilant 填补了哪些治疗空白？

铂耐药卵巢癌领域：铂耐药卵巢癌的治疗选择有限，疗效短暂且难以维持，现有疗法仅能为患者带来温和获益，且多数受限于生物标志物筛选。Relacorilant 通过靶向皮质醇驱动的化疗耐药，填补了这一治疗空白。其核心机制为阻断糖皮质激素受体 (GR) 激活，既能恢复肿瘤细胞对化疗的敏感性，又能显著增强白蛋白结合型紫杉醇的疗效；同时，相较于白蛋白结合型紫杉醇

单药治疗，该联合方案未增加额外毒性，安全性优势明确。此外，relacorilant 无需生物标志物筛选，大幅扩大了适用人群，为无法接受靶向治疗的患者提供了比标准单药化疗更优的治疗选择，并且口服给药方式相较于传统静脉化疗更便捷，能进一步提升患者治疗依从性。

皮质醇增多症领域：现有皮质醇增多症治疗药物常伴随显著副作用，包括肾上

腺功能不全、低钾血症及孕激素相关并发症。Relacorilant 采用选择性阻断糖皮质激素受体 (GR) 的靶向设计，在不影响其他激素受体的前提下实现精准治疗。这种特异性机制不仅能有效减轻皮质醇过量引发的高血压、高血糖、代谢功能紊乱等核心症状，还能规避其他治疗中常见的不良事件。

要成为重磅炸弹药物，可能需要克服哪些障碍？

受目标患者群体小众及市场竞争激烈双重因素影响，relacorilant 要跻身重磅炸弹级药物行列，仍面临不小挑战。不过，其广泛的临床开发布局，以及在前列腺癌等额外适应症上的潜在成功，有望丰富收入结构、实现营收多元化，为其冲击重磅炸弹地位提供核心支撑。

铂耐药卵巢癌领域：该药物需在日益拥挤的治疗赛道中突围立足，同时还需推动临床医师认可“皮质醇调控”这一相对

新颖的治疗理念。尽管“不依赖生物标志物筛选”是其核心优势，但在实际临床应用中仍可能面临挑战：raludotatug deruxtecan (默沙东)、Rina-S (rinatabart sesutecan, Genmab A/S) 等处于后期研发阶段的 ADC 药物管线持续扩容，在特定分子亚型中展现出强劲疗效。要实现差异化竞争，relacorilant 需在更广泛的患者群体中验证疗效的持久性，同时明确自身定位为无法接受靶向治疗患者的标准治疗方案。

皮质醇增多症领域：relacorilant 需要与现有疗法直接展开竞争，例如 Korlym (mifepristone, Corcept Therapeutics) 和适锐飒 (奥唑司他, Recordati Rare Diseases)。尽管 relacorilant 具有更优的安全性特征，但要取代已占据市场的成熟疗法、实现小众市场渗透，仍需在真实世界场景中证明其疗效优势，才能建立临床认可度。

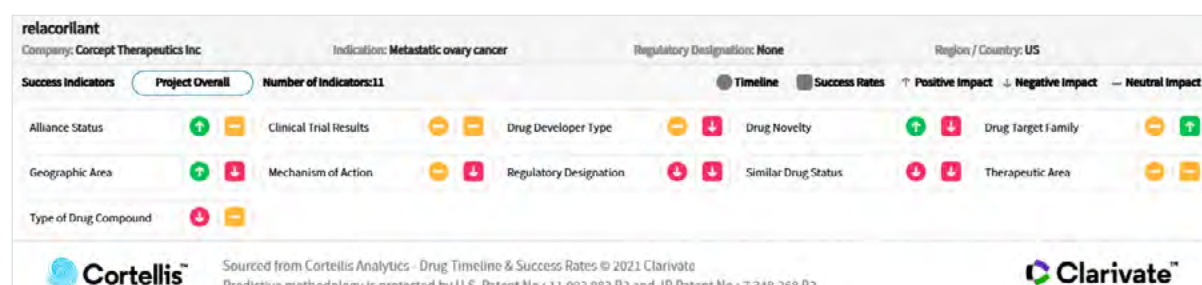
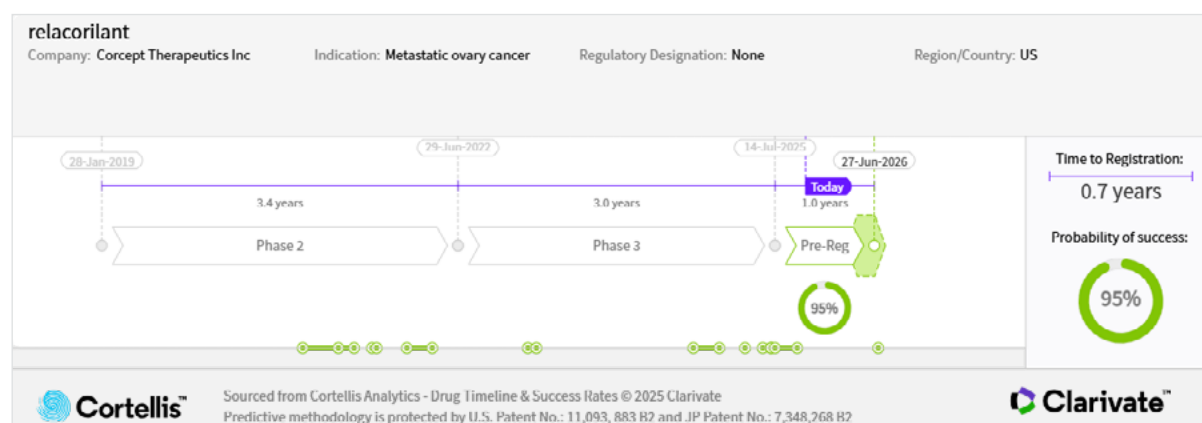
1.5 亿美元

2031 年在 G7 市场卵巢癌治疗领域的预计销售额

“我认为 relacorilant 最令人振奋的核心亮点，在于其不依赖肿瘤微环境、无需生物标志物筛选。而临床中，当患者无明确可用的生物标志物时，往往只能依赖化疗，这一现状着实令人沮丧。因此，这款药物至少为这类缺乏靶向治疗选项的患者，提供了化疗之外的全新治疗机会，这一价值尤为突出。”

肿瘤内科医生，来自美国

Cortellis 数据表明，relacorilant 在美国注册成功的概率为 95%。



数据来源：Cortellis 竞争情报数据库，含药物研发时间线与注册成功率预测，更新日期：2025 年 10 月 29 日。

如需获取最新动态，请访问 [relacorilant](#) 页面。

癌症、肥胖症与 2 型糖尿病仍是中国市场 关注焦点

我们筛选出 6 款药物（涵盖全球原研与本土创新药物），这些药物有望填补中国市场中高度未被满足的医疗需求，且所针对的适应症商业潜力突出，对药企而言具备重要战略价值。中国国家医保药品目录 (NRDL) 在提升患者对创新疗法可及性方面发挥着不可或缺的作用，通过政策赋能助力创新药物快速落地并实现广泛市场渗透。凭借优异的临床数据与庞大的患者需求，这些疗法在持续变革的中国医疗健康生态中，有望占据可观市场份额并创造丰厚商业价值。

值得关注的是，中国医药市场的竞争格局正经历创新主导权的显著更迭。尽管跨国药企仍将持续向市场推出疗效卓越的前沿药物，但中国本土创新力量的崛起已引发行业广泛关注。在 2026 年有望脱颖而出的 6 款核心候选药物中，4 款源自中国本土创新企业，这一现象标志着中国医药市场已从曾经的仿制药主

导，成功实现向创新驱动型市场的跨越式转型，如今已能研发出媲美甚至在部分领域挑战跨国药企龙头产品的创新成果。这一趋势更凸显了中国在生物制药领域的角色演变：不再是单纯的生产制造基地，而是成长为全球制药创新领域的重要参与者。

这 6 款药物的临床价值与市场相关性，与中国日益变化的疾病负担格局高度匹配，尤其是肥胖症、糖尿病及各类癌症等非传染性疾病的患病率持续攀升，构成了核心需求支撑。过去 20 年间，中国超重与肥胖的患病率增长近 3 倍 (Li 等，2022 年)。截至 2022 年，约 34.8% 的人口被归类为超重，14.1% 达到肥胖标准 (Chen 等，2023 年)，对应约 6.9 亿人存在体重相关健康问题，规模接近美国总人口的两倍。这一数据意味着，用于减重及 2 型糖尿病、心血管疾病等相关代谢疾病的治疗药物蕴藏

着巨大市场机遇。另有研究表明，在超重与肥胖人群中，糖尿病前期、血脂异常及高血压的患病率分别高达约 68%、74% 和 58%，进一步放大了相关治疗领域的需求缺口。

与此同时，中国癌症发病率亦呈上升态势，给社会带来了沉重的发病与死亡负担 (Han 等，2024 年)。国家癌症中心数据显示，2022 年我国癌症发病数已达 482.47 万例，死亡数 257.42 万例。值得注意的是，乳腺癌是女性中仅次于肺癌的第二大常见恶性肿瘤，2022 年新发病例约 35.72 万例，发病率达到 51.17 例 /10 万人，成为推动癌症治疗药物需求增长的重要细分领域。



中国市场的“变革性药物”

安得卫（贝莫苏拜单抗，TQB2450）

公司：
- 正大天晴 - 中国生物制药
适应症：
非小细胞肺癌 (NSCLC)
美国首次获批时间：
N/A
欧洲首次获批时间：
N/A
中国首次获批时间：
2024 年 4 月
2024 年全球销售额（百万美元）：
N/A
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
>400
预计中国专利到期时间：
2035

为什么列为值得关注的药物？

安得卫 (Andewei) 最初在中国获批用于广泛期小细胞肺癌 (ES-SCLC) 一线治疗，为患者带来显著的无进展生存期 (PFS) 与总生存期 (OS) 获益；随后于 2024 年 8 月、11 月进一步拓展适应症，分别获批晚期 / 转移性肾细胞癌一线治疗及复发或难治性转移性子宫内膜癌治疗。基于后期临床试验的积极数据，该公司计划在中国提交两项新的上市申请：一是联合或不联合安罗替尼，用于不可切除 III 期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者放化疗后的巩固治疗；二是联合化疗后序贯安罗替尼，用于晚期鳞状 NSCLC 的一线治疗。临床数据为这一拓展提供了坚实支撑：CAMPASS 临床试验显示，安得卫联合安罗替尼组的中位 PFS 达 11.0 个月，显著优于帕博利珠单抗组的 7.1 个月 ($P=0.007$)；R-ALPS 研究进一步证实，联合治疗组中位 PFS 提升至 15.1 个月，明显高于安得卫单药组的 9.7 个月。依托强劲的临床疗效、具有竞争力的定价策略，以及相较于度伐利尤单抗、舒格利单抗的明确差异化优势，安得卫有望在我国不可切除 III 期 NSCLC 治疗市场中占据主导地位。

HRS-9531

公司：
• 恒瑞医药
适应症：
• 肥胖症 • T2DM
美国首次获批时间：
• N/A
欧洲首次获批时间：
• N/A
中国首次获批时间：
• 预期上市时间：2027 年
2024 年全球销售额（百万美元）：
• N/A
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
• >300
预计中国专利到期时间：
• N/A

为什么列为值得关注的药物？

HRS-9531 是一款每周给药一次的 GIP/GLP-1 双重受体激动剂，目前处于肥胖症和 2 型糖尿病的后期研发阶段，旨在为代谢疾病患者提供强效减重和血糖控制双重解决方案。在针对肥胖症的关键性 III 期临床试验 (NCT06396429) 中，对于超重或肥胖且伴有至少一种体重相关合并症的成年患者，经 HRS-9531 治疗 48 周后，平均减重幅度达 17.7%，较安慰剂组的减重差异达 16.3%，优势显著。其 2 型糖尿病适应症的 III 期临床试验结果尚未披露，但结合该药的作用机制及肥胖症领域已验证的优异疗效，业界普遍预期其 T2DM 适应症将取得积极数据。作为中国首款有望获批的本土自主研发 GIP/GLP-1 双重受体激动剂，HRS-9531 上市后将直接与穆峰达（替尔泊肽，礼来）争夺市场份额。

Icotrokinra

公司：
• 强生
适应症：
• 斑块状银屑病
美国首次获批时间：
• N/A
欧洲首次获批时间：
• N/A
中国首次获批时间：
• 预期上市时间：2028 年
2024 年全球销售额（百万美元）：
• N/A
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
• >200
预计中国专利到期时间：
• N/A

为什么列为值得关注的药物？

Icotrokinra 有望成为全球首款口服 IL-23 受体拮抗剂，在 III 期银屑病临床试验 (ICONIC-LEAD/NCT06095115) 中表现亮眼，治疗 24 周时，74% 的患者达到 IGA 评分 0/1 级标准（即皮肤清洁或几乎清洁），疗效优势显著。该药兼具强效治疗效果与每日一次口服给药的便捷性，为中重度银屑病患者提供了注射类生物制剂的有力替代方案。其市场定位直指氘可来昔替尼等酪氨酸激酶 2 (TYK2) 抑制剂，凭借独特作用机制与临床数据，有望在 2031 年前实现疗效超越。更重要的是，icotrokinra 或能加速推动口服疗法向中重度银屑病一线治疗转型，既显著提升患者治疗可及性，更有望重塑中国中重度银屑病的临床治疗格局。

Orforglipron

公司：
礼来
适应症：
- 肥胖症 - T2DM
美国首次获批时间：
N/A
欧洲首次获批时间：
N/A
中国首次获批时间：
预期上市时间：2027 年
2024 年全球销售额（百万美元）：
N/A
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
1500
预计中国专利到期时间：
2037

为什么列为值得关注的药物？

若能成功上市，orforglipron 有望成为中国首款口服小分子 GLP-1 受体激动剂，重塑国内 2 型糖尿病与肥胖症治疗市场格局。在针对 T2DM 合并肥胖症患者的关键性 ACHIEVE-1 临床试验 (NCT05971940) 中，该药以每日一次口服给药方式展现出优异疗效：在基线值为 8.0% 的情况下，HbA1c 降幅达 1.3%~1.6%；最高剂量组中，患者更实现了具有临床意义的减重效果（减重 16 磅，7.9%）。依托口服给药的便利性，该药预计在肥胖症领域也将获得广泛应用，尤其适配不愿接受注射治疗的患者群体。此外，orforglipron 还在推进高血压及阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 适应症的拓展研发，进一步扩大治疗应用场景。凭借强效的血糖控制效果、临床意义明确的减重作用及便捷的口服给药优势，orforglipron 不仅有望在快速增长的中国 T2DM 与肥胖症市场中占据重要份额，更能显著提升更广泛患者群体的治疗可及性。

信超妥（沙库巴曲阿利沙坦钙，S086）

公司：
信立泰药业
适应症：
- 心力衰竭 (HF) - 高血压
美国首次获批时间：
N/A
欧洲首次获批时间：
N/A
中国首次获批时间：
2025 年 5 月
2024 年全球销售额（百万美元）：
N/A
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
>500
预计中国专利到期时间：
2037

为什么列为值得关注的药物？

信超妥作为一款新型血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂 (ARNI)，获批用于轻中度原发性高血压治疗，也是首款将沙库巴曲与中国本土研发的血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB) 阿利沙坦组成复方制剂的药物。尽管该药首发适应症为高血压，但基于积极的早期临床数据，以及国内射血分数降低型心力衰竭 (HFrEF) 领域显著的未被满足医疗需求，其向 HFrEF 拓展的潜力十足。III 期临床试验结果已达到主要终点，不仅证实了其临床疗效非劣于诺欣妥[®]（沙库巴曲 / 缬沙坦，诺华），高剂量给药时的降压效果更优于标准 ARB 疗法，为其适应症拓展提供了坚实数据支撑。信超妥的核心差异化优势在于可降低血清尿酸水平，这一特性对合并利尿剂相关性高尿酸血症的心力衰竭患者尤为有益，填补了此类患者治疗的细分空白。该药整体定位为填补中国心力衰竭治疗领域的关键缺口，尽管需面对标准治疗药物诺欣妥的直接竞争，但依托本土研发背景、预期的价格优势，以及在农村地区更强的可及性提升潜力，未来有望实现广泛临床应用。

依达方（依沃西单抗，AK112）

公司：
康方生物
适应症：
- 乳腺癌 - NSCLC
美国首次获批时间：
N/A
欧洲首次获批时间：
N/A
中国首次获批时间：
2024 年 5 月
2024 年全球销售额（百万美元）：
55
2031 年中国市场预计销售额（百万美元）：
~500
预计中国专利到期时间：
2038

为什么列为值得关注的药物？

依达方是中国首款 PD-1/VEGF 双特异性抗体，其首次获批适应症为 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗失败后的晚期 EGFR 突变非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC)。III 期 HARMONi-2 试验结果具有里程碑意义，在 PD-L1 阳性 NSCLC 治疗中，该药首次实现头对头试验对帕博利珠单抗的优效性，PFS 达 11.1 个月，显著优于帕博利珠单抗组的 5.8 个月（风险比 0.51），且在各 PD-L1 表达亚组中均展现出一致的临床获益。基于这一突破性数据，该药获国家药品监督管理局 (NMPA) 批准该适应症的一线治疗。III 期 HARMONi-6 试验进一步验证了其在 NSCLC 领域的应用潜力，在晚期鳞状 NSCLC 一线治疗中，依达方相较于替雷利珠单抗联合化疗方案，显著延长患者 PFS，相关适应症的上市申请已于 2025 年 7 月向 NMPA 递交并获受理。通过在单一制剂中整合免疫检查点抑制与抗血管生成双重机制，依达方构建了差异化治疗优势，有望成为 PD-L1 阳性 NSCLC 及 EGFR-TKI 耐药非鳞状 NSCLC 领域的变革性治疗药物，同时具备向三阴性乳腺癌等实体瘤拓展的潜力。

数据来源：科睿唯安 China In-Depth 系列报告

政治化 FDA 背景下重新思考监管透明度

自特朗普总统第二任期开启以来，美国政治环境为药物研发与审批增添了额外不确定性。这一扰动正深刻影响生物科技领域，不仅让行业预测更趋复杂，还促使大型制药企业在投资与合作决策中更趋保守。在此背景下，FDA 历来秉持的监管透明度下滑，阻碍制药行业获取规划研发策略所需的信息，从而令获取可靠、高质量数据这一工作变得空前关键。



药品定价相关行政命令

特朗普总统签署多项直接针对制药行业的行政命令，宣称旨在降低处方药价格、提升药品可及性并增强透明度，具体包括：

- **“为美国患者提供最惠国待遇处方药定价”**：建立“最惠国待遇”（MFN）定价机制，要求制药企业向美国市场供应药物时，定价不高于该药在其他发达国家的最低售价
- **“促进国内关键药品生产的监管减负”**：通过简化监管流程、清除药品制造回流美国的障碍，助力恢复美国本土处方药及关键活性成分的生产能力
- **“再次将美国人放在首位以降低药品价格”**：通过强化市场竞争、提升价格透明度、扩大仿制药与生物类似药可及性等手段降低药价，同时修订《通胀削减法案》（IRA）中联邦医疗保险（Medicare）药品价格谈判的等待期条款
- **“赋予患者清晰、准确、可操作的医疗定价信息，使美国重新恢复健康”**：完善并保障医疗全链条价格透明度，同时挖掘进一步提升透明度的潜在方向
- **“扩大体外受精服务可及性”**：提出政策建议，保障体外受精（IVF）服务可及性，降低患者自付费用及医保计划覆盖成本
- **“成立总统‘让美国再次健康’（MAHA）委员会”**：要求卫生与公众服务部（HHS）聚焦慢性疾病防控，包括优先推进相关研究、保障健康平价食品供应、扩大治疗服务及保险覆盖范围
- **“利用人工智能解锁儿童癌症治疗方法”**：授权“让美国再次健康（MAHA）”委员会探索利用人工智能等先进技术，优化儿童癌症的诊断、治疗、治愈及预防策略

上述行政命令中，聚焦药价降低的举措对制药行业的影响或最为深远。具体要求包括：在 IRA 法案初始 22% 谈判覆盖率的基础上，进一步扩大 Medicare 药物定价谈判范围；将 Medicare 支付标准与药品实际采购成本挂钩（数据显示，签约采购价格平均较联邦医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）定价低 35%）；统一部分药品支付标准以缩小差异，尤其覆盖肿瘤药物及标准治疗药物；简化低价药品进口审批流程；优先支持直接面向消费者（DTC）的药品销售模式；推行最惠国待遇（MFN）药品定价机制，辉瑞于 2025 年 9 月底成为首家同意该机制的企业（Boggs, 2025b）。

尽管这些举措被包装为“惠及患者”、“财政负责任”的定位，但给药物研发企业与生产商带来了显著不确定性：自愿遵守可能导致营收缩水，拒绝遵守则可能面临更严格的监管审查。批评人士警告，此举可能引发一系列非预期后果，包括创新投入缩减、企业优先布局美国以外市场、供应链中断及法律诉讼增多等。这些行政命令对行业的实际运营影响，最终取决于多方面因素：各机构对行政命令的落地执行方式、企业的谈判议价空间，以及制药行业助力生产商适应政策变化的效率（Serebrov, 2025a）。

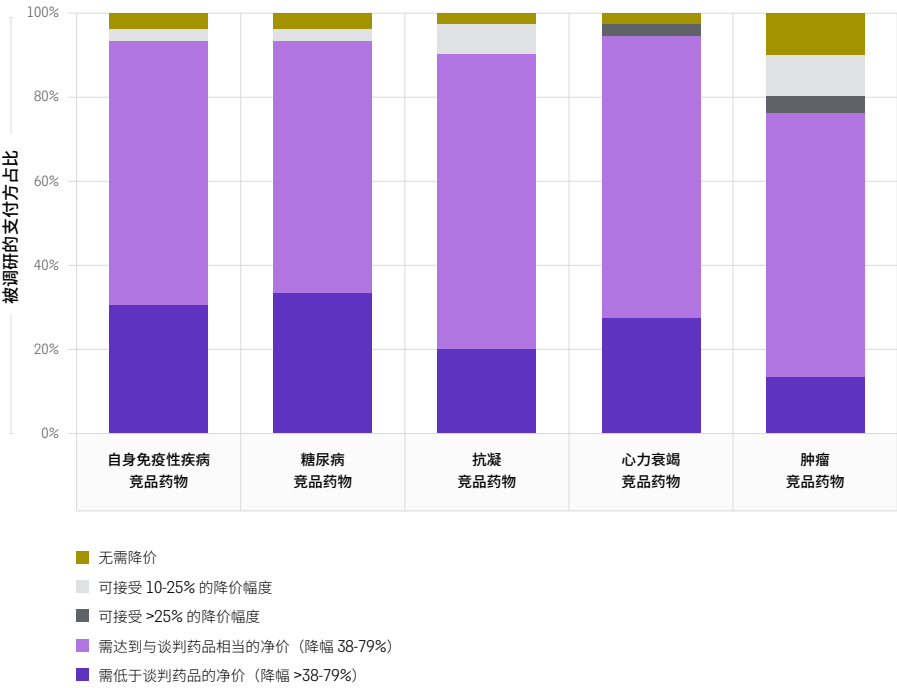
《通胀削减法案》药品价格谈判的叠加效应

尽管《通胀削减法案》(IRA) 由拜登政府推出，但其核心条款于 2025 年逐步落地执行，为制药企业的药物定价策略增添了更多不确定性。即便该法案遭遇多项法律挑战，相关法院仍裁定其合法有效。这一结果迫使药企不得不重新制定产品上市方案与定价框架，其中重磅炸弹级药物受影响尤为显著。

IRA 的核心改革举措可概括为三个方面：一是调整联邦医疗保险 (Medicare) Part D 支付结构，将部分成本负担从患者及 Medicare 体系转移至医疗支付方

与制药企业；二是针对 Medicare 覆盖范围内的高价药物，启动“最高公平价格”(MFP) 专项谈判机制；三是对药价涨幅超同期通胀率的药品，依法征收通胀回扣。2024 年首轮 Medicare Part D 药物定价谈判已创下行业先例，例如强生旗下抗凝血药物拜瑞妥® (利伐沙班) 的降价幅度高达 60%。针对这一谈判结果，科睿唯安的专项研究显示，医疗支付方普遍预期，未来同一治疗类别中，参与谈判药品与非谈判药品的 Medicare 净采购价将逐步趋于一致。

图 5：2024 年谈判药品的竞品需调整的 Medicare 净价幅度（以维持医保覆盖与用药管理地位）（基于 30 位支付方代表的调研数据）



数据来源：科睿唯安市场准入和报销

在此基础上，特朗普政府正推动改革以解决“药丸惩罚 (pillpenalty)”政策带来的失衡问题，该政策目前要求小分子药物比生物药提前 4 年进入价格谈判。两党联合提出的《确保创新疗法途径》(EPIC) 法案，旨在统一 Medicare Part B 与 Part D 药物的谈判等待期，恢复小分子药物研发的投资激励。另一项两党合作提案则聚焦《孤儿药法案》修订，计划填补政策漏洞、重新校准罕见病药物研发激励机制，并扩大加速审批通道与儿科独占期 (PEDS)) 条款的应用。尽管业界担忧这会削弱罕见病药物领域的投资意愿，但患者群体认为，此类调整将兼顾创新促进与罕见病疗法可负担性提升。

此外，另有多项变动事项备受行业关注，包括美国对部分药品进口加征高额关税（部分税率或超 200%）、FDA 内部领导层变动、资深咨询委员会 (AdCom) 成

员被解雇及大规模员工离职等，进一步加剧了监管环境的不确定性。政治因素对科学研究优先级的干预正引发行业的普遍担忧，例如生物医学高级研究与发展管理局 (BARDA) 突然终止 22 项 mRNA 疫苗相关合同及投资 (Serebrov, 2025b)；而机构履职能力的下滑，也让监管审查与决策的及时性、一致性备受质疑。

不过，与以往惯例形成鲜明对比的是，FDA 已在全机构范围内部署生成式人工智能工具，以加速科学审查进程。尽管此举有望缩短审批周期，但也为制药行业带来新的挑战：企业需提前准备应对 AI 生成的审查结论、确保申报材料格式符合 AI 可读性要求，并预判审查动态变化，而这一切均发生在“AI 工具的监管规则与沟通机制尚未明确”的大背景下，进一步叠加了行业合规与运营的不确定性。

敬请访问 BioWorld 关于特朗普政府相关决策的专题报道，以追踪政府决策对制药行业的影响：[单击此处](#)。



创新疗法塑造 2025 年监管格局

2025 年，全球监管环境持续释放积极信号，推动多款突破性疗法成功落地，为患者带来多款创新机制药物，更填补了多个疾病领域的治疗空白。

Insmed 公司的 BRINSUPRI™ (brensocatib) 是全球首款获批用于非囊性纤维化支气管扩张症 (NCFB) 的创新疗法，有望颠覆这类罕见病的治疗范式。针对 H3K27M 突变型弥漫性中线胶质瘤这一超罕见恶性肿瘤（美国每年约 2,000 人患病），Jazz Pharmaceuticals 的 Modeyso™（多达维普酮 dordaviprone）已获 FDA 批准，成为该病首款针对性治疗药物。Stealth Bio Therapeutics 的 FORZINITY™ (elamipretide) 同样斩获 FDA 批准，成为全球首款治疗巴氏综合征 (Barth syndrome) 的药物，为这种全球确诊病例不足 500 例的超罕见进行性遗传病患者带来新希望。

入选《2025 年最值得关注的药物预测》榜单的 QFITLIA™ (fitusiran, Alnylam/赛诺菲)，是首款用于血友病的抗凝血酶降低疗法，适用人群覆盖范围广泛，包括 A 型、B 型血友病患者，且无论患者是否产生抑制均适用。该药物通过预充笔或瓶罐注射器给药，每年仅需注射 6 次即可提供持续出血保护，相较于传统疗法需静脉输注或高频注射的给药方式，大幅提升了治疗便利性与患者依从性。此外，表 2 所列多款药物还具备显著特色，或采用创新给药途径，或成为数十年来首个针对某适应症获批的疗法。

表 2：2025 年在澳大利亚、加拿大、欧盟、日本、中国、英国或美国首次获批的新药，截至 2025 年 10 月 31 日

药物	公司	适应症	类型	国家 / 地区
ANDEMBRY® (garadacimab-gxii)	CSL 公司	遗传性血管性水肿	抗 XIIa 因子 (FXIIa) 单克隆抗体	澳大利亚、欧盟、日本、 英国、美国
AVMAPKI™/FAKZYNJA™ 联合疗法 (avutometinib + defactinib)	Verastem Oncology	低级别浆液性卵巢癌	MEK/RAF 双重抑制 剂 / FAK 抑制剂	美国
倍长平 (考格列汀)	海思科医药	T2DM	二肽基肽酶 -4 (DPP-4) 抑制剂	中国
BLUJEPA (gepotidacin)	葛兰素史克	单纯型尿路感染	三氮杂萘烯 (Triazaacenaphthylene) 口服抗生素	英国、美国
BRINSUPRI(brensocatib)	Insmed	非囊性纤维化支气管 扩张症 (NCFB)	二肽基肽酶 -1 (DPP-1) 抑制剂	欧盟、美国
DAWNZERA™ (donidalorsen)	Ionis Pharmaceuticals	遗传性血管性水肿	RNA 靶向血浆前激肽 释放酶 (PKK) 抑制剂	美国
东卫卓 (磷酸蔡坦司韦)	东阳光药业	丙型肝炎病毒 (HCV) 感染	NS5A 抑制剂	中国
EKTERLY® (sebetralstat)	KalVista Pharmaceuticals	遗传性血管性水肿	PKK 抑制剂	澳大利亚、欧盟、英国、 美国
EMRELIS™ (telisotuzumab vedotin-tllv)	艾伯维	NSCLC	c-Met ADC	美国
ENCELTO™ (revakinagene taroretcel-lwey)	Neurotech Pharmaceuticals Inc	2 型黄斑毛细血管扩张症 (MacTel)	同种异体封装细胞基因疗法	美国
ENFLONSIA™ (clesrovimab-cfor)	默沙东	呼吸道合胞病毒 (RSV) 所致下呼吸道疾病	长效半衰期单克隆抗体	美国
Exdensur (depemokimab)	葛兰素史克	哮喘和慢性鼻窦炎伴 鼻息肉 (CRSwNP)	靶向 IL-5 的单克隆抗体	英国、美国
EZMEKLY®/GOMEKLI® (mirdametinib)	德国默克旗下 SpringWorks Therapeutics	1 型神经性纤维瘤 (NF1)	MEK 抑制剂	欧盟、英国、美国
FORZINITY (elamipretide)	Stealth BioTherapeutics Inc	巴氏综合征	心磷脂稳定剂	美国
HERNEXEOS® (zongertinib)	勃林格殷格翰	NSCLC	HER2 酪氨酸激酶 抑制剂 (TKI)	中国、日本、美国
HYRNUO® (sevabertinib)	拜耳	NSCLC	TKI	美国
IMAAVY™ (nipocalimab)	强生	全身性重症肌无力 (gMG)	抗 FcRn 单克隆抗体	欧盟、美国
INLURIYO™ (imlunestrant)	礼来	乳腺癌	雌激素受体 (ER) 拮抗剂	美国
JASCAYD® (nerandomilast)	勃林格殷格翰	磷酸二酯酶 4B(PDE4B) 抑制剂	特发性肺纤维化 (IPF)	中国、美国
JOURNAVX™(suzetrigine)	Vertex Pharmaceuticals	中重度急性疼痛	选择性 NaV1.8 抑制剂	美国
KEYTRUDA QLEX™/KEYTRUDA SC™ (帕博利珠单抗 + berahyaluronidase alfa-pmph)	默沙东 /Alteogen	Keytruda (可瑞达) 获批 的所有实体瘤适应症	抗 PD-1 单抗, 帕博利珠单 抗皮下注射制剂	欧盟、美国
KOMZIFTI™ (ziftomenib)	Kura Oncology and Kyowa Kirin	急性髓性白血病 (AML)	menin 抑制剂	美国

药物	公司	适应症	类型	国家 / 地区
KYGEVVI® (doxecitine + doxribtimine)	UCB	胸苷激酶 2 缺乏症 (TK2d)	嘧啶核苷	美国
LEROCHOL™ (lerodalcibep-liga)	LIB Therapeutics	高胆固醇血症	PCSK9 抑制剂	美国
LYNKUET® (elinzanetant)	拜耳	更年期中重度血管舒缩症状	神经激肽 1 (NK1) 和神经激肽 3 (NK3) 受体拮抗剂	澳大利亚、加拿大、英国、美国
LYNOZYFIC™ (linvoseltamab-gcpt)	再生元	多发性骨髓瘤	BCMA x CD3 双特异性抗体	欧盟、美国
MAAPLIV	Recordati Rare Diseases	枫糖尿症 (MSUD)	氨基酸	欧盟
美佑恒 (维贝柯妥塔单抗)	乐普生物	鼻咽癌	EGFR ADC	中国
Modeyso(dordaviprone)	Jazz Pharmaceuticals	弥漫性中线胶质瘤	线粒体酪蛋白水解蛋白酶 P (ClpP) 激活剂和多巴胺 D2 受体 (DRD2) 抑制剂	美国
NUZOLVENCE® (zolidfadacin)	Innoviva Specialty Therapeutics (Innoviva 子公司)	泌尿生殖道淋病	螺啉酮三酮类细菌 II 型拓扑异构酶抑制剂	美国
Oczyesa® (奥曲肽)	Camurus	肢端肥大症	生长抑素	欧盟、英国
PALSONIFY™ (paltusotine)	Crinetics Pharmaceuticals	肢端肥大症	生长抑素受体 2 型 (SST2) 非肽类激动剂	美国
QFITLIA (fitusiran)	Alnylam Pharmaceuticals / 赛诺菲	A 型或 B 型血友病	小干扰 RNA(siRNA)	美国
REDEMPLO® (plozasiran)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	家族性乳糜微粒血症综合征 (FCS)	siRNA	美国
Rhapsido® (remibrutinib)	诺华	慢性自发性荨麻疹 (CSU)	BTK 抑制剂	美国
Riulvy® (tegomil fumarate)	Neuraxpharm Pharmaceuticals	多发性硬化症	小分子免疫抑制剂	欧盟
ROMVIMZA™ (vimseltinib)	Deciphera Pharmaceuticals (小野制药全资子公司)	腱鞘巨细胞瘤 (TGCT)	激酶抑制剂	欧盟、美国
SEPHIENCE™ (sepiapterin)	PTC Therapeutics	高苯丙氨酸血症 (HPA)/ 苯丙酮尿症 (PKU)	酶促辅因子 BH4 的前体	澳大利亚、加拿大、欧盟、美国
TRYPTYR® (acoltremon 滴眼液)	爱尔康	干眼症	TRPM8 受体激动剂	美国
VANRAFIA® (阿曲生坦)	诺华	IgAN	内皮素 A (ETA) 受体拮抗剂	中国、美国
VIZZ (aceclidine 滴眼液)	LENZ Therapeutics	老花眼	瞳孔选择性缩瞳剂	美国
VOYXACT (sibeprenlimab)	大冢制药株式会社	IgAN	靶向 APRIL (增殖诱导配体) 的单克隆抗体	美国
WAYRILZ™ (rilzabrutinib)	赛诺菲	免疫性血小板减少症	BTK 抑制剂	美国
新替妥 (斯泰度塔单抗)	泰诺麦博	破伤风	抗破伤风单克隆抗体	中国

数据来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库；各公司官网



制药行业高管需关注的核心战略要务

代谢领域变革：突破机制层面的差异化竞争

在竞争日趋白热化的代谢疾病治疗领域，企业若想基业长青，必须顺应领域变革趋势，跳出“机制复刻”的局限，打造更高层次的差异化竞争优势。仅靠复制现有 GLP-1 类疗法的研发路径已无法满足市场需求，当前行业亟需能解决耐受性痛点的创新方案、便捷的口服给药选择、可维持目标体重的联合治疗策略，以及能与临床试验数据匹配的真实世界疗效证据，以此夯实药物的临床价值与市场竞争力。

礼来制药的 orforglipron 和 retatrutide 等新一代代谢疗法，正是差异化创新的典型范例：orforglipron 的口服剂型可大幅提升患者治疗依从性，精准契合市场对给药便捷性的需求；retatrutide 的三重激素作用机制能实现更卓越的减重效果，其适应症还从传统代谢领域拓展至脑部健康、肾脏疾病等新方向，进一步拓宽了治疗边界。

不过，代谢治疗领域仍面临多重关键挑战，包括医保定价谈判压力、支付方覆盖范围限制、供应链短缺风险，以及减重过程中难以规避的肌肉流失问题。值得关注的是，针对胰淀素 (amylin)、大麻素受体、激活素 (activin) 等靶点的新型作用机制，正为破解上述难题提供全新思路与可行方案，为领域突破注入新动力。

精准医疗与罕见病商业化：构建患者导向的全新模式

精准医疗与罕见病的商业化，需构建与传统医药领域全然不同的运营体系。其成功核心在于将“患者优先”理念深度植入研发与商业化全流程，既要高度聚焦患者早筛识别、早期用药可及性等核心痛点，更要通过疾病认知普及项目、患者组织深度合作、关键意见领袖 (KOL) 联动赋能等多元举措，提升市场培育能力。

与此同时，精准肿瘤学与免疫学的持续演进，正推动靶向治疗机制向更精细化方向发展。例如，乳腺癌治疗药物 gedatolisib、嗜酸性粒细胞疾病治疗药物 depemokimab、血液恶性肿瘤治疗药物 mezigdomide，以及能攻克传统“不可成药”靶点的靶向蛋白降解剂等疗法，均标志着难治性疾病的治疗模式正在发生革命性转变。

而面对极其稀缺的患者群体（部分疾病患病率低至 200 万分之一），企业必须彻底摒弃传统规模化商业化路径，针对性构建以患者为核心的专属运营模式，才能适配小众市场的独特需求。

应对监管复杂性与政治阻力：强化信息洞察，筑牢战略弹性

2026 年制药行业将面临前所未有的监管不确定性，其中美国市场的挑战尤为突出。特朗普政府任命的 FDA 领导层主导下的监管导向、《通胀削减法案》(IRA) 持续释放的定价压力，以及全球各国卫生技术评估 (HTA) 要求的频繁调整，共同构成了多层次的战略挑战。2024 年联邦医疗保险 (Medicare) Part D 首轮谈判已树立关键先例，抗凝血药物拜瑞妥（利伐沙班）降价幅度高达 60%，这一结果从根本上重塑了行业对医保定价的预期。

企业管理者需在“加速研发周期”与“生成严谨临床证据”之间精准平衡，既要预判不同地区的监管差异并提前布局，更要为全球上市策略预留充足战略弹性。值得关注的是，FDA 已在全机构范围内部署生成式 AI 工具以加速科学审查，这一举措既为缩短审批周期带来新机遇，也暗藏合规与适配挑战：药企需提前筹备应对 AI 生成的审查结论、确保申报材料格式符合 AI 可读性要求，同时还要直面“AI 工具的监管规则与沟通机制尚未明确”的不确定性。

聚焦中国市场：把握从“制造中心”到“创新高地”的转型机遇

中国大陆已成为全球制药行业不可或缺的战略核心市场，其产业角色正实现从“全球医药制造中心”向“本土创新高地”的关键转型。

2026 年中国市场最具增长潜力的 6 款核心药物中，4 款源自本土创新企业，部分产品已具备与跨国药企龙头产品同台竞技的实力，彰显本土创新力量的快速崛起。从市场基本面看，中国大陆超重或肥胖人群规模已达 6.9 亿，癌症发病率持续攀升，催生了庞大且持续增长的治疗需求；与此同时，企业需制定精细化市场策略以应对本土竞争与政策挑战，具体包括：直面国家医保药品目录 (NRDL) 准入谈判的降价挑战、设计具备竞争力的差异化定价方案，以及与本土创新企业构建优势互补的合作联盟。

术语缩写

ADC ：抗体药物偶联物
AE ：不良事件
AHI ：呼吸暂停低通气指数
AI ：人工智能
AML ：急性髓性白血病
AR ：雄激素受体
ARB ：血管紧张素 II 受体拮抗剂
ARNI ：血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂
ARR ：年复发率
ATMP ：先进治疗药品
AUTOTAC ：自噬靶向嵌合体
BCG ：卡介苗
BLA ：生物制品许可申请
BTK ：布鲁顿酪氨酸激酶
CB1 ：大麻素受体 1
CDAC ：嵌合式降解激活化合物
CDK ：细胞周期蛋白依赖性激酶
CDP ：确认残疾进展
CELMoD ：cereblon E3 泛素连接酶调节剂
CERAN ：完全雌激素受体拮抗剂
CHMP ：欧洲药品管理局人用药品委员会
ClpP ：酪蛋白水解蛋白酶 P
CIS ：原位癌
CKD ：慢性肾病
CLL ：慢性淋巴细胞白血病
CNPV ：局长国家优先审评券
CNS ：中枢神经系统
CR ：完全缓解
CRSwNP ：慢性鼻窦炎伴鼻息肉
CSU ：慢性自发性荨麻疹
CVD ：心血管疾病
DAC ：降解剂 - 抗体偶联物
DOR ：缓解持续时间
DPP ：二肽基肽酶
DRD2 ：多巴胺 D2 受体
EC ：欧盟委员会

EFS ：无事件生存期
eGFR ：估算肾小球滤过率
EGPA ：嗜酸性肉芽肿性多血管炎
EMA ：欧洲药品管理局
EPIC ：确保创新疗法路径法案
ER ：雌激素受体
ESKD ：终末期肾病
ETA ：内皮素 A
FCS ：家族性乳糜微粒血症综合征
FDA ：美国食品药品监督管理局
FL ：滤泡性淋巴瘤
Gd-IgA1 ：半乳糖基缺陷 IgA1
GIP ：葡萄糖依赖性促胰岛素多肽
GLP ：胰高血糖素样肽
gMG ：全身性重症肌无力
GR ：糖皮质激素受体
HCV ：丙型肝炎病毒
HER2 ：人表皮生长因子受体 2
HF ：心力衰竭
hf-PGA ：手足部位医师整体评估
HFrEF ：射血分数降低型心力衰竭
HHS ：美国卫生与公众服务部
HPA ：高苯丙氨酸血症
HR ：激素受体
HR-NMIBC ：高危非肌层浸润性膀胱癌
HR-QOL ：健康相关生活质量
HTA ：卫生技术评估
IGA ：研究者整体评分
IgAN ：免疫球蛋白 A 肾病
IL ：白细胞介素
IMiD ：免疫调节药物
IND ：新药临床试验申请
IP ：知识产权
IPF ：特发性肺纤维化
IRA ：通胀削减法案
KDIGO ：改善全球肾脏病预后组织

KOL ：意见领袖	PFS ：无进展生存期
LYTAC ：溶酶体靶向嵌合体	PI3K ：磷脂酰肌醇 3- 激酶
MAA ：上市许可申请	PKK ：血浆前激肽释放酶
MACE ：主要不良心血管事件	PKU ：苯丙酮尿症
MAD ：最大给药剂量	pOR ：病理总缓解
MAHA ：让美国再次健康	PRIME ：优先审评药物
MASH ：代谢功能障碍相关脂肪性肝炎	PROTAC ：蛋白水解靶向嵌合体
MCL ：套细胞淋巴瘤	R&D ：研究与开发
MCP ：模型上下文协议	RA ：受体激动剂
mCRPC ：转移性去势抵抗性前列腺癌	RSV ：呼吸道合胞病毒
MFN ：最惠国待遇	RTOR ：实时肿瘤学审评
MFP ：最高公平价格	SAE ：严重不良事件
MGD ：分子胶降解剂	SC ：皮下注射
MIBC ：肌层浸润性膀胱癌	SERD ：选择性雌激素受体降解剂
MSUD ：枫糖尿症	SERM ：选择性雌激素受体调节剂
MTD ：最大耐受剂量	SGLT ：钠 - 葡萄糖共转运蛋白
mTOR ：哺乳动物雷帕霉素靶蛋白	SGRA ：选择性糖皮质激素受体拮抗剂
NAFLD ：非酒精性脂肪性肝病	SGRQ ：圣乔治呼吸问卷
NCFB ：非囊性纤维化支气管扩张症	siRNA ：小干扰 RNA
NDA ：新药上市申请	SLL ：小淋巴细胞淋巴瘤
NF1 ：1 型神经性纤维瘤	sNDA ：补充新药申请
NHL ：非霍奇金淋巴瘤	SOC ：标准治疗方案
NIH ：美国国立卫生研究院	sPGA-G ：生殖器静态医师整体评估
NK ：神经激肽	ss-IGA ：头皮特异性研究者整体评估
NMPA ：中国国家药品监督管理局	SST2 ：生长抑素受体 2 型
NRDL ：中国国家医保药品目录	STAT-3 ：信号转导和转录激活因子 3
NSCLC ：非小细胞肺癌	T2DM ：2 型糖尿病
OA ：骨关节炎	TEAE ：治疗相关不良事件
oHCM ：梗阻性肥厚型心肌病	TGCT ：腱鞘巨细胞瘤
ORR ：客观缓解率	TKI ：酪氨酸激酶抑制剂
OS ：总生存期	TNF ：肿瘤坏死因子
OSA ：阻塞性睡眠呼吸暂停	TYK2 ：酪氨酸激酶 2
PAP ：气道正压通气	UPCR ：尿蛋白 / 肌酐比值
PASI ：银屑病面积和严重程度指数	VHL ：希佩尔 - 林道综合征
pCR ：病理完全缓解	VRS ：鼻塞言语反应量表
PD-1 ：程序性死亡受体 1	WHO ：世界卫生组织
PDE4B ：磷酸二酯酶 4B	WM ：华氏巨球蛋白血症
PDUFA ：处方药使用者付费法案	WOMAC ：西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数

参考文献

康方生物 (2024 年 5 月 31 日)。基于 HARMONi-A 临床试验结果, 依沃西单抗联合化疗已获中国国家药品监督管理局批准用于二线及以上 EGFR 突变型 NSCLC 治疗: 依沃西单抗联合化疗的总生存期数据呈现积极趋势 [在线]。康方生物。访问链接: <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/240531/> (访问时间: 2025 年 10 月 31 日)。

康方生物 (2025 年 4 月 26 日)。基于具有突破性的头对头 III 期临床试验结果, 依沃西单抗获中国国家药品监督管理局批准用于 PD-L1 阳性 NSCLC 一线治疗, 试验结果显示其疗效优于帕博利珠单抗 [在线]。康方生物。访问链接: <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/250426/> (访问时间: 2025 年 10 月 31 日)。

康方生物 (2025 年 7 月 28 日)。中国国家药品监督管理局已受理依沃西单抗联合化疗用于晚期鳞状非小细胞肺癌一线治疗的补充新药申请 (sNDA) [在线]。康方生物。访问链接: <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/250728/> (访问时间: 2025 年 10 月 31 日)。

Allemani, C. 等 (2018)。“2000-2014 年全球癌症生存趋势监测 (CONCORD-3): 基于 71 个国家和地区 322 个基于人群的癌症登记系统中 18 种癌症 37,513,025 例确诊患者个体记录的分析”,《柳叶刀》, 391(10125), 第 1023-1075 页。

Allemani, C. 等 (2025)。“2015-2018 年乳腺癌、宫颈癌和卵巢癌诊疗模式与初始治疗时间的全球差异 (VENUSCANCER 研究): 基于 39 个国家和地区 103 个基于人群的癌症登记系统中 275,792 名女性个体记录的二次分析”,《柳叶刀》。https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01383-2/fulltext

美国糖尿病协会。(2025 年 6 月 23 日)。新型 GLP-1 疗法通过改善肌肉保留, 提升减重质量 [在线]。美国糖尿病协会。访问链接: <https://diabetes.org/newsroom/press-releases/new-glpi-therapies-enhance-quality-weight-loss-improvi> (访问时间: 2025 年 8 月 17 日)。

Ark, J.T. 等 (2017)。“血尿患者诊断评估的差异: 性别、种族及膀胱癌风险因素的影响”,《泌尿学杂志》, 198, 第 1033-1038 页。

Aronne, L.J. 等 (2024)。“持续使用替尔泊肽维持成年肥胖患者的减重效果: SURMOUNT-4 随机临床试验”, JAMA, 331(1), 第 38-48 页。doi:10.1001/jama.2023.24945

BioWorld。(2024 年 12 月 10 日)。ATC-324 靶向前列腺癌 AR 突变体及剪接变体 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/715244-atc-324-targets-prostate-cancer-ar-mutants-and-splice-variants> (访问时间: 2025 年 8 月 15 日)。

BioWorld。(2025a)。候审药物: FDA 审批日期 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/content/PDUFA-dates> (访问时间: 2025 年 8 月 15 日)。

BioWorld。(2025b)。海思科专利披露新型 SMARCA2 降解诱导剂 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/721426-haisco-pharmaceutical-patent-describes-new-smarca2-degradation-inducers> (访问时间: 2025 年 8 月 15 日)。

BioWorld。(2025 年 2 月 13 日)。Lycia Therapeutics 推进蛋白降解疗法研发 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/717243-lycia-therapeutics-advances-protein-degradation-therapies> (访问时间: 2025 年 8 月 15 日)。

BioWorld。(2025d)。密歇根大学公布新型 STAT3 降解诱导剂 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/716530-university-of-michigan-divulges-new-stat3-degradation-inducers> (访问时间: 2025 年 8 月 15 日)。

Boggs, J. (2025 年 4 月 14 日)。辉瑞在肥胖症治疗领域的失利为竞争对手带来机遇 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/719197-pfizers-loss-offers-boost-to-competitors-in-obesity-space> (访问时间: 2025 年 8 月 17 日)。

Boggs, J. (2025 年 9 月 30 日)。辉瑞签署首份特朗普“最惠国待遇” (MFN) 定价协议 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/724763-pfizer-inks-first-pricing-deal-under-trump-mfn-plan> (访问时间: 2025 年 10 月 30 日)。

Carey, K. (2023 年 10 月 2 日)。面对高昂的社会成本与快速增长的市场规模, 研发企业正在寻求将减肥药物纳入医保报销 [在线]。BioWorld。访问链接: <https://www.bioworld.com/articles/701979-with-high-societal-costs-a-burgeoning-market-size-developers-seek-reimbursement-for-weight-loss-meds> (访问时间: 2025 年 8 月 17 日)。

Chen, K. 等 (2023)。“中国肥胖症及相关并发症的患病率: 针对 1580 万成年人的横断面真实世界研究”, Diabetes Obes Metab, 5(11), 第 3390-3399 页。doi:10.1111/dom.15238

Clayton, J.A., Collins, F.S.(2014)。“政策: 美国国立卫生研究院将在细胞与动物研究中平衡性别因素”,《自然》, 509, 第 282-283 页。doi:10.1038/509282a

美国国会官网 (Congress.gov)。(2025 年 7 月 4 日)。第 119-21 号公共法案——2025 年 7 月 4 日 [在线]。美国国会官网 (Congress.gov)。访问链接: <https://www.congress.gov/119/plaws/publ21/PLAW-119publ21.pdf> (访问时间: 2025 年 9 月 4 日)。

Doshi, B. 等 (2023)。“膀胱癌性别差异背后的生物学差异: 现状综述与未来方向”, Oncogenesis, 12(44)。doi:10.1038/s41389-023-00489-9

EMA。(2025 年 1 月 10 日)。欧盟卫生技术评估新规正式生效 [在线]。欧洲药品管理局。访问链接: <https://www.ema.europa.eu/en/news/new-eu-rules-health-technology-assessments-become-effective> (访问时间: 2025 年 9 月 2 日)。

EMA。(2025b)。欧盟孤儿药 [在线]。欧洲药品管理局。访问链接: https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/infographic-orphan-medicines-eu_en.pdf (访问时间: 2025 年 8 月 19 日)。

EURORDIS。(无日期)。何为罕见病? [在线]。EURORDIS。访问链接: <https://www.eurordis.org/information-support/what-is-a-rare-disease/> (访问时间: 2025 年 9 月 2 日)。

Fair Health。(2025 年 5 月 27 日)。肥胖症与 GLP-1 类药物: 基于报销申请数据的分析 [在线]。Fair Health。访问链接: <https://s3.amazonaws.com/media2.fairhealth.org/whitepaper/asset/Obesity%20and%20GLP-1%20Drugs%20-%20A%20FAIR%20Health%20White%20Paper.pdf> (访问时间: 2025 年 8 月 17 日)。

- FDA. (2025 年 5 月 29 日)。美国生物制品评估与研究中心 (CBER) 罕见病项目 [在线]。美国食品药品监督管理局。访问链接：<https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cber-rare-disease-program> (访问时间：2025 年 9 月 3 日)。
- Floege, J. 等 (2025)。“KDIGO 2025 年免疫球蛋白 A 肾病 (IgAN)
- 与免疫球蛋白 A 血管炎 (IgAV) 管理临床实践指南”，Kidney International, 108(45), S1-S71 页。<https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/08/KDIGO-2025-IgAN-IgAV-Guideline.pdf>
- Garg, T. 等 (2014)。“血尿评估与膀胱癌诊断中的性别差异：一项基于人群的分析”，《泌尿学杂志》，192, 第 1072-1077 页。
- Gasoyan, H. 等 (2025)。“根据停药状态分析司美格鲁肽或替尔泊肽用于肥胖治疗后，体重与血糖控制的变化”，Obesity. doi:10.1002/oby.24331
- Han, B. 等 (2024)。“2022 年中国癌症发病率和死亡率”，《癌症科学进展》，4(1), 第 47-53 页。doi:10.1016/j.jncc.2024.01.006
- Kedrion Biopharma (2025 年 8 月 7 日)。FDA 授予用于先天性无铜蓝蛋白血症的在研血浆源性疗法孤儿药资格认定 [在线]。Kedron Biopharma。访问链接：<https://www.kedrion.com/fda-grants-orphan-drug-designation-to-investigational-plasma-derived-treatment-for-congenital-aceruloplasminemia/> (访问时间：2025 年 9 月 4 日)。
- Li, J. 等 (2022)。“肥胖症在中国的流行：流行病学、负担、挑战和机遇”，《中华医学杂志》(英文版)，135(11), 第 1328-1330 页。doi:10.1097/CM9.00000000000002189
- McIntosh, S.A. 等 (2023)。“2016-2020 年全球癌症研究资金：公共与慈善投资的内容分析”，《柳叶刀·肿瘤学》，24(6), 第 636-645 页。
- Memel, Z. 等 (2025)。“GLP-1 受体激动剂疗法对肌肉减少症高风险患者的影响”，Current Nutrition Reports, 14(1), 第 63 页。doi:10.1007/s13668-025-00649-w
- Miyajima, H. (2015)。“无铜蓝蛋白血症”，Neuropathology, 35(1), 第 83-90 页。<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/neup.12149>
- Moran, N. (2025 年 3 月 3 日)。艾伯维为 Gubra 公司的胰淀素类肥胖症治疗药物付出 22 亿美元 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/717825-abbvie-enters-22b-deal-for-gubras-amylin-obesity-drug> (访问时间：2025 年 8 月 17 日)。
- 摩根士丹利。 (2025 年 5 月 09 日)。肥胖症治疗药物呈指数级增长 [在线]。摩根士丹利。访问链接：<https://www.morganstanley.com/insights/articles/weight-loss-medication-market-unstoppable-growth> (访问时间：2025 年 8 月 17 日)。
- Mullard, A. (2019 年 3 月 6 日)。首款靶向蛋白降解剂进入临床阶段 [在线]。《自然综述：药物发现》。访问链接：<https://www.nature.com/articles/d41573-019-00043-6> (访问时间：2025 年 4 月 21 日)。
- 美国国家罕见疾病组织 (NORD)。 (2025)。罕见病事实与统计数据 [在线]。美国国家罕见疾病组织 (NORD)。访问链接：<https://rarediseases.org/understanding-rare-disease/rare-disease-facts-and-statistics/> (访问时间：2025 年 8 月 19 日)。
- Osborne, R. (2024 年 4 月 11 日)。Arvinas 公司 PROTAC 战略布局：与诺华达成超 10 亿美元的前列腺治疗领域合作 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/707549-arvinas-protac-pro-tack-1b-plus-novartis-deal-in-prostate> (访问时间：2025 年 4 月 15 日)。
- Osborne, R. (2024 年 9 月 23 日)。后续进展：Skye 与 Corbus 修复诺和诺德 CB1 减重数据 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/712714-recovery-room-skye-corbus-mend-post-novo-cb1-weight-loss-data> (访问时间：2025 年 8 月 17 日)。
- Osborne, R. (2024 年 10 月 28 日)。Monte Rosa 与诺华就 VAV1 达成合作，签署 21 亿美元协议 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/713941-monte-rosa-novartis-have-one-in-vav1-sign-21b-pact> (访问时间：2025 年 4 月 14 日)。
- Reinke, M., Fleseriu, M. (2023)。“库欣综合征：综述”，JAMA, 330(2), 第 170-181 页。doi:10.1001/jama.2023.11305
- Serebrov, M. (2025 年 7 月 31 日)。制药企业被要求采纳最惠国待遇 (MFN) 定价，否则将面临后果 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/722739-adopt-mfn-pricing-or-else-drug-companies-told> (访问时间：2025 年 8 月 18 日)。
- Serebrov, M. (2023 年 8 月 6 日)。美国卫生与公众服务部 (HHS) 取消 22 份 BARDA mRNA 疫苗合同 [在线]。BioWorld。访问链接：<https://www.bioworld.com/articles/722809-us-hhs-cancels-22-barda-mrna-vaccine-contracts> (访问时间：2025 年 8 月 18 日)。
- 中国生物制药有限公司 (2024 年 8 月 1 日)。贝莫苏单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊用于晚期肾细胞癌一线治疗的新适应症上市申请获受理 [在线]。中国生物制药有限公司。访问链接：<https://www.sinobiopharm.com/userfiles/files/E24071877-Sino%20Bio%20PA.pdf> (访问时间：2025 年 10 月 31 日)。
- Smith, K. (2023 年 5 月 3 日)。女性健康研究资金不足——图表揭示现状 [在线]。《自然》。访问链接：www.nature.com/immersive/d41586-023-01475-2/index.html (访问时间：2025 年 9 月 23 日)。
- Spencer, R.J. 等 (2019)。“基于资金投入与致死率比值评分的妇科癌症研究资金分配差异”，Gynecol Oncol, 152(1), 第 106-111 页。doi:10.1016/j.ygyno.2018.10.021
- Sung, H. 等 (2021)。“2020 年全球癌症统计：GLOBOCAN 对 185 个国家和地区 36 种癌症的发病率与死亡率估算”，CA Cancer J Clin, 71, 第 209-249 页。
- Temkin, S.M. 等 (2023)。“女性慢性病：美国国立卫生研究院的框架制定”，BMC Women's Health, 23(162)。doi:10.1186/s12905-023-02319-x
- Wharton, S. 等 (2023)。“每日口服 GLP-1 受体激动剂 orforglipton 用于成人肥胖症治疗”，《新英格兰医学杂志》，389(10), 第 877-888 页。doi: 10.1056/NEJMoa2302392
- 世界卫生组织。 (2022)。全球癌症观测站 [在线]。国际癌症研究机构。访问链接：<https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf> (访问时间：2025 年 10 月 30 日)。
- 世界卫生组织。 (2025 年 5 月 07 日)。肥胖症和超重 [在线]。世界卫生组织。访问链接：<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (访问时间：2025 年 8 月 17 日)。
- 世界肥胖症。 (2025 年 3 月)。2025 年世界肥胖症地图 [在线]。世界肥胖症。访问链接：<https://data.worldobesity.org/publications/world-obesity-atlas-2025-v7.pdf> (访问时间：2025 年 8 月 17 日)。

关于科睿唯安

科睿唯安是全球领先的变革性资讯提供商。我们提供丰富的数据、洞见、工作流解决方案和专业服务，涵盖学术研究和政府机构，知识产权、生命科学与健康各个领域。如需了解更多信息，请访问 www.clarivate.com.cn。

如需查看《最值得关注的药物预测》的各期内容和全年分析数据，请访问[最值得关注的药物预测网页](#)并在微信公众号上关注：科睿唯安生命科学与制药。

在全球医疗健康领域谋求发展变得越来越困难，探索、开发和商业化改变患者生活的成功治疗方法是一项艰巨的挑战。[了解科睿唯安如何在产品整个生命周期内为专家提供帮助以及传递互联数据和解决方案。](#)

科睿唯安 中国办公室

北京海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座北楼 610 单元

邮编：100190

电话：+86-10 57601200

传真：+86-10 82862088

技术支持电话：4008424896

技术支持邮箱：lsh.support@clarivate.com

网站：clarivate.com.cn